范学文　徐长卿　编

（附：桂林古本《伤寒杂病论》）

范中林六经辨证医案选

奉伤寒金匮宗圣人之典
创火神一派施姜附之法

学苑出版社

范学文　徐长卿　编

（附：桂林古本《伤寒杂病论》）

范中林六经辨证医案选

奉伤寒金匮宗圣人之典
创火神一派施姜附之法

学苑出版社

范中林六经辨证医案

范中林

范中林六经辨证医案

1、太阳证发热(长期低热)
郭××，女，24岁。北京某医院医务人员。
[病史]
近三年来，常间歇性低热。1976年3月，感冒发烧，曾服用感冒冲剂、四环素等药。其后经常自觉畏寒发热，常患扁桃体炎和关节痛。腋温，一般在37．4～38℃，偶尔在38℃以上。曾查血沉25毫米／小时，其它如白血球和基础代谢均正常。注射卡那霉素后，热暂退，但始终呈间歇性发作。自1978年初以后，每日皆发热两次，体温在37．5℃上下。虽经治疗，未愈。1979年3月来诊，按太阳伤寒证发热论治，两诊热退。
[初诊]
3月1日。今晨自觉畏寒发热，测体温37．4℃ ，畏寒发热、身无汗，两膝关节疼痛，面色正常，唇淡红，舌质淡红而润、微紫暗，苔黄挟白较腻，脉浮紧。此为太阳伤寒表实证，法宜开腠发汗、安中攘外，以麻黄汤主之。
处方:
麻黄10克 桂枝6克 甘草18克 杏仁15克 二剂
[辨证]
《伤寒论》云：“ 太阳病， 头痛发热，身疼腰痛，骨节疼痛，恶风，无汗而喘者，麻黄汤主之。 ”此为太阳伤寒之主证。柯韵伯曾指出：“ 麻黄八证……重在发热身疼，无汗而喘 ”。本例患者未致肺气郁闭，故无喘证，其余麻黄汤之主证皆备。舌质淡红润，苔白，为有寒象，这种舌质，再加淡黄色苔，参之舌微现紫暗，为陈寒郁滞已久之征。脉浮，病在表，紧则为寒。寒邪外束，身之阳气不得宣散，故令发热。此非阳明实热，故虽发热而不甚，虽间歇性发热而非潮热可比。寒主闭藏，使皮毛闭，故身无汗。营卫阻滞，失正常之卫外机

能，故畏寒。寒邪郁于经脉之间，阳气不舒，故令骨节疼痛。
此病之初，原为外感风寒之邪，虽迁延三载，但始终缠绵未解，并未传经。转来初诊时，病仍属太阳伤寒表实，麻黄证具，故不拘其日，仍当发其汗。
[二诊]
3月3日。服药后，身觉微汗出，恶寒减，舌紫暗渐退，苔白滑根部微黄，脉细微缓。尚有轻微发热，病仍在太阳。服麻黄汤后，发热恶寒皆减，但现身汗出，脉微缓，营卫失和之象。法宜通阳解表，调和营卫，以桂枝汤加味主之。
处方：
桂枝10克 白芍1O克 炙甘草6克 生姜6克 大枣10枚 白薇12克 三剂
[三诊]
3月8日。上方服三剂后热退。两日来未再低热．试体温36．7。c。膝关节偶尔有短瞬疼痛，微觉头昏，梦多，此外身无明显不适，舌脉均转正常。再少进调和营卫之剂，巩固疗效，并嘱其注意饮食起居，避免病情反复。
7月17日随访，患者说：自第二诊服药后低热退，至今未再复发，自觉一直良好。
[按语]
从祖国医学看，发热的原因，可归纳为外感和内伤两类。在外感热病即伤寒病中，发热为主要见证之一。如太阳病多恶寒发热；阳明病多蒸蒸发热或潮热；少阳病为往来寒热；少阴病发热则有寒化热化之别，还有兼证及阳气渐复发热之异；厥阴病发热主要表现在阴阳胜复过程中，有正胜于邪及阳复太过发热等不同；唯太阴为至阴，所谓“两阴相合，无热可发”。上述诸发热证，虽性质各不相同，并且不论高热低热，均有一定规律性，皆可按六经辨证施治。
本例患者间歇性低热反复发作，已三年之久，但未传经。这样长的时间，始终属太阳表证，似乎不好理解。实际上，后世《伤寒论》注家，对此已有阐发，认为太阳病传变与否，应凭脉证，计日传经之

说，不可拘泥。不过，此证虽未犯他经，却在太阳经内变化；所谓表虚表实．常可相互转化。因此，关键在于严格掌握六经及其传变规律。本例辨证准确，抓住太阳病恶寒发热这一基本特征，灵活使用麻黄汤和桂枝汤，先后有别，分寸恰当，故使三年缠绵之疾，数日内迎刃而解。

2、太阳证偏头痛(三叉神经痛)

邢××，女，67岁。河北省任丘县马家坞乡，农民。

[病史]

1975年春节，左面部疼痛， 其后逐渐转为剧痛，阵阵发作，持续三年之久。任丘××医院，北京××医院等诊断为“ 三叉神经痛 ”。经针灸、中西药物治疗，未明显好转。1978年12月18日来诊，按太阳证偏头痛论治，两诊而愈。

[初诊]

12月18日。近日来疼痛加剧，痛甚时脸肿发亮，眼不能睁，夜不能眠，坐卧不宁，生活无法自理。微恶寒，无汗，舌质淡红，苔淡黄润夹白，根稍厚腻。此为太阳伤寒表实证偏头痛，风寒挟湿侵袭，无从达泄，法宜解表开闭，散寒除湿，以麻黄汤加味主之。

处方：

麻黄10克 桂枝10克 炙甘草18克 杏仁18克 法夏15克 二剂

[辨证]

此证头面左侧剧痛，病属偏头痛。 头居人之首，位高而属阳。手足三阳经脉，以及脏腑清阳之气，皆会于此。舌质淡红而润，苔淡黄夹白不燥，即为风寒夹湿，入侵肌腠，郁闭不解之象；参之头一侧痛甚，微恶寒无汗，显系邪犯太阳经脉；再参之无阳明、少阳病情，更无三阴之候，亦可以佐证。因此，本例偏头痛，不必拘于头痛偏侧多属少阳，或头痛日久，多属内伤之常规。而应从实际出发，按六经辨证，太阳伤寒表实之证具，邪无达泄之路而上扰，以致多年头痛不愈，急用麻黄汤以开之。

[二诊]

服药二剂，疼痛明显减轻，余证亦随之好转。原方再服二剂。
[三诊]
剧痛消失，夜能安睡， 精神顿觉清爽，多年痛楚若失，不胜欣喜。舌质正常，苔黄腻退。头部微觉恶风，头左侧尚有轻微阵痛。风邪未尽，尚有病后营卫不和之象。宜祛风解肌，桂枝汤和之，以善其后。
处方：
桂枝10克 白芍12克 炙甘草10克 生姜15克 大枣20克 二剂
服二剂，病愈，遂停药。嘱其免受风寒。观察约一月，情况良好。患者说：“ 头痛三年，真是痛苦极了，花了二、三百元，还是不好。范老看了三次，每付药只四、五味，一共只花了一元零一分钱，病就治好了，真使我感动。 ” 遂返回家乡。其后，向其亲属追访，知病未复发。
[按语]
“ 三叉神经痛 ” ，目前病因还不十分清楚。老年人患此病尤多，可能与神经传导功能障碍有关。西医治疗，多采用镇痛剂、酒精封闭等法，无效时则考虑开颅行三叉神经根切手术。这样虽能解除剧痛之苦，但术后面部易出现后遗症，且不易为患者所接受。
祖国医学认为，举凡风寒暑湿等外邪，气血痰郁之内伤，均可以引起头痛。本例按仲景六经辨证，应属太阳经证，伤于风寒雾露所致。故急投开表、逐邪、发汗之峻剂麻黄汤，直达病所；继而以桂枝汤和之。用 麻黄汤加法夏者，“ 其用有四： 除湿化痰涎，大和脾胃气，痰厥及头疼，非此莫能治 ” 。

3、太阳证眩晕(美尼尔氏综合症)
罗××，女，34岁。成都市某场工人。
[病史]
1976年5月，突感眩晕，如坐舟中，卧床不起。成都市××医院内科确诊为 “ 美尼尔氏综合症 ” 。数日后转来求诊。
[初诊]
四天前，下班回家，自觉头胀痛，眩晕甚，颇欲吐。次日上班，到厂

后片刻即晕倒。呕吐频繁，吐出大量清涎，头晕似天旋地转。恶寒、咳嗽、无汗。舌质偏淡，苔微黄。此太阳证，寒邪闭阻，水饮内停而致眩晕。法宜先从温化寒饮，祛痰降逆入手，以半夏干姜散加味主之。

处方：

法夏18克 干姜18克 云苓30克 甘草3克

[二诊]

干呕消失，头胀痛、眩晕减轻。 再宜表里同治，散外寒，涤内饮，以小青龙汤加减主之。

处方：

麻黄10克 法夏15克 干姜10克 甘草15克 二剂

[三诊]

头晕、咳嗽进一步好转，痰涎减。 表邪未尽，阳气尚虚，继以麻黄细辛附子汤，助阳解表。

处方：

麻黄10克 制附片60克(久煎) 辽细辛6克 桂枝10克 干姜60克 甘草30克 四剂

服药后，自己单独乘公共汽车前来诊病，尚有头晕胀之感，舌淡红，苔薄白微黄。又少进散寒除湿，安中攘外之品，数日后病愈。1979年10月26日追访，三年来坚持上班，病未复发。

[按语]

《金匮要略》云：“ 干呕、吐逆、 吐涎沫，半夏干姜散主之 ”。故首用此温中止呕之法。 重加茯苓，取其健脾利水渗湿，既能扶正，又可祛邪，且为治痰主药。 服药两剂，病情好转。次用小青龙汤与麻黄细辛附子汤，取其善涤内饮，助阳驱邪之功。

4、太阳证咳嗽(支气管扩张)

常××，女，22岁。中国人民解放军某部学员。

[病史]

患者五岁出麻疹时，曾合并肺炎。其后常吐浓痰，并转为咳血。1970

年，经北京几家医院会诊，诊断为“支气管扩张”。先后在北京、上海、山西等地治疗，咳血基本控制，但经常头痛，时发高烧。医院多次建议手术治疗，患者家属未接受。病情逐渐加重，终于不能坚持学习，从某军医学校休学。1978年5月2日来诊，按太阳证温病论治，两月余基本治愈。

[初诊]

头昏头痛，身热而不恶寒；手心灼热，汗出，心烦，渴喜凉饮。咳嗽，频频吐大量浓黄稠痰，便秘，睡眠不安。面红亮，双颧有明显黑斑，唇绛红，舌质鲜红，苔黄厚腻而紧密，脉洪数。此系温病伏邪为外感所触发，并上犯肺经所致。法宜宣肺泄热，降逆止咳。以麻杏石甘汤加味主之。

处方：

麻黄10克 杏仁24克 石膏60克 甘草18克 葶苈子10克 川贝15克

[辨证]

《伤寒论》云：“太阳病， 发热而渴，不恶寒者，为温病”。仲景在此提出不恶寒而渴，与恶寒而不渴，作为辨别温病与伤寒之标志。本例患者，虽身热头痛与伤寒相似，但不恶寒而渴，故当属温病。因伤寒传变化热，必传经而后渴；温邪不待传变，虽病在表而热邪伤津，故渴。同时伤寒为寒邪，故身发热而恶寒；温病为阳邪，故发热而不恶寒。此例温病，邪热壅肺，病根已深，肺失宣降，故咳甚，吐浓痰；蕴热日久，必伤血络而致咳血。参之舌象，舌质鲜红，苔黄厚腻而紧密，亦与上述印证相符；而两颧属肺，湿积于肺，日久不得宣化，内聚成痰，外现于面，故形成两颧黑斑也。据此，立法处方，服药十剂，咳嗽与浓痰减，手心灼热，头痛心烦，睡眠不宁等均有好转，面红亮亦稍退。

[二诊]

痰、咳、烦、热等虽有好转， 但舌质仍鲜红，苔黄少津，便秘，时有发热，此郁热虽衰而津液未复。宜守原法，兼顾生津润燥以养阴。以麻杏石甘汤合竹叶石膏汤加减主之。

处方：
麻黄10克 杏仁18克 石膏60克 竹叶10克 麦冬12克 甘草3克 桑皮15克 川贝15克 黄芩10克 知母12克 荷叶12克 三剂
服三剂后，发热、便秘、头昏、咳吐浓痰等显著好转。原方损益又服十剂。
[三诊]
舌质红、苔白润，偶尔尚吐稠痰。上述诸证悉减，两颧黑斑基本消退，病已显著好转。为祛多年余邪，宜养阴清肺，以善其后。自拟养阴清肺汤主之。
处方：
桑皮12克 杏仁12克 川贝10克 橘红10克 麦冬12克 白芍12克 银花10克 连翘10克 甘草3克
1979年2月25日追访患者，其家长告之， 患者已于1978年秋复学，情况一直很好。

5、太阳证咳嗽
晏××，女，66岁。四川郫县某乡，农民。
[病史]
体质素虚，有咳嗽病史。1970年8月中旬遇风雨后，突然高烧剧咳，头痛胸痛，气紧，吐黄稠痰。急送××医院，测体温39．5℃，经胸透、验血，诊为“急性肺炎”。注射青、链霉素等，高热虽退，但咳嗽、气紧等证仍较重。同年9月初， 由子女抬至成都就诊。
[诊治]
咳嗽不休，神疲面肿， 气逆不能平卧，喉间痰鸣如水鸡声，痰壅盛，色黄。自觉胸腹微热，间有寒战。舌尖边红，苔微黄腻。此为风寒外邪侵犯肺卫，气机阻滞，肺失清肃，兼有郁热，邪聚于胸膈。证属太阳伤寒咳嗽，法宜宣肺降逆，止咳祛痰，以射干麻黄汤加减主之。
处方：
射干12克 麻黄12克 辽细辛3克 炙紫菀12克 炙冬花10克 法夏12克 黄芩10克 川贝12克(冲) 甘草15克 一剂

上方服后，自觉胸部稍宽舒，咳喘略缓。原方再进三剂，咳喘郁热减，痰仍盛。去黄芩，加桔梗、云苓，又进三剂，诸证显著好转。嘱原方再进三剂，以资巩固疗效。
1979年7月21日追访：患者现已74岁高龄， 谈及当年病势沉重，经范老治愈，九年来身体较好。现在还能步行到附近场镇赶集。
[按语]
《金匮要略》云：“ 咳而上气，喉中水鸡声，射干麻黄汤主之 ”。本案病属太阳伤寒，与射干麻黄汤证相合，故以此方加减治之。因风寒郁闭，微有热象，去五味之收，大枣之腻，生姜之辛；另加黄芩、川贝，以增强清肺化痰之效。

6、太阳证哮喘
马××，男，3岁。四川双流县某乡。
[病史]
从婴儿时起，常患感冒。两岁时，曾高热咳嗽，服药后热退，但咳嗽未愈，迁延至三岁。近因新感，病势加重，发为喘逆，哮鸣之声，邻室可闻。1965年5月来诊。
[一诊]
咳嗽气喘，喉间痰鸣，痰清稀，白泡沫较多，咳时微汗出，遇风咳甚。面色萎黄，舌质淡红，苔白滑。此为太阳表虚证哮喘。法宜解肌祛风，降逆平喘，以桂枝加厚朴杏子汤加味主之。
处方：
桂枝6克 炙甘草3克 白芍6克 生姜10克 大枣15克 厚朴4克 杏仁6克 紫菀6克 防风3克 五剂
[二诊]
服上方五剂，咳喘明显减轻，夜能安睡。早晚遇风仍咳喘，痰多，汗出。风邪未尽，湿痰尚盛。上方加茯苓、陈皮、法夏，以除湿化痰。
处方：
桂枝6克 白芍6克 大枣10克 生姜10克 厚朴4克 杏仁6克 紫菀6克 防风3克 法夏9克 炙甘草3克 云苓12克 陈皮5克 三剂

[三诊]
服三剂后，咳喘大减，时咳清稀痰涎。拟小半夏汤加味，温中化饮，祛风止咳治之。
处方：
云苓12克 法夏6克 干姜3克 炙甘草5克 旋覆花6克 紫菀6克 苏叶3克 防风3克
[四诊]
服四剂，咳喘平。因久病伤正，宜温中益气，健脾除湿，以理中汤加味善其后。
处方：
党参10克 白术6克 干姜3克 炙甘草3克 黄芪6克 法夏6克 砂仁5克 云苓6克 六剂
服六剂后停药，身体恢复正常。1979年7月26日追访，患儿已成年，体质健壮，哮喘未复发。
[按语]
此例太阳表虚，桂枝汤证具。复因风痰交争，新感引动宿疾，气机阻滞，发为哮喘。正如《伤寒论》所说：“喘家作，桂枝汤，加厚朴、杏子佳。”验之临床，对太阳伤寒之表虚兼有喘逆之证，不论老幼皆宜。

7、太阳证刚痉(临产麻疹)
郭××，女，20岁。成都某厂工人。
[病史]
1951年春，因临产入××产院。次日晨，自觉身倦、头昏、发热、恶寒，双眼流泪，鼻流清涕，脸上出现红疹，当即诊断为麻疹。因怕传染，通知其转传染病院。由于即将分娩，两院相距又远，家属不同意，最后回到家中，复感风寒，病情急剧恶化，昏迷失语。遂请范老去家急诊。按太阳证麻疹寒闭论治，服药两剂，转危为安。
[诊治]
面部耳后麻疹出而复收，疹色转为淡紫微暗，疹点下陷。额头微热无

汗，恶风寒，胸闷气紧上逆。项背强痛，两手抽搐，口噤无声，人已昏迷。面色灰暗，唇淡微乌，撬开牙关，视舌质淡红偏暗，苔黄夹白微腻，脉浮紧。此当临产疹出未透而重感风寒，麻毒内陷，并致刚痉之危证。法宜驱风散寒，解痉透疹，以葛根汤加减主之。

处方：

葛根10克 麻黄10克 桂枝6克 白芍10克 甘草3克 生姜lO克 升麻10克

服药后，逐渐清醒，声渐出而语清，手足抽动停止。头项强痛明显减轻，疹点重新现出。此为寒邪衰，郁闭开，刚痉主证已解，转为正常疹出，遂即顺产。后继以清热解毒、甘寒养阴之剂，调治而愈。

[辨证]

一般说来，麻疹属温病范围，切忌辛温发汗。为什么本例竟从太阳经病风寒表实兼证入手?

《金匮要略》云：“ 太阳病，发热无汗，反恶寒者，名日刚痉 ”，“ 太阳病，无汗而小便反少，气上冲胸，口噤不得语，欲作刚痉，葛根汤主之。 ”

临床所见，患者突然项背强痛，胸闷气紧上逆，口噤不得语，以及牙关紧闭等，皆为寒气盛而痉在表。同时疹出即没，疹点下陷，昏迷失语，牙关紧闭，显系麻疹中途隐没之闭证。此病例病机，究属热闭寒闭?细察之，额头虽微热，但非全身灼热；虽昏沉失语，但无烦渴谵妄；疹点虽下陷，仅淡紫微暗。参之唇色，暗淡不红；苔黄而不燥，脉浮紧而不洪数。显然，应属麻疹寒闭之逆证。不可泥于“ 痧喜清凉，痘喜温暖 ”之说。故投葛根汤发表透疹以除寒闭，从经输达邪外出，以解刚痉。

[按语]

产褥期中，由于失血伤津，产道创伤，感染毒邪而引起“ 产后发痉 ”，颇不乏人。本例麻疹，发生于成年，且临产发病，并转为寒闭刚痉，在临床中颇为罕见。此证对产妇而言，生死反掌。其致命之危，首在麻疹寒闭而引起之抽搐昏迷。故临证之要点，必须拨开云雾，辨析其症结。综观患者麻疹寒闭诸证，按伤寒六经，归根到底，则为寒

气盛而致痉，应属寒，属表，属实，病在太阳之经，葛根汤实为对症之良方。

8、太阳证柔痉

史××，男，37岁。北京市某局汽车驾驶员。

[病史]

1977年秋开始，头痛、眩晕、眼胀、后项强直胀痛及背，牵连双肩酸楚，难以俯仰转侧。驾驶车辆时，头项活动受限，严重影响工作。夜间卧床，必须垫上三个高枕；病重时闭眼则觉眩晕，甚而被迫睁目不眠。西医查无明显指征，仅血压稍偏高。经常服用镇痛、安眠剂，无明显效果。 1978年9月来诊，按太阳证柔痉论治，半月痊愈。

[诊治]

头痛、项背强痛。常自汗出，头项部特别恶风。躺下则头晕，夜卧不宁。一年来逐渐加重，驾驶汽车日感困难。舌质淡红，苔白滑润，脉浮濡。此系风湿外伤筋脉之“项背强几几”，属太阳病“柔痉”。法宜解肌祛风，濡润经脉。以桂枝加葛根汤主之。

处方：

葛根12克 桂枝9克 白芍9克 炙甘草9克 生姜15克 大枣20克 二剂

上方服两剂，诸证悉减。损益再进数剂，嘱其注意冷暖。半月左右病遂告愈。 1979年5月17日随访，患者说：经范老治愈后，一直未再犯病。去年11月，驱车万里，远至东北，至今头项再无不适之感。

[辨证]

本例头痛项强，舌淡红润，苔薄白滑，脉浮，显系太阳痉病。虽病已年余，但无里证，无传经之候，病仍属太阳经证。

初诊时，项背强几几为时已久，究其病因，为风寒之邪壅阻脉络，气血运行不畅，以致筋脉失养。舌质正常、苔白滑，脉浮濡，为太阳表证之象；再参之汗出而恶风，此为表虚之证。

《伤寒论》明确指出：“太阳病，项背强几儿，反汗出恶风者，桂枝加葛根汤主之。”与本例对照，主证相符，故投原方。

[按语]

本例桂枝加葛根汤之柔痉，与上例葛根汤之刚痉，皆以桂枝汤为基本方，均重用葛根为君。所不同者，麻黄一味之差，有汗无汗一字之异，其理法方药，则随之不同。但历来《伤寒论》若干版本，刊载之桂枝加葛根汤多有麻黄。后人如林亿等提出，此恐非仲景之本意。今验之临床，亦确实如此。

9、太阳证风湿

田××，女，70岁。北京中直机关家属。

[病史]

左下肢疼痛，以小腿与膝关节为重，步履艰难，一年有余。××医院按风湿性关节炎治疗。经理疗、针灸、中药治疗无效。1978年11月28日来诊，按太阳证风湿论治，两诊而愈。

[初诊]

经人搀扶前来。左腿痛甚，难以着地，并有畏风及沉重感，入夜常剧痛难寐。关节不红肿。舌质淡红，苔白滑。此为太阳证风湿，法宜祛风胜湿，解肌通络，以桂枝汤加味主之。

处方：

桂枝3克 白芍10克 生姜15克 大枣15克 牛膝10克 炙甘草10克 威灵仙6克 木瓜10克 二剂

[复诊]

上方服两剂，腿痛消失。可下地自由走动。为巩固疗效，清除余邪，原方加减，再服。

处方：

桂枝6克 白芍10克 生姜10克 牛膝lO克 炙甘草10克 木瓜10克 紫苏叶10克 防风10克 法夏10克

服两剂病愈。1979年5月15日追访，因家中无人，邻居介绍：1977年患者腿痛，多处治疗，不见好转，痛甚时，背着儿女在家哭泣。范老几剂药治愈，现回乡探亲去了。

[按语]

《伤寒论》中，论述杂病颇多。而风湿痹痛之阐述，又以《太阳篇》

最详。 盖太阳主一身之表，为六经之藩篱。风寒外邪袭人，太阳首当其冲。或由表及里，引起整体反应；或具备太阳病之特征，不必拘于时日，皆可从实际出发，按太阳病“脉证并治”。
本例之关节疼痛，其病变为风湿之邪，由表及里，留注腠理，滞于下肢，使局部气血运行不畅，邪阻益甚，故痛剧难忍。用桂枝汤者，取其通阳解肌，祛风邪，调营卫之效。重用芍药、甘草，酸甘化阴，凋血养筋，缓急止痛；加牛膝，性善下行，活血通经；再加木瓜、威灵仙，舒筋活络，祛风除湿，以共奏解表驱邪之功。
此篇置于风湿痹痛诸案之第一篇，拟通过现代之实践检验，举一反三，进一步证实，伤寒之中有万病，仲景约法能合诸病也。

10、太阳证风湿
杨××，女，60岁。四川省温江县永宁乡， 农民。
[病史]
既往有风湿痛史。1974年8月初， 身觉不适，畏寒，头昏，身痛。某日正弯腰时，忽感腰部剧烈疼痛，不能伸直，头上直冒冷汗，遂倒床不起。邀范老诊治，按太阳证风湿论治，十余日痊愈。
[诊治]腰痛如割，不能转侧，身觉阵阵畏寒发热，手脚麻木。面色青暗，唇乌，舌质微红，苔白滑腻，触双手背微凉，脉浮虚。此为太阳证，风湿相搏，卫阳已虚。法宜温经散寒，祛风除湿。以桂枝附子汤主之。
处方：
桂枝15克 制附片60克(久煎，一个半小时) 生姜30克 炙甘草10克 红枣30克 四剂
上方连眼四剂后，诸证悉减。再服四剂，基本痊愈。从此行走、劳动如常。1979年6月追访， 患者谈及五年前病愈以后，未再复发。
[按语]
《伤寒论》指出：“伤寒八九日，风湿相搏，身体疼烦，不能自转侧，不呕不渴，脉浮虚而涩者，桂枝附子汤主之。”本例诸证与上条基本吻合，故按原方投之，仅药量斟酌变化。加重桂枝，发散在表之

风寒，通阳化气；配以生姜，使风邪从皮毛而出；加重附子，温经逐寒止痛，助肾阳，而立卫阳之基；佐以草、枣，益中洲、和营卫，则三气除而搏自解。

11、太阳证风寒湿痹(风湿)

汤××，女，37岁。成都市棕垫生产组工人。

[病史]

1964年自觉经常头晕，乏力，周身关节疼痛。1965年10月30日晚，突觉肢体沉重疼痛，不能转侧，手不能握物，足不能移步，衣食往行均需他人料理。次日急送××医院，诊断为“风湿”。经针灸治疗十余日，效果不显，遂来求诊。按太阳证论治，三个月基本治愈。

[初诊]

由两人搀扶前来就诊。全身关节剧痛似鸡啄，游串不定。头晕，耳鸣，四肢不温，畏寒恶风，口干少津，不欲饮。舌质偏淡，舌体胖大，边缘有齿痕，苔薄白。寸关脉浮虚，尺微沉。此为太阳证，风寒湿邪郁久成痹，法宜温经逐寒，除湿止痛，以甘草附子汤加味主之。

处方：

炙甘草30克 制附片60克(久煎) 白术12克 桂枝18克 生姜30克 二剂

附片先煎一个半小时，再加其它味药同煎约半小时(以下汤剂中，凡有附片者，均以此法煎煮)；日三服，忌食生冷。

[辨证]

此证风寒湿邪兼而有之，蕴积已久，郁阻成痹。虽有畏寒恶风脉浮之表证，但不可单用发表；虽有头晕耳鸣，四肢不温，口干不欲饮，舌质偏淡而尺脉沉之里证，又不宜径投回逆。参之舌脉诸证，乃为风寒湿相搏，属太阳类似证。《伤寒论》曰：“风湿相搏，骨节疼烦，掣痛不得屈伸，近之则痛剧……甘草附子汤主之。”此方用治本例风寒湿痹，颇相吻合。甘草益气和中，附子温经散寒止痛，白术燥湿健脾，桂枝祛风固卫，通阳化气，加生姜以助温散之力。

[复诊]

上方服两剂后，关节疼痛减轻，稍可转侧行动。上方加麻黄、辽细

辛，以增强驱风散寒、开闭止痛之效，续进五剂。
[再诊]
自拄拐杖前来就诊。关节疼痛及全身串痛著减。头晕，耳鸣，畏寒，恶风亦明显好转。上方加茯苓以渗湿，续服五剂。
[又诊]
全身活动已较自如，精神好转，但腰腿尚觉疼痛、重着。今虽见初效，毕竟一时难收全功。须培补脾肾，通窍除湿，以清余邪，拟理中丸加味续服。
处方：
潞党参60克 干姜片120克 炒白术60克 炙甘草60克 制附片120克 云苓60克 上肉桂30克 川桂枝15克 宁枸杞60克 真琥珀60克 五剂
共研细末，水打丸，如黄豆大。日服二次，每次3克。
连服三个月，基本痊愈，恢复正常工作。1979年追访，十余年来，虽关节偶有轻微疼痛，但行动自如，一切较好。
[按语]
甘草附子汤之“骨节疼烦，掣痛不得屈伸”，与桂枝附子汤之“身体疼烦，不能自转侧”，皆为风寒湿相搏之太阳证；其疼痛不能自已者，均为筋胀之故，病理相同。所异者，本例甘草附子证，风湿留于关节，邪深入里；而桂附证，风寒湿留着肌肉，有表无里。故汤证不同。
上述两方原义，桂附证因属风湿，留着肌表，当以速去为宜，故附子用量较大；而甘草附子证，已病久入里，减其附子用量者意在缓行。但本例虽属久病入里，又暴发于一旦，且脉沉而细；故兼采两方之义，加大附子并生姜，既速去标，又开筋骨之痹也。

12、太阳证历节病(风湿性关节炎)
柴××，男，13岁。四川省郫县团结乡，学生。
[病史]
1975年11月，在校义务劳动中遇雨，全身湿透，身觉不适。翌日，感周身骨节烦疼，服药效不显。一月后，双膝关节逐渐肿大，骨节变

形，膝关节周围出现硬结。1976年1月初，下肢屈伸不利， 行动困难。经××医院诊断为“风湿性关节炎”。同年2月初来诊，按历节病论治，月余病愈。

[初诊]

患者已卧床不起，由其父背来就诊。全身关节疼痛，尤以四肢为甚。双膝关节肿大，膝面有多处硬结，双手掌脱皮，双脚边缘红肿麻木。晚间自汗出，食欲不振。舌质较红，苔白微腻，脉浮紧数。此为太阳证历节病。法宜驱风解热，化湿散寒，以桂枝芍药知母汤加减主之。

处方：

桂枝12克 赤芍12克 知母12克 麻黄10克 生姜10克 白术15克 甘草6克 防风12克 苡仁20克 三剂

[辨证

本例劳动中大汗出，风寒湿邪留注关节。正如仲景所云：“汗出入水中，如水伤心。历节黄汗出，故日历节。”又云：“诸肢节疼痛，身体廷赢，脚肿如脱，头眩短气，温温欲吐，桂枝芍药知母汤主之。”此例主证突出，风寒湿邪致痹，病属太阳类似证。但已有风从热化之象，故去附子，加苡仁以增强渗湿利痹，止痹痛拘挛之效。

[二诊]

上方服三剂，下肢渐能屈伸，诸证皆有好转。守原法加辽细辛再服两剂。

[三诊]

膝关节及脚肿消，膝面硬结缩小．变软。全身关节仍有轻微疼痛，原方加减续服。

处方：

桂枝10克 赤芍12克 麻黄10克 生姜10克 白术12克 甘草3克 防风10克 茯苓12克 川芎10克 柴胡10克 前胡10克 羌活10克 独活10克 辽细辛3克

嘱服数剂，可停药，注意生活调养，忌食生冷和预防风寒。

月余后，其父来告，小儿关节已不疼痛，双膝硬结消失，病已痊愈。1979年7月追访，其母日：玉儿已长成人，身体很健壮。自范老告戒

后，不准他洗冷水澡、食生冷之物，四年来病未复发。
[按语]
以上四例太阳证，西医辨病大体相同。但范老临床施治方药，各有所异：田例风湿之邪，留洼肌腠，下肢局部气血阻滞，以桂枝汤加味轻取之；杨例风湿相搏，卫阳已虚，腰剧痛不能转侧，桂枝附子汤中重用附子，温经逐邪，助肾阳而立卫阳之基；汤例风寒湿邪久留骨节，又突然转重，甘草附子汤中重用附子，速开筋骨之痹；柴例病属历节，兼有风从热化之象，故去附子，后加羌独柴前而收功。四例皆属太阳证之范畴，或称太阳类似证，病因与病位相似，但理、法、方、药有所不同。可见范老既重“辨证”，又严“论治”，且善于“同病异治”。

13、风寒湿痹(坐骨神经痛)
李××，男，4J6岁。铁道部某厂干部。
[病史]
1974年底，腰臀部痛引双下肢，左侧为甚，行动日益困难。××职工医院诊断为风湿性坐骨神经痛。经针灸、中西药治疗，其效不显。遂发展至下肢难以行动，生活不能自理。于1975年2月底， 由工厂派专人护送来成都求治。
[初诊]
患者卧床不起，翻身需由他人协助，腰臀部及下肢麻痛沉重，左下肢尤甚，活动患肢则疼痛加重。恶风寒，头痛，小腹胀满，小便不利，双下肢凹陷性水肿。面黄无泽，舌质淡红，苔白滑厚腻，根部微黄。此证属风寒湿痹，湿邪为胜。急当温阳化气行水，以五苓散加味主之。
处方：
猪苓10克 茯苓20克 泽泻10克 砂仁10克 白术15克 桂枝15克 上肉桂10克 五加皮12克三剂
[二诊]
服上方后，小便量增多，腹部及下肢肿胀减，但疼痛无明显改变。针

对主证，以助阳胜湿，散风止痛之甘草附子汤加味主之。
处方：
炙甘草30克 制附片120克(久煎) 桂枝15克 生白术20克 生姜60克 云苓30克 四剂
[三诊]
服上方后，全身关节疼痛减轻，扶杖可下地缓步而行。宜原法再少佐麻黄、辽细辛，以增强开闭、散寒、行水之力。
处方：
炙甘草30克 制附片120克(久煎) 生白术20克 桂枝15克 生姜60克 麻黄10克 辽细辛4克云苓20克 五剂
[四诊]
头痛，腰臀部及下肢疼痛大减，离杖能行。肢肿基本消失，尚有寒湿凝聚、经络受阻之象，继以活血通络、舒筋散淤之品调理之。
处方；
桂枝 木通 红藤 威灵仙 当归 川芎 猴骨 海马 松节 牛膝 木瓜 乳香 没药 苏木 辽细辛 羌活 独活 柴胡 前胡 血竭 伸筋草
以上各10克，共为细末，水打丸。每晚睡前用白酒兑服3克。
服药20余日后，病愈恢复工作。 1979年7月20日追访，至今未复发。
[按语]
本例太阳痹证，以湿为胜。急投五苓散加味，不仅急则治标，同时化气行水，即为治本。前贤曾称“五苓散，逐内外水饮之首剂。”而桂枝则为此方之关键，故重用之，以增强通阳化气行水之力。另加上肉桂，补命门真火，助气化，散寒凝；加砂仁醒脾化湿，行气宽中以消胀满，且能纳气归肾以助膀胱之气化；再用五加皮祛风湿之痹痛，疗经络之拘挛，且有利小便、消水肿之效。服药三剂而病获转机。然后抓住风寒湿致疼痛之主证，继用甘草附子汤。 白术、附子，顾里胜湿；桂枝、甘草，顾表胜风；重用附子，温里扶阳，除痹止痛。冠以甘草者，意在缓而行之。最终，再用活血通络之法以善其后。

14、风寒湿痹(周期性麻痹)

刘××，男，45岁。辽宁省抚顺市某局干部。

[病史]

1975年2月，参加抗震救灾工作。 当时气温降至零下20度，在雪地临时架设帐篷办公和食宿。2月17日深夜，起床接长途电话， 衣着单薄，持续约20分钟，后感下肢冷麻。翌日，遂不能站立。经医疗队以抗风湿治疗无效，第五日即四肢瘫痪。2月24日送回抚顺，××职工医院外科诊断为“筋肌纤维质炎”。又转××医院治疗，当时膝关节红肿，诊断为“急性风湿症”。

此后三年内，时好时坏，反复发作。多次住院，有一次长达200多天。1979年1月9日瘫痪复发后， 病情加重，每日反复发病，大腿肌肉呈阵发性游走疼痛，轻则起立困难，重则卧床不起。经辽宁省某中医医院内科，先后诊断为：“痹证”、“痿证”、“痿痹兼证”、“风痱”。沈阳××医院内科、神经内科会诊，诊断为“发作性瘫痪待诊”，并建议转北京诊治。在北京××医学院附院确诊为：“周期性麻痹”。1979年4月13日前来就诊。

[初诊]

由专人陪伴来诊，步履困难。周期性下肢瘫痪每日发作，轻时蹲下后即不能起立，重则四肢皆瘫；发作时间约半小时到1小时，有时长达8小时以上。不服药也可以暂行缓解，次日又突然发作。受凉或疲乏后较易引发。两腿肌肉游走疼痛，并有凉麻感，四肢关节及腰部亦时觉痛胀。头晕痛，口干，无汗。舌质稍红，根部薄黄苔，脉浮紧。此为太阳证风寒湿痹，外邪郁闭，阻滞经络，长期凝聚不解。法宜解表开闭，散寒除湿，以麻黄汤加减主之。

处方：

麻黄10克 杏仁12克 苏叶10克 防风10克 法夏12克 甘草15克

因稍有热象，去桂枝，重用甘草；为加强祛风散寒除湿之力，加苏叶、防风、半夏以佐之。从4月13日至5月18日，月余内，每日一剂，基本以此方加减。犯病程度逐渐减轻，时间缩短，能独立自由行动。

[辨证]

患者病情复杂，周期性麻痹缠绵不愈，迁延数年，日益沉重。
《素问?痹论篇》云：“ 所谓痹者， 各以其时重感于风寒湿之气也。 ”本例病发于严冬，风寒湿邪，互相交织。肌肉关节疼痛，游走不定，为风痹之象；下肢时觉冷痛，遇寒加重，乃寒痹之候；肢体关节，尤其是双腿重着疼痛，又为湿痹之征。从主证来看，风寒湿痹，兼而有之。
《素问?痹论篇》还指出：“ 痹，或痛，或不痛，或不仁，或寒，或热，或燥，或湿 ”，“ 痛者，寒气多也，有寒，故痛也。其不痛、不仁者，病久入深，荣卫之行渣，经络时疏，故不通，皮肤不营，故为不仁 ”。本例患者时痛、时不痛，时麻木不仁，或寒、或热、或湿，虽证候纷纭，错综复杂，但其为太阳痹证则一也。
从病因病机分析，此证仍从太阳伤寒传变而来。’初诊证候，尚具头痛、肢体关节痛、无汗、脉浮紧，表明太阳伤寒表邪郁滞未解。不论病程长短，证候如何复杂，仍遵仲景“ 外证未解 ”，“ 当先解表 ”之旨。虽然本例表里相兼，亦应先解表而后治里，以期获“ 表解里自和 ”、或表轻里亦减之效。
[二诊]
近日来间隔二、三日发作一次。未出现四肢瘫痪，仅下肢突然不能抬起，或蹲下不能站立，持续约2至3小时缓解。两腿肌肉串痛，凉麻较甚，只上半身出汗。邪中血脉，气血凝滞之象仍重。法宜活血通络，温经散寒，以当归四逆汤加味主之。
处方：
当归12克 桂枝10克 白芍10克 辽细辛3克 木通10克 炙甘草6克 大枣20克 生姜10克 苏叶10克 防风10克 牛膝10克 木瓜10克
[三诊]
从5月22日至6月13日，以上方随证加减治之。发病间隔延长至五至七天，发作时间缩短，仅感四肢痿软无力，疼痛与凉麻亦减轻。为增强疗效，改投桂枝附子汤，进一步温其经脉，逐其风寒。并配服针砂丸荡涤湿邪。

处方一：
桂枝10克 制附片20克(久煎) 生姜20克 炙甘草10克 大枣30克 茯苓18克 白术15克
处方二：
针砂 硼砂 绿矾 白矾 神曲 麦芽 木通 广香 甘草
各30克研末为丸，每日一次，每次约5克。
服上方后，疼痛减，近日来仅有轻度发病。又间以麻黄汤、桂枝汤加减，散寒开闭，通阳解肌，并收通经络，开痹阻之效。
[四诊]
7月14日。发病时，下肢疼痛痿弱进一步减轻，可自行站立；发病时间缩短至1小时左右。7月11日犯病时，只觉左腿沉重，行步困难， 半小时后即缓解。病现向愈之佳兆，以五通散加味，舒筋通络为治。
处方：
血通12克 木通10克 通草6克 桂枝10克 茯苓20克 法夏20克 苏叶10克 防风lO克 牛膝12克 木瓜12克 苡仁15克 甘草3克 伸筋草15克 五加皮15克 丝瓜络10克
上方加减连服27剂，30余日未犯病；其后，曾交替服用当归四逆汤、桂枝附子汤及五通散加减。共25日未发病。
[五诊]
9月以后。遇有外感或劳累，仅间有发病。平时下肢肌肉略有凉麻疼痛之感，腰微痛：10月中旬，病已显著好转，要求回单位工作。行前嘱其避风寒，忌生冷，注意调养，并拟五通散加味，令其缓服以资巩固。
处方：
血通10克 木通10克 通草6克 桂枝6克 白芍10克 灵仙15克 牛膝10克 木瓜10克 钩藤10克 防风10克 乳香10克 没药10克 茯苓20克 法夏20克 甘草5克 生姜20克
[按语]
本例周期性麻痹，前医曾众说纷纭。从中医临证看，主要分歧，在于

或痹或痿，或痹痿相兼?
一般说来，“ 痹 ”与“ 痿 ”应属两类病变：痹属寒与实；痿属热与虚。患者虽有肢体痿弱之象，乃由痹病痛久而废用，并非“ 五脏因肺热叶焦，发为痿 躄 ”(《素问?痿论篇》)。当然，致痿的原因甚多，但其主因为五脏，如肺脏之热。而本案主要为“ 风、寒、 湿三气杂至，合而为痹 ”(《素问?痹论篇》)，属太阳证。故坚持温通之法为治。

15、太阳证水疝
何××，男，6个月。成都某局职工之子。
[诊治]
1960年8月。患儿连日来，哭啼不休，饮食大减，面青黄，体消瘦，父母不知何故。某日突然发现小儿阴囊肿胀，如鸡子大，似水晶重坠，少腹按之有水声，急来求诊。此为寒湿凝聚，经脉不通，气滞于下，水湿浸渍于阴囊。法宜化气行水，温肾散寒，以五苓散加味主之。
处方：
猪苓6克 茯苓6克 泽泻6克 白术6克 桂枝6克 上肉桂3克
上方服一剂，肿胀消，疼痛止。
[按语]
疝病之名，始于《内经》。但与今日西医所谓之疝气，涵义不尽相同。后世医家对疝病的命名更加繁多，但对其发病尤侧重于厥阴肝经，故有“ 诸疝皆归肝经 ”之说，治法多以温肝疏木为主。本例小儿水疝，主要为寒湿凝滞阴器，膀胱气化失常，气之所积，久而不散，水液停聚，致阴囊肿痛。故投以五苓散，以除水蓄之疝颇效。不仅小儿或男子水疝可用，妇女类似之病变亦可移用。如一青年妇女，小腹凉麻，下阴重坠，阵阵抽引疼痛。范老从手足太阳同时入手，以五苓散加重二桂于利水之中，大宣阳气，药服两剂亦愈。

16、阳明证呕吐(食管癌待查)
席××，男，52岁。成都某厂干部。
[病史]

1972年3月，自觉外感不适，胸膈闷胀，不思饮食，食入即吐。急入××医院，住院治疗十余日，经抽取胃液，并食管镜取下活组织病理检查，诊为“食管癌待查”。后转入××医院，经半个多月检查治疗，仍未确诊，终日靠输液维持，思想负担益重。再转××医院，由中医诊治，改服大量补气降逆止呕之剂，病势犹未减。1972年4月，遂请范老至家中急诊。

[初诊]

饮食不下，食入即吐，历时月余，形体日益消瘦。心烦、胸闷、身疼、发热、汗出、微喘、溺少，上腹部时时隐痛，下肢微肿。面色黧黑，唇乌，舌质深红，苔黄厚腻浊，系太阳表邪未尽，传入阳明。正如《伤寒论》所说：“伤寒、发热、无汗、呕不能食，而反汗出濈濈然者，是转属阳明也。”法宜散寒泄热，降逆和中，以麻杏石甘汤加味主之。

处方：

麻黄12克 杏仁18克 石膏60克 甘草10克 桑皮30克 黄芩12克 六剂

[二诊]

上方连进六剂后，自觉身痛、发热、心烦、汗出均减，全身稍觉轻快。惟仍不能进食，食入即吐。此阳明邪热内结，痰湿与宿食相胶着，堵塞胃脘，致胃气上逆而呕吐。本《素问?阴阳应象大论篇》“其高者，因而越之”之意，以吐法为治。

处方：

硼砂2克

用温开水一次冲服。

疏方以后，有关医院认为，此药有毒，不可误服。但本人和家属均坚持服用。为了慎重，领导遂令住院试服，以防不测。服药前，开始输液。上方服后数分钟，即涌吐出大量灰黑色粘液、泫痰，以及其它污浊之物。阵阵涌吐，持续约两小时，吐出秽物盈盂。顿觉上腹部明显舒适。当晚睡眠良好。次日晨，试进稀粥一小碗，呕吐竟未发作。

[三诊]

精神好转。上腹部痛，胸闷，喘息等证消失，苔浊腻减。为清余邪，以自制九成丹，清热解毒，化淤通窍，缓服之。
处方：
真牛黄半份 原麝香半份 血琥珀一份 人中白二份 花蜘蛛二份 蒲公英二份 上梅片半份 血余炭一份
按上述比例，共研细末，隔日服一次，每次一克，月余后痊愈。1979年6月30日追访，患者高兴地说：“ 自病愈后，七年来，能坚持上班，饮食如常，身体健康。 ”
[按语]
《素问?至真要大论篇》云：“ 诸逆冲上，皆属于火。 ” 又云：“ 诸痿喘呕， 皆属于上。 ” 但此证不能单纯治以清火。因为痰浊夹邪化热，乃其致病机转，故涌吐痰食，则气机通畅，热结亦解。所谓 “ 土郁则夺之 ” 者是。范老面临此证，遵经之旨，敢于用峻猛之剂，使月余饮食不进，病势危急之候，迅速奏效。其独到之处在于：先用麻杏石甘汤加味，重用石膏，连服六剂，虽呕吐未止，却为吐法奠定了基础。继用硼砂一味，取其功入上除热，荡涤垢腻积块，并能刺激胃液分泌，借饮入于胃即吐之机，因势利导而越之。令在上之痰涎宿食等胶着异物，一涌而出。此所谓毕其功于一役也。

17、阳明证高热痿躄
张××，女，24岁。四川郫县红光乡，农民。
[病史]
1960年10月某日于田间劳动后，自觉身热头痛，周身不适，入夜尤甚。次日，××医院按感冒论治，后改服中药，反复汗出，而热势不减。十余日后，忽感下肢痿弱无力，难以移步，遂来就诊。按阳明经证论治，一诊而痊愈。
[诊治]
蒸蒸发热已十余日。几天前，突然下肢痿软，步履维艰，甚至难以站立。自觉口干烦渴，身热汗多，不恶寒，反恶热。面赤，舌质鲜红少津，无苔，脉洪大。此系阳明高热不退，肺胃津气两伤，以致筋骨失

养成痿。法宜泄热润燥，补气生津，以大剂白虎人参汤加味主之。
处方：
知母60克 生石膏120克 生甘草15克 粳米30克 北沙参60克 竹茹30克 灯心草1克为引
二剂
连服两剂，一剂热势衰，二剂高热退，渐能独自行走。遂停药，嘱其注意调养，旬日痊愈。
[辨证]
患者来诊时，身大热、汗大出、大烦渴、脉洪大，所谓“四大”俱备。脉洪大为阳明内热炽盛，热邪扰于内则作烦，热盛耗津则口大渴。加以患者面赤、舌红、口燥，皆为病邪在里，阳明热盛之象。
或问：患者阳明证高热仅一、二十日，何以突然致痿?因其阳旺邪盛，津液大伤，致使筋弛不收。同时，足阳明胃之津液亏耗，则脾不能为胃行其津液，而脾之大络络予肺，自不足以濡润手太阴肺，正如《素问?痿论篇》所谓：“肺热叶焦，发为痿躄”。阳明经证热盛伤津，《伤寒论》提出以白虎加人参汤主之。本例重用石膏，清阳明独盛之热；佐知母之苦寒而凉润，既清炽盛之邪热，又复亏耗之真阴；用北沙参，取其养胃生津之功；加竹茹，增强除胃热止烦渴之效。再以灯芯草少许，引上部郁热下行。
[按语]
仲景之白虎汤及白虎加人参汤，因于寒凉清肃之中，寓有通宣之效，退热而无滞邪之弊，甘寒并用而不伤胃，其使用范围曾有较大之扩展。如《金匮?痉湿喝病脉证治》以白虎加人参汤主治太阳中喝。《资生篇》以人参白虎治气分有热。《保赤全书》用以解麻疹斑疹。《活人辨疑》之化斑汤，也即此方。《证治准绳》治温邪湿重，则以白虎加苍术。唐容川用白虎加味治白痢。张锡纯对白虎汤及石膏之应用，也大有开拓。近年来以白虎汤治疗流行性乙型脑炎(偏燥者)和脑溢血等颇效。由此可见，古今对白虎汤之运用不断扩展。但以白虎加人参汤治疗痿证者则罕见。范老严格按照六经辨证，用此方治疗痿 躄 之经

验，是值得重视和研究的。

18、阳明证臌胀

范××，女，22岁。成都市龙泉区长风乡，农民。

[病史]

两岁时开始患腹胀，其后发展到全身皆肿，肌肉变硬。下阴常流黄水，臭味异常。十多年来，病魔缠身，其父为之四处求医，未见显效。1969年8月，前来就诊，按阳明腑证论治， 服药两剂后基本治愈。

[诊治]

腹胀如鼓，胸胁满闷，皮色苍黄；全身肌肤胀硬。大便常秘结，所下如羊粪，已四日未行；下阴不断渗出臭黄水。舌质深红，苔黄燥，脉沉实有力。此为阳明腑证兼水热互结。法宜峻下热结，兼逐积水，以大承气并大陷胸汤加味主之。

处方：

生大黄18克 厚朴30克 枳实30克 芒硝30克 甘遂15克(冲服) 芫花15克(冲服) 桑皮60克

先服一剂，泻下燥屎十余枚，并臭秽黄水甚多，腹部硬胀消失大半。续服一剂，胸腹肿胀皆消，全身肌肤变软，下阴外渗之黄水亦止。因自觉病势顿减，加以客居成都，经济困难，遂自行停药回家。不久患者邻友来告，已康复如常。1979年7月追访，病愈结婚，并生一子。十年来身体一直很好。

[辨证]

患者虽病程颇长，因正值青春，素体阳旺。胸腹胀满，皮色苍黄，大便秘结，舌红苔燥，脉沉实有力，显然属阳、属热、属里、属实。正所谓“大实有羸状”。再观之大便硬结如羊屎，几日未行，应为阳明腑实，痞满燥实俱备无疑。然此证又现全身肌肤肿胀，从心下连及少腹，胀满尤甚，同时下阴流黄水而恶臭，皆为热结水积之象，即燥热结胸之证。由此形成阳明腑实为主，太阳结胸相兼，邪实病深，错综复杂之局面。热结须峻下，积水宜攻逐，病重不可药轻。因此，大承

气与大陷胸汇成一方，大剂猛攻之，取其斩关夺隘之力。
[按语]
臌胀系内科之重证。论治之关键，首在辨其虚实。一般而言，臌胀初起，气实病实，宜峻剂攻逐；若久病脏气日虚，则不宜峻消其胀。本例患者，虽病久而形瘦弱，但邪实而阳旺，故不可按久病多虚之常规论治。

19、太阳阳明证泄泻(过敏性结肠炎)
姚××，男，46岁。四川成都某厂干部。
[病史]
曾于1970年夏患阿米巴痢疾，经医院治疗，痊愈出院。因饮食不节，过食生冷，病又复发。中西医治疗月余，腹泻止。但其后因工作劳累，饮食不慎，又出现腹部隐痛，腹泻便稀，口三、四次，1971年经四川省××医院确诊为“过敏性结肠炎”、“慢性肠炎”。在成都先后经多处医疗单位治疗，服中药一百余剂，时好时坏，夏秋更重，迁延五年之久。1975年11月2日来诊，按太阳阳明证泄泻论治，月余而愈。
[初诊]
腹泻每日三、四次，胃腹胀满隐痛，大便时稀时秘，无脓血。头昏，身痛，神疲面黄，肢体消瘦。舌质暗红，苔黄白而润，脉浮紧。此为外感风寒郁闭，寒湿留滞肠中，交织不解，迁延日久。属太阳阳明泄泻。宜先开腠理，除寒湿，以麻黄汤加味主之。
处方：
麻黄10克 桂枝10克 杏仁18克 甘草30克 法夏18克
二剂，忌油腻、生冷。
[辨证]
患者几年前曾患痢疾，后又泄泻。虽排便次数较多，但无里急后重，下利赤白之主证；再参之西医诊断，当不再属痢疾。今头昏，身痛，苔黄白而润，脉浮紧，为太阳风寒束表之象。舌暗红，面萎黄，神倦体瘦，为病邪入里已久，邪实伤正之征。胃腹胀痛泄泻，表明外邪不解，内迫阳明，影响大肠而令传导失职。所以，此病应属太阳阳明合

病泄泻。《伤寒论》云：“ 太阳与阳明合病者，必自下利，葛根汤主之。 ” 病机与此相似，为何不用葛根汤?因此证历时久，寒邪重，表实郁闭，水湿内聚，故须用麻黄汤解表散寒；加半夏燥湿，首开腠理，使邪仍从太阳而解。

[二诊]

服药后，食纳增加，余证未减，舌脉同前。虑其久病邪实，兼之既往所服药中，参芪归地等滋补药较多，致寒湿胶着，一时难以奏效。原方加生姜，温散以助之，再进两剂。

[三诊]

头身略有微汗，疼痛减轻。苔腻稍减。腹痛、泄泻等尚无明显变化。继上方去桂枝，再服两剂。

[四诊]

太阳表实已解，时泻时秘虽减，但尚未根除。本自制针砂散方意，重用白矾，以攻其里，推荡阳明之湿浊。

处方：

针砂 白矾 绿矾 麦芽 广香 木通 硼砂 神曲 甘草

白矾50克，余药各30克，共碾细末，以红糖一斤拌之为丸，如梧桐子大。日二服，每服二粒。

连服二十余日，遂痊愈。 1979年6月24日追访，从病愈以来，未再复发，体重增加儿斤，身体健康。

[按语]

《素问?阴阳应象大论篇》云：“ 清气在下，则生飧泄 ”，又云：“ 湿胜则濡写 ”。泄泻一证，虽有急性多实，实则泻之；久泻多虚，虚则补之之说，但临证不可拘泥。本例病程虽久，但仍以实邪为主，即风寒湿邪，久郁不得外泄，水湿内聚肠胃之间。加之“ 水反为湿，谷反为滞，精华之气，不能输化，致合污下降而泻利作矣 ”。应属太阳表证与阳明里证同病，而以水湿实邪为重。即使有伤正之象，亦不可补。虽有里实，因表证尚重，更不可下。太阳为开，阳明为阖。诸泄之成，多原于湿。故以麻黄之峻，开其表实；继以针砂之方，推荡里

湿。湿邪去而泄泻止。

20、太阳阳明证结胸
钟××，男，45岁。成都市某厂工人。
[病史]
有胃痛病史。月余前曾感受风寒，自觉身不适。面部及全身浮肿，皮肤明显变黄。胃脘及胸胁胀痛，大便秘结，曾按胃痛治疗，病势不减。1960年10月来诊。
[一诊]
胸胁及胃脘疼痛，胸脘之间，触之微硬而痛甚，胸部如塞，呼吸不利，口渴不欲多饮，大便已三日未行。舌质红，苔白黄腻。此为太阳阳明证结胸，法宜泄热逐水，破结通腑，以大陷胸汤主之。
处方：
大黄3克 芒硝3克 甘遂3克(冲服)
一剂，日分三服，得快利，止后服。
[二诊]
服二次，得微利；三次后，得快利。胸胁及胃脘胀痛顿减，浮肿及余证明显好转。遂停服上方，少进清热、化湿之品，以善其后。约半月病愈。半年后追访，身体已康复。
[按语]
《伤寒论》关于阳明一证，曾有太阳阳明、正阳阳明、少阳阳明之分。历代医家对此分类，见解很不一致。通常认为，正阳阳明，为阳明自病；太阳阳明、少阳阳明，是太阳或少阳误治而来；其胃家实则一也。但据范老临床经验：太阳阳明、少阳阳明，不经误治，亦可传经转实。本例太阳阳明证，未经汗下，故属未误治之传经。

21、少阳证发热
杨××，男，54岁。成都市居民。
[诊治]
1960年10月来诊。近两年来，每日早餐后发热，体温38。c左右，汗出

较多，持续约两小时，热退汗止，即觉畏寒。每日如此。头晕眩， 口苦咽干，胸胁满，心中烦躁。舌质红，苔白微黄腻，脉弦数。经××医院检查，发热原因不明，治疗未见好转。此为少阳证发热，法宜和解少阳，以小柴胡汤加减主之。

处方：

柴胡24克 黄芩10克 法夏15克 沙参15克 甘草10克 知母15克 石膏30克 牡蛎24克 陈皮9克 茯苓12克

一剂

上方服一剂，热退，诸证悉减。嘱其停药，调养数日而愈。其后，患者与范老常来往，知其病未复发。

[按语]

此证口苦咽干，头晕眩，往来寒热，胸胁苦满，心烦，脉弦，少阳脉证十分明显。病虽迁延两年，正如《伤寒论》所称“柴胡证仍在者，先与小柴胡汤”。又发热汗出，口渴，舌红，为兼有郁热之象，故去姜。枣，加知母、石膏以清之。又因胸胁苦满较甚，夹有湿邪，加牡蛎、陈皮、茯苓，以渗湿，化滞、散结。

22、少阳证癫狂

吴××，女，43岁。四川省郫县团结乡小学，教员。

[病史]长期失眠多梦，易动怒，多气郁，偶有神志惚恍之象。××医院曾诊断为“神经官能症”。1974年9月，因工作与同志争吵，一怒之下， 突然昏倒。苏醒后，神志不清，语言错乱，亲疏不分，见人詈骂不休。急来求诊，按少阳证癫狂论治，两诊而愈。

[初诊]刚进诊室，就将医生和病人大骂一通，语无伦次。胸满，阵阵呃气，眼神微呆滞，面赤，唇红，便秘。脉弦数，舌质红，苔微黄而腻。此为少阳证癫狂，法宜和解泄热，重镇安神，以柴胡加龙骨牡蛎汤加减主之。

处方：

柴胡12克 龙骨60克(先煎) 黄芩12克 党参12克 桂枝6克 茯苓12克 法夏12克 生大黄10克(后下) 牡蛎60克(先煎) 大枣15克 赭石60克(先煎)

[辨证]患者初起病轻，仅有失眠易怒，心神浮越，微现癫病之象。由于失治而病情加重： 旰气郁结，热久化火；偶遇感情激动，胆火上冲；心气不镇，神志顿为之昏乱，遂发为癫狂。其面赤、舌红、脉弦数，参之上述诸证，可确诊无疑。 《伤寒论》柴胡加龙骨牡蛎汤，本用治太阳伤寒因误下后，胸满惊烦、谵语等证。后世常以此方，治狂痫诸病，今验之临床，确有效验。
[二诊]服两剂，夜可安睡，神志渐清，呃逆亦止。守原法加减续服。
处方：
柴胡10克龙骨30克(先煎) 黄芩10克党参10克 茯苓12克法夏12克牡蛎30克(先
煎) 赭石30克(先煎) 钩藤12克枯花12克甘草3克上方服三剂，病愈。
1979年7月24日追访： 从病愈以来，再未复发。
[按语] 《素问?通评虚实论篇》云：“ 癫疾、厥狂，久逆之所生也。 ”《素问?宣明五气篇》云：“ 邪入于阳则狂……搏阳则为巅疾。 ”以柴胡加龙骨牡蛎汤，治癫痫狂证，历史久矣!过去有人认为：本方既有龙骨、牡蛎之收涩，复有大黄、茯苓之通利；又有大黄之攻，兼有人参之补；以其方意杂揉，疑其不可用，或谓系他方加龙牡之误。经临床实践检验，上说均不可信。

23、太阳少阳证胁痛(慢性肝炎、早期肝硬化)
薛××，男，42岁。成都市某厂干部。
[病史]自1969年患慢性肝炎，1971年肝大肋下3厘米，剑突下5厘米，肝区胀痛，经治疗病情未控制。于1972年春，开始全休。同年5月27日来诊。
[初诊]肝区胀痛，食欲日益减退，进食后腹胀，坐立不安。腰部如重带紧束，难以蹲下。头疼恶寒，面色青黄，两颊瘦削，眼胞与双足微现浮肿。舌质暗淡，边缘稍红，苔淡黄夹白，根部稍厚腻。此为少阳证，兼太阳伤寒，宜先开郁闭，散寒除湿，以麻黄汤加味主之。
处方：
麻黄10克桂枝lO克 杏仁12克炙甘草15克法夏18克服四剂后，头痛与肝

区胀痛略减，余证无明显变化。为增强散寒除湿，通阳行气之力，继用甘草麻黄汤，再服五剂。舌质渐转红，苔腻稍退，现寒湿风热交织之象。为引邪外出，选用荆防败毒散，、去川芎、羌活、独活，酌加桑叶、黄芩、牛蒡等，辛温发汗与辛凉清解之品相配伍，服二十余剂。

[二诊]胁、腰部紧束沉重之感稍减，眼胞浮肿渐消，全身初觉松动。舌苔仍腻而紧密，根部较厚。风寒湿邪积聚已久，蕴结于肝胃，气机阻滞，故胸胁中脘仍觉胀满。今乘表邪已解之机，又据邪实而主证在上之理，因势利导，“ 其高者，因而越之 ”，运用吐法，两月之内，先后用自制“ 二妙丹 ”引吐两次，呕出大量痰涎泫液，并配合服用针砂散。

处方一：“ 二妙丹 ”

绿矾3克 白矾3克硼砂1克炼制成丹，空腹用温开水送服1克。

处方二：“ 针砂散 ”

针砂 硼砂绿矾 白矾神曲麦芽

木通 广香甘草各10克，共为细末。

第一周，每日晨空腹用米汤冲服一次，每次3克；其后，每三日服一次。

[三诊]自觉证状著减，纳增。活动时，肝区仍觉坠胀、疼痛。少阳证未解。以自制回生丹加味，配合针砂散疏肝行气，开窍止痛，缓缓服之。 处方：“ 回生丹 ”藿香丁香 广香辽细辛 巴豆牙皂 雄黄朱砂 白矾蟾酥麝香 炼制成丸，如绿豆大，痛时服2 — 3粒，每日一次。针砂散每周服一次，每次服3克。上方服用两月。

前后治疗五个月，病情基本好转。遂停服汤药，继服回生丹，针砂散，又调养五个月。重返工作岗位，坚持全日工作。

1978年12月，患者来信说：“ 六年来，一直坚守岗位，心情愉快。今年检查，肝肿大已消失，触肝肋下1．5厘米，剑突下2．5厘米，质软，基本上无痛感。即使繁重的工作也能胜任 ”。

[按语] 根据范老临床经验，此种胁痛，单纯属少阳证者较少，而常见

少阳与太阳伤寒相兼，互相交织．且多由外感风寒湿邪，反复缠绵，历久不解，邪传少阳，两经同病。又因寒湿积滞益深，更增气机郁结，肝失条达，日久则气滞血凝，阻塞胁络，以致变证丛生。因此，针对本案少阳之枢转无权，必须首开太阳，发表开闭，散寒除湿。太阳一开，邪有出路，然后根据病情轻重缓急，逐一突破，以竟全功。

24、太阳少阳证腰痛

江××，男，39岁。四川省某局工作人员。

[病史]患者素有腰酸痛史。因天气变化，常轻度发病。1974年4月，自觉头昏，腰酸痛，发热恶寒。某日，当用凉水浣洗时，转身接水，突觉腰部剧烈疼痛，僵直不能转动。几人抬上车，送至××医院外科检查，诊断疑似：一、腰椎错位；二、风湿。经服药、按摩，电针，理疗二十余日，未见显效。遂来求诊，按太阳少阳合病论治而愈。

[诊治]几人搀扶前来就诊，腰部凉而痛甚，难以转侧，全身酸痛，头目晕眩，口干，不欲饮食，间歇发作低热，微恶寒。舌质偏淡，苔白腻，根部微黄，脉弦微浮。此原为风寒湿邪，郁久不解，积聚于腰部。后太阳之邪未罢，复传少阳，致两经同病。法宜祛寒除湿，和解少阳。本柴胡桂枝汤与肾着汤方意用之。

处方：

柴胡10克 桂枝10克 泡参10克 法夏15克 白芍12克 大枣15克 甘草6克 白术15克 干姜12克茯苓15克

二剂

服药半小时，自觉全身开始轻松。连进两剂后，腰部即能自由转动。再服四剂，腰痛遂止。1979年7月7日追访：自从获愈以来，至今未再复发。

[辨证]此证本太阳受邪，由于失治，病情急剧转化，表现在以下两个方面：

首先，太阳外证未除．又出现某些少阳证，太少二经同病，其证相互交错。患者此次发病，即觉发热恶寒，全身酸痛，显系太阳表证。少阳受病后，仍有间歇性低热，微恶寒；此不属少阳之往来寒热，仍为

太阳表证未解之象。另一方面，口苦为少阳受邪，热蒸胆气上溢；头目晕眩，为风火循经上扰空窍；不欲饮食，乃胆气犯胃；参之脉弦，此皆属少阳证候，其邪在半表半里。《伤寒论》云：“伤寒六、七日，发热微恶寒，支节烦疼，微呕，心下支结，外证未去者，柴胡桂枝汤主之。”此例基本上符合本条之病证。再则，此证腰觉凉而沉重，为寒湿侵袭腰部；其病不在肾之本脏，而在肾之外腑。正如《金匮要略》所谓：“肾著之病，其人身体重，腰中冷……甘姜苓术汤主之。”可见，此例除有柴胡桂枝证以外，兼有肾着之病，故本柴胡桂枝与甘姜苓术汤方意，合而用之。

[按语]《素问?阴阳离合论篇》云：“太阳为开，阳明为阖，少阳为枢。”仲景根据这一原理，治太阳表证，据其主开之特点，立汗解之法，制桂枝等方，使邪“汗出而散”。治阳明腑实，据其主阖之特点，立攻下之法，制大、小承气等方，以泻下肠胃燥实。惟少阳主枢，司一身腠理之开阖，禁汗禁下，故制小柴胡汤，为少阳枢机之剂，和解表里之总方。可见此方之任重不拘于经也。

少阳经主上下内外之转枢，在柴胡证发展过程中，或全归少阳，或兼表兼里。若邪之偏于表者，可借太阳之途径，使邪随汗而外解；邪之偏于里者，可借阳明之途径，使邪从泻下而清解。尤其对太少合病之证，单纯用小柴胡托邪外出，则嫌不足。故仲景又立两阳双解之法。将柴、桂合制为一方。取柴胡之半，解少阳之邪为主；取桂枝之半，散太阳之兼，使邪外达。但以本例而言，既有太阳外证未罢，而病机又见少阳；且肾为寒湿所伤，病在肾之外腑。故临证效法柴胡桂枝合剂之意，并甘草干姜茯苓白术汤燠土而胜水，亦为使太少合病之证兼而收效之义。

25、太阴证视歧(复视、双目动脉硬化性网膜病变)

刘××，男，54岁。成都某公园职工。

[病史]主诉：1972年冬，我在公园茶馆售茶。某日下班清帐时，总算不清楚，反复多次还是算不清。我走出屋去，看到迎面不远的小桥上，站着两个人，好象有点反常；我闭眼休息片刻，再看，却又成了

一个人!这时我才意识到，自己的眼睛出了毛病。当时又感到身上疲乏不适，以为一天工作劳累所致，于是提前就寝。
第二天早晨刚起床，看见我家的单门也变成两扇，行人、车辆都是成双成对，房屋成了白色……当即到××医院诊治，经眼科检查后，确诊为“双目动脉硬化性网膜病变”。服鱼肝油并注射VB12，治疗一段时间，病情如故。又去医院，医生说：“你的眼睛已经坏了，眼底血管硬化了，好象机器已经坏了一样，修不好了……以后来注射一个时期针药，再吃些鱼肝油吧!”按此办法，拖了一段时间。同时，又服了一些中药，诸如珍珠母、石决明之类，仍无效。
两月以后，来范老处求诊。按太阴证视歧论治，服药六剂而愈。
[诊治]两月前突然发病，视一为二，有时视物变白色。除此，全身无明显不适和既往病史。舌淡红，苔白黄微腻、稍紧密。白睛微现淡红血丝。此为寒湿之邪入侵手太阴肺经，形成视歧。法宜散寒湿，利肺气，通经脉，以麻黄汤加减主之。
处方：
麻黄10克 杏仁12克 法夏12克 甘草10克
上方连服六剂，复视消失，视觉恢复正常。
1978年12月28日，至患者家中追访。他高兴地说：六年前，吃了六付药，眼睛便完全恢复，每付药才九分钱。自那时起，我不仅照常算账看书，还经常书写蝇头小楷，作国画，描绘山水、花鸟、人物等，一如常人。
[辨证]此证无明显之既往病史，患病之始，仅自觉劳累如感冒后之不适，主证即现复视。《灵枢?大惑论篇》云：“五脏六腑之精气，皆上注于目……精散则视歧，视歧见两物。”通常认为，精散多由肝肾虚损。但此例患者，从病情及全身情况辨析，并无肝肾两虚之征。再者，前医曾用补肝血、益肾气之中西药品，亦未奏效。我们认为，本例之“精散”，当属邪伤手太阴肺经。究其病因，主要在以下几个方面：
其一，《审视瑶函》曾说：目“中有神膏”，此神膏实为肺阴所聚；

前人或称为阴精所生之魄。即《素问?宣明五气篇》所谓：“ 肺藏魄 ”；《灵枢?本神篇》云：“ 并而精出入者谓之魄 ”。张景岳注：“ 魄之为用，能动能作，痛痒由之而觉也 ”(《类经?脏象类》卷三)。人体一些知觉与动作，皆与“ 魄 ”正常作用相关。很显然，此例之视歧，乃邪伤手太阴之精膏所致。

其二，患者视物常现白色、白影。《医宗金鉴》曾指出：“ 浅绿如白肺经发 ”。同时，患者在白睛中现淡红血丝。白睛属肺，肺主治节，且为娇脏，五哐六腑之华盖也。外感寒湿之邪入侵，每先犯肺，使治节失调，致令气血阻滞于目，逐渐凝聚，必损及手太阴之精膏；久之，遂发为视歧。

再参之舌象：舌质淡红而润；苔白滑而腻，兼淡黄色，标志寒湿较重，邪渐入里。再望舌苔紧密，更说明寒湿凝聚较深。寒湿之邪入侵人体，太阳经首当其冲。同时足太阳膀胱之脉，起目内眦，上额，交巅，．下脑后；外邪循经上目逐渐凝聚，终于截散瞳神之精膏，以致视物分歧。

总之，此证之病因病机，为外伤寒湿之邪，循太阳之经入侵，内伤手太阴之精膏，凝结而成。故用太阳伤寒之主方，随证加减，以散肺金之寒湿，通经脉之凝滞，从根本入手施治。

[按语] 前人对麻黄汤之运用，总其要不外太阳伤寒。正如柯琴所说：太阳主一身之表，主筋所生之病，为诸阳主气，太阳为开，立麻黄汤以开之，诸证悉除矣。但，多年来范老临证对麻黄汤应用的范围，已大大超过上述诸证。不仅已突破外感伤寒之局限，同时在许多内伤杂病之运用上，亦常获效。为何此例与麻黄八证无关而用麻黄汤，须从本方之配伍具体分析。

麻黄，味微苦，性温，不仅为发汗之主药，而且“ 于全身之腑脏经络，莫不透达 ”，故前贤赞其“ 开诸闭 ”；“ 谓其破症瘕积聚者，以其能透出皮肤毛孔之外，又能深入积痰凝血之中，而消坚化淤之药，可偕之以奏效也 ”。今用麻黄入手太阴，以逐寒搜风开闭散淤，透邪外出，而去病根。

杏仁，性愠，味甘苦，可升可降，气薄味厚，亦为入手太阴之剂。《本草求真》谓：“ 杏仁，既有发散风寒之能，复有下气除喘之力 ”。本例用杏仁配麻黄，开毛窍，利气机，使久郁之寒邪得有出路。不仅如此，杏仁还能散结滞，故此证用之，不在于降气平喘，而在于散太阴之寒邪，通经脉之凝滞。
去桂枝，不使增强发汗之力；加半夏，取其燥脾湿，散郁结之功；使以甘草，不仅甘平缓中，为麻杏之匡助，而且能表能里，可升可降，通经脉，利血气。
前人云，用药如用兵。“ 运用之妙，存乎一心 ”。推之经方之应用，这个 “ 妙 ” 字，盖为 “ 师其法而不泥其方 ” 欤!

26、太阴证痰咳(慢性支气管炎)
李×，男，5岁。北京某所干部之子。
[病史]初生不久，即患支气管炎。一至四岁时，曾先后在北京××中医院住院治疗。因缠绵不愈，身体益弱，经常感冒发烧，咳嗽反复加重。1978年7月来诊，按太阴证痰饮咳嗽论治，两诊痊愈。
[初诊]患儿咳嗽已一年多，频频发作。痰清稀，睡时可闻痰鸣声。食纳不佳，面萎黄，体瘦。舌质偏淡，苔自滑腻。触双手，肌肤微冷，此为手足太阴两脏同病，水饮久留不去，上干于肺，致常年痰咳不止。法宜温化水饮，降逆止咳。以小半夏加茯苓汤加味主之。
处方：
法夏10克生姜10克茯苓12克紫菀6克冬花3克 甘草3克二剂
[二诊]服上方两剂，咳嗽减，痰鸣消；但仍吐清稀痰，上方损益再服。
处方：
法夏10克干姜6克茯苓12克甘草6克1979年5月24日追访，患儿家长说：经范老治愈，去冬今春再未复发。
[辨证]患儿面黄、体瘦、食少、肢冷，舌质偏淡，皆脾为湿困，失其健运，化源衰少之证。而咳痰稀薄，苔白滑厚腻，又为痰湿内蕴，上干于肺之象。加以卧则痰鸣，显系寒饮上泛喉间，呼吸之气激发使

然。正如仲景所云：“ 水在肺，吐涎沫 ”，“ 水在脾，少气身重 ”。可见，此例病根，首责于手足太阴皆为水湿所困，并互相连累，致使痰饮咳嗽更加胶着难愈。本例痰饮，投以小半夏加茯苓汤，为振奋阳气，治病务求其本之意。原方《金匮要略》用以主治痰饮咳嗽。方中半夏、生姜化饮降逆；加茯苓以去水安神。加甘草者，以助脾气，并配干姜以温中；加紫菀、冬花者，更增消痰下气之效。且小儿脏腑娇嫩，生机蓬勃，一旦病邪衰退，即不宜频频用药，故嘱其着重调理后天，扶正以驱余邪。

[按语) 后世不少《伤寒论》注述认为，六经仅三阳与少阴有咳。其理由为《伤寒论》中，太阳、阳明、少阳病咳记载较多；而少阴病咳，属少阴阳虚，或属少阴热化，但亦非必然见证；何况太阴、厥阴篇并无病咳之记载。而本例痰咳，何以按太阴证论治?

第一，“ 五脏六腑，皆令人咳 ”，非独肺也(《素问?咳论篇》)；但五脏六腑之咳，又必皆表现于肺。他脏之病，必须起于肺，或累及于肺，方能出现咳嗽。故张景岳说：“ 咳证虽多，无非肺病 ”，喻嘉言亦认为：“ 咳者，肺之本病也 ”。

第二，本例患者之痰咳，不仅脾为湿困，且为水气袭肺所致。显然为足太阴脾与手太阴肺同病。

第三，或问，伤寒六经传足不传手，足太阴脾湿何能上干手太阴肺?其实，后世不少注家对此已有阐述。如《伤寒六经辨证治法》云：“ 人之充满一身，无非气血所养，昼夜循环，运行不已，岂有止行足而不行手乎……?设或不传，气逆作满，何经而来?如谓不然，仲景设有桂枝麻黄，乃肺经药也， 岂虚言哉! ”

第四，即使“ 伤寒论》中仅三阳与少阴有咳，正如近世学者认为：“《伤寒论》是仲景书的总论 ”(《伤寒论证治类诠》)。很明显，我们焉能苛求，仲景在“ 总论 ”中，必须将六经诸咳罗列无遗!

27、太阴证寒呃(胃神经官能症)

罗x×，男，25岁。四川新津县某乡，农民。

[病史]1969年冬，时感胃脘隐痛，按之似包块。便秘而腹不满，未予

治疗。翌年，胃脘持续疼痛，嗳气吞酸，呃逆气阻，暖出始舒。曾按“胃炎”治疗数年，后转成都××医院诊为“胃神经官能症”，后改由中医按“肝胃不和”等论治，时痛时缓，迁延至1973年冬，病情加剧。1974年4月初来诊。

[初诊]形体消瘦，面色不荣，阵阵呃逆，胃脘疼痛，遇寒加剧。数月来，只能食稀粥流质，饮入频频发呕，泛吐清涎。大便先结后溏，数日一次。舌质偏淡，苔白滑，脉沉。此为足太阴脾虚寒呃，法宜温中健脾，行气化浊，以理中汤加味主之。

处方：

党参20克干姜15克 白术15克炙甘草6克茯苓20克砂仁12克 白蔻10克法夏15克三剂

[二诊]呃气减少，腹痛缓解，继上方加公丁香、吴茱萸，暖肝行气止痛，再服五剂。

(三诊]呃逆止，食欲增，大便畅，精神好转。嘱忌生冷。再将上方服十余剂。月余后患者来告，饮食如常，已参加农业劳动。

1979年7月20日追访：患者说，“现在身体健康，体力超过一般劳动力。”

[按语] 呃逆一证，《素问?宣明五气篇》云：“胃为气逆、为哕”。《素问?宝命全形论篇》云：“病深者，其声哕”。《金匮要略》将此证分寒呃，虚热、实热。此例寒呃，证属足太阴。乃中阳不振，寒湿内聚，阴寒与胃气相搏于中脘，以致上逆而呃。故不宜见气逆即投降逆平冲之品。今用理中以温中行气，除湿化浊而获效。

28、太阴证胃脘痛

周××，男，61岁。四川郫县某乡，农民。

[病史]胃脘痛二十余年，时吐酸，呃逆。开始几年，服药后可缓解；后十年渐重，饥则时疼。1970年4月，病情进行性加剧，持续疼痛，纳呆， 体虚，便黑。急送××医院治疗，诊为“胃溃疡”、“胃癌待查”。建议手术，但考虑血色素仅4．5克，年老体衰，商定改由中医保守治疗。遂来成都就诊。

(初诊]患者按腹弯腰，呻吟不已；呕吐酸水，时时呃逆，食不下，恶寒肢冷；舌淡、苔白腻浊。证属太阴虚寒邪盛。法宜温中散寒，消淤止痛，以四逆汤加味主之。
处方一：
炙甘草30克 炮姜30克 制附片30克(久煎)
上肉桂10克公丁香6克处方二：
回生丹，日服二次，每次三粒，痛止停服。
(二诊]一周后来诊，疼痛大减，便血止， 泛酸、呃逆明显减轻。以甘草干姜汤加味缓服。
处方：
炙甘草30克炮姜30克 上肉桂10克 砂仁lO克白蔻10克茯苓20克 白术20克服药调养月余，疼痛消失，饮食正常。
1979年7月20日追访：数年来，曾轻度复发一次，服甘草干姜汤加味后愈，未再复发。现已七旬，尚可做一些轻活。
[按语) 《素问?金匮真言论篇》云：“ 人身之阴阳，则背为阳，腹为阴 ”。腹部之病，按其部位，分属太、少，厥阴。太阴为三阴之里，其脉从足入腹，属脾络胃。脾为湿土，阴中之至阴，凡伤于寒湿，则脾先受之。且与阳明胃相表里，脾虚胃亦虚，即所谓胃家不实，便是太阴病。此证显系属太阴虚寒邪盛。始终抓住太阴主证；而太阴温里宜四逆辈，故首投四逆汤加味，兼以行气通络，散滞化淤为治，而病获愈。

29、太阴证水肿
于××，男，4l岁。北京某机关干部。
(病史]全身浮肿十年，近一年加重。出国工作期间，曾患疟疾，服奎宁半年而愈。回国后，1969年到西南山区，在潮润闷热之坑道内工作一年多。逐渐感到全身乏力，肢体沉重，食欲减退，面与下肢开始浮肿。1978年初，病情发展，上肢麻木不能写字，下肢关节冷痛，全身浮肿明显加重。口干，欲大量热饮。小便短少。时而点滴难下，体重由140斤增至174斤。北京××医院诊为 “ 前列腺炎 ”。但水肿原因始终

未查明。
[初诊]1978年8月4日。因一周前参加夏收后，浮肿加剧。面部与四肢尤甚，按之凹陷。神疲，纳呆，腹满，喜热饮，腰痛，阳痿，小便短少。面暗黑无华，舌淡，苔白滑腻。此为太阴脾虚湿郁所致。初因湿热内困，后伤及脾阳，故水液内停；而太阴之伤，又累及足少阴肾，法宜温肾健脾，燥湿利水，以理中汤加减主之。
处方：
制附片30克(久煎) 白术15克 干姜15克 炙甘草12克 茯苓12克 上肉桂6克(冲服)
[二诊]8月18日。上方服十剂， 浮肿减轻，头昏、乏力好转。原方再服二十剂。
[三诊]9月18日。 全身浮肿消退大半，纳增，小便较前通畅。上方加桂枝10克，生姜皮60克，以增化气行水之力。续服十五剂。
(四诊]lO月8日。浮肿基本消退， 诸证均明显好转。为巩固疗效，以理中丸加味缓缓服之。
处方：
党参30克 炒白术60克 干姜60克 炙甘草30克 制附片120克 茯苓60克 上肉桂lO克
十剂
共为细末，水打为丸。日服2次，每次10克。
1979年5月15日追访：服丸药四个多月，病痊愈，体重由170余斤降至140余斤。
[按语] 《素问?至真要大论篇》云：“ 诸湿肿满，皆属于脾 ”。脾乃至阴之脏，少阴又为太阴之母。故肾不主五液，脾不行水，则肿满生焉。本例先后以理中汤加附子等，温补太、少二阴，阳气升，阴霾散，气化行，水湿消，故病获愈。

30、太阴证泄泻(慢性肠炎)
刘××，女，26岁。北京某机关干部。
[病史]从幼儿起，常年腹泻，已迁延二十余载，北京××医院诊断为慢

性肠炎。经中西医长期治疗未愈。1978年8月初来诊，按太阴虚寒证泄泻论治，三诊病愈。

[一诊]1978年8月1日。腹时痛，喜温喜按。下利稀薄，口不渴，不思饮食。神疲体弱，面色苍黄无泽。舌质淡，苔白厚腻。触诊肢冷甚。证属太阴虚寒证泄泻，法宜祛寒除湿，实脾固肾。先以四逆汤，继以理中汤加味主之。
处方一：
制附片60克(久煎) 干姜30克 炙甘草30克
处方二：
制附片60克(久煎) 干姜18克 炒白术24克 茯苓15克 炙甘草30克 上肉桂6克 红枣30克
各五剂
[辨证]《伤寒论》日：“ 自利不渴者，属太阴，以其脏有寒故也，当温之，宜服四逆辈 ”。患者肢冷，口不渴，舌质淡，苔白而厚腻，皆湿寒阻滞之象，为太阴虚寒之证。
太阴在脏为脾，脾主运化，脾虚邪陷，则中阳不振；寒湿不化，气机阻滞，故腹满时痛；脾气不升，寒湿下注，故下利益甚；脾失健运，后天失调，故不思饮食。但必须指出，此证不仅在中州；长期泄泻，不可单责之于脾。所谓“ 五脏之伤，穷必及肾 ”。患者神疲恶寒，面色苍黄，显系下元亏损，命门火衰，肾阳不振。王和安云：“ 但温其中宜理中，温其中兼温其下宜四逆。 ”故一诊即投之以四逆、理中相继为治。
(二诊]8月23日。服药后，腹泻止，精神、睡眠均好转，食量增加。面色略转红润，舌淡红，白腻苔减。多年陈疾，初获显效。但久病后，脾肾阳虚，不能骤复，宜继守原法，效不改方，加减再进。
处方：
制附片60克(久煎) 炒白术24克 干姜18克 炙甘草15克 红枣30克 上肉桂6克(冲服) 茯苓15克
[三诊]8月26日。近半月来，大便趋于正常。上方加减，嘱其续服一段

时间，并注意忌食生冷，防止受凉，以资巩固。
1979年4月20日追访，患者说：自去年8月服药后，从此未再腹泻。

31、太阴证睑废(重症肌无力眼肌型)
文××，女，6岁。卫生部职工之女。
[病史]1976年1月20日晚，家长突然发现患儿眼缝缩小，眯眼斜视。旋即右眼胞下垂，无力睁开，复视。1976年2月，中国人民解放军总医院肌注“新斯的明”试验，呈阳性反应，诊为“重症肌无力(眼肌型)”，待查。同年3月28日，北京同仁医院确诊为眼睑“重症肌无力”。1977年3月29日，转××医院．中医诊治一年。虽曾短暂开大睑裂，但上胞重新下垂后，反复治疗无效。1978年5月10日来诊，按太阴证睑废论治，三月基本治愈，现已巩固一年余。
[初诊)右眼睑下垂而肿，视物困难，复视，午后尤重。面色微黄，乏力。舌质润红而暗；苔白灰黄、根部厚腻浊密布。此系脾湿之邪，蕴积已久，表实未解，上窜眼胞所致。证属足太阴睑废，法宜开闭除湿，宗仲景甘草麻黄汤方意主之。
处方：
麻黄3克 法夏12克 甘草6克
三剂
[辨证]眼睑属脾。脾主肌肉四肢，不仅专司运化水谷之精微，且-仃传导水湿之功用。患儿面黄乏力，乃脾困之象。更以舌象分析，苔虽白黄粘腻，但质淡湿润，显系表实未解，寒邪久闭；脾湿之邪，蕴积益深。眼睑既属于脾，今水湿之邪不得外泄，而循经上窜于眼睑，以致眼睑肿垂，无力开裂，故属足太阴之证。
《金匮要略》云：“里水……甘草麻黄汤亦主之”。吴谦等按：里水之“里”字，当是“皮”字。其意乃皮水表实无热者，则当用此发其汗，使水从皮毛而去。今本其意而变通其法：以麻黄之辛温，开诸闭，驱水邪；半夏性燥而去湿，脾胃得之而健；甘草味甘，火土之色，补太阴大有奇功；配麻黄，更有通利寒湿之效，麻黄、半夏、甘草配伍，辛甘化阳，阳盛则湿消；甘草倍麻黄，化湿而不伤元气。

上方服三剂后，眼皮稍可活动。原方加桂枝，温通经脉，辛以散邪；配杏仁，疏理肺窍，入手太阴以利水之上源。再服一剂，患儿眼睑开裂稍大，后随证加减。
6月初，患儿曾有一整日可略微睁开右眼睑。苔浊腻始退，脾湿稍减。原方损益续服十二剂。
[二诊]舌质转淡红，白腻苔续减。湿浊内困已有消退之象，惟眼睑变化无进展。改服自制“针砂散”，加强疗效(后又以甘草麻黄汤加减配合服)。
处方：“针砂散”方每味10克，共研细末。第一周，每日晨空腹眼一次，每次2克；一周后，三天服一次，每次2克，共服三周。
[三诊]舌质淡红，白腻苔大有减退。脾湿渐化，脉络始通，眼睑开合较前自如。但余邪未尽，应益土行水。本苓桂术甘并小半夏汤方意主之。
处方：
茯苓15克 桂枝6克 白术12克 法夏12克 苍术9克 大腹皮9克
十剂
[四诊]病情大有好转，原患眼午后较重，近日晚间观察，双目基本一致。舌质已正常，白厚腻苔已退。患眼睑稍厚，开裂较正常眼略小。病虽向愈，参之舌象等，尚属脾湿之邪未尽解，输化功能仍嫌不足。亟应抓住转机，健脾化湿，理气和中，助其运化之力，上方加减续服十五剂。
[五诊]1978年8月初，“睑废”基本治愈，视物已正常。惟眼胞仍稍厚，乃脾虚兼湿之象。以五苓散利水健脾，再除余邪。
处方：
猪苓10克 茯苓15克 泽泻10克 白术12克 桂枝6克 五加皮10克
三剂
其后，曾间服上方汤剂；或服剩余之针砂散(有时间隔二、三周服一次)。
1979年3月8日，患儿再赴同仁医院复查：未见异常，为重症肌无力恢

复期。1979年7月18日访问家长，患者眼睑恢复良好。
[按语] 现代医学所称重症肌无力，是以骨骼肌无力为特征的一种神经肌肉间传递功能障碍性疾病。相当于中医之上胞下垂，因其难治难愈，又名“睑废”。目为五官之一，“五脏六腑之精气，皆上注于目”。十二经脉，亦均与眼部密切关联。眼病虽为局部疾患，多由内脏病变而引起，内服药则重于整体考虑。大体说来，此证可分为先天与后天两大类：先天性患者，往往因发育不全而形成，常发于双眼；后天性多由于脾弱气虚，脉络失和等所致，常发于一目。本病例，当属后者。
本例睑废，以六经辨证应属太阴证。太阴者，土也。在脏为脾，在气为湿。寒邪侵入太阴与湿相搏，于是寒湿阻滞经络，精微物质不得上呈，眼睑失养，以致上胞肿垂，无力开合。寒湿内困于阴土难以消除之际，仅用补中益气，升阳举陷之常规方药，不能除其寒湿之邪，故效果不显；应散寒除湿以祛邪，脾阳得伸，运化复常，精微物质得以上呈，此才是治病之本。故遵仲景太阴病亦可以从外而解之变法，“于寒湿中求之”。先投以甘草麻黄汤，促使邪从皮毛速去(现代医学认为，加注麻黄素亦可加强“新斯的明”疗效)；并以五苓散除余邪而收功。

32、太阴少阴证睑废(重症肌无力眼肌型)
撒××，女，17岁。北京市中学生。
[病史]1978年4月22日，忽觉眼不能睁，视物双影，眼胞肿胀不适。在首都医院检查，做“新斯的明”试验和肌电图检查，确诊为“重症肌无力眼肌型”。转××医院治疗，服中药半年余，未获效。同年10月18日来诊，经治五个月，眼睑开始恢复正常。
(初诊]左眼胞下垂，无力睁开。双眼胞皆浮肿，双膝关节疼痛，月经色暗，有乌黑淤血块。面色萎白无华，额面部湿疹较多。唇色淡白，舌淡暗微红，边缘有齿痕，苔灰白夹淡黄，根部厚腻而紧密，脉沉细。此为太阴少阴合病睑废，兼有太阳表邪未去，先宜温经解表为治，以麻黄细辛附子汤加味主之。

处方：
麻黄10克 制附片30克(久煎) 辽细辛3克 桂枝6克 炮姜20克 血余炭20克 甘草15克
[二诊]服上方二剂，关节痛稍减。眼肌有轻微跳动感。苔转灰白腻，余证如前。精神萎靡，四肢不温，虽值年少，但肾阳小足，须从根本入手，峻补先天，以四逆汤主之。
处方：
制附片60克(久煎) 干姜片30克 炙甘草30克
[三诊]上方服三剂，眼肌颤动消失，眼胞浮肿稍减。左眼睑仍重垂无力。宜温补脾肾，助阳驱阴，拟四逆并理中加减再进。
处方：
制附片60克(久煎) 干姜片30克 炙甘草15克 炒白术25克 茯苓25克 上肉桂lO克(冲服) 生姜60克
[四诊]原方出入增减，每日一剂，坚持服二月余。至1979年1月1日，左眼睑有两次短暂开裂，前后持续约一小时。仍遵原法，四逆、理中交替使用，或合为一方。当月经不调．夹紫黑血块，则加炮姜、血余炭；兼有表证，则加麻黄、桂枝等，又服两月余。
[五诊]1979年3月初，左眼上胞下垂明显好转，眼睑已能睁开，比正常略小，双眼胞尚有轻度浮肿。左右眼视物，常不能协调。面额部湿疹明显消退。经色转为正常，但有少量淤血块。食纳尚可，舌质稍转淡红润，苔薄白。逐渐阳复阴消，仍有脾肾阳虚之象。以理中汤并桂枝去芍药加附子汤损益调理。
处方：
桂枝10克 炙甘草15克 生姜30克 红枣30克 炒白术20克 茯苓20克 制附片30克(久煎)
上方随证加减，并用苓桂术甘汤、小半夏汤、针砂散等配合使用。1979年4月以后，偶有双眼视物不协调，双眼上胞轻微浮肿。继续调理，以期巩固。
[按语] 文例与本例，西医辨病均属“重症肌无力眼肌型”；但按六经

辨证，则有所不同，故其立法处方，也随之而异。
前例睑废，证属太阴，脾困于湿，主要病机在于水湿溢于经络肌肤，不得外泄，而上串于眼胞，以致眼睑肿垂。此例属太少二阴合病，脾肾阳虚，病在于脾，根在于肾。其眼睑下垂，眼胞浮肿，面色萎白，月经色暗而有淤块，舌现齿痕而苔灰白厚腻，均为脾阳衰弱，脾虚湿胜，运化失权，下不能温经血于胞宫，上不能输精微于眼睑；而精神萎靡，四肢不温，舌淡脉沉微，显系肾阳衰惫，阴气弥漫，五脏之伤，穷必及肾；肾气之伤，又令脾失温养。虽辨病均属睑废，但辨证论治同中有异。因此，本例不仅不能重复补益中州，升阳举陷之常规；而且不能简单再遵文例“太阴病亦可从外而解之变法”。必须峻补元阳，温肾健脾为治。这正体现了祖国医学辨证施治，辨证与辨病相结合，同病异治，异曲同工之妙。

33、太阴少阴证痉病
郝××，女，22岁。重庆市某厂管理员。
[病史]1959年7月，因高热昏迷。送往某医院急诊。经用退热药，高烧不减，再以物理降温，仍无效。未明确诊断。遂出院，请中医治疗，当日服药两剂热退，渐清醒。但次日晚又陷入昏迷。送××医院抢救，当即下病危通知，亦未能确诊，急邀某老中医会诊，服中药后，病情又逐渐好转。老中医认为，脑中有淤滞。转××医学院检查拍片，果然发现颅内确有淤血，遂手术脱险。一月后，手足抽搐，下半身发凉；出院用中药医治，断续有五．六年之久，其效不显。1965年专程来蓉求诊，治疗三月基本痊愈。
[初诊]右半身手足抽掣，发作时口眼歪斜。每月约五、六次，抽搐前有预兆，先觉右侧身麻。近几年来，特别畏寒，六月炎暑，身穿毛衣，四肢仍厥冷。月经不定期，色暗淡。视力减退，恍惚不清，记忆与反应力均显著减弱、迟钝。神疲，纳呆。舌淡，少苔而灰白，脉沉细。此为大病之后，气血亏损而致痉，病属太、少二阴，宜先温中健脾，调和气血，以小建中汤主之。
处方：

桂枝12克 炙甘草6克 白芍15克 生姜30克 红枣15克 饴糖60克(兑服)
六剂
[二诊]服上方六剂，十日来，手足抽掣只发作过一次，发作前身麻减轻，精神和食欲均有好转。仍畏寒，肢冷，经水不调，阳气不通达于四肢。为除血虚寒凝，宜温经宣络，通脉养血为治，以当归四逆汤加味主之。
处方：
当归10克 桂枝12克 白芍10克 辽细辛15克 甘草6克 木通6克 大枣20克 吴茱萸6克 炮姜15克
八剂
(三诊]上方进八剂，半月内抽搐未再复发。畏寒肢冷减轻，食欲稍增。月信刚至，色暗淡夹紫黑色血块较多，小腹痛。宜温脾肾，散寒滞。
处方：
炮姜60克 血余炭30克 炙甘草30克 制附片30克(久煎) 当归12克 吴茱萸6克
六剂
(四诊]服六剂后，病情稳步好转，以理中汤加味，继续调治。
处方：
党参15克 干姜12克 炒白术12克 甘草10克 制附片30克(久煎) 茯苓12克 砂仁10克 白蔻10克 枸杞15克 菟丝子20克 桂枝10克
上方加减，约服两月余，身体基本康复。1979年7月，闻范老从京返蓉休息，专程来访致谢。自述病愈后，回家调养约两年，逐渐巩固至今，未曾复发。
[按语] 本例发病之初，病情危重复杂，未明确诊断，几经数家医院中西医治疗，度过危险而余证迁延数年不愈。转来就诊时，按其证，神疲，畏寒，四肢厥冷，半身及手足抽引，舌淡，脉沉细，应属太阴、少阴脾肾阳虚；按其病，大病之后，气血皆虚，筋脉抽动拘急，发为痉病。正如《素问?至真要大论篇》云：“ 诸寒收引，皆属于肾 ”。

《灵枢?经筋第十三》云：“ 足少阴之筋 ”，其病“ 主痢瘛及痉 ”。本例辨证施治，体现了六经分证与辨病相结合；抓住主证，明晰病机；分清主次缓急，论治有先后。因而使迁延多年之宿疾，迅速向愈。

34、太阴少阴证崩漏(功能性子宫出血并发失血性贫血症)

吴××，女，43岁。新华社工作人员。

[病史]自1971年，因失眠与低血压时而昏倒，当时未予重视。1975年以后，发病频繁；尤其是经量多、间隔短，长期大量失血，不能坚持工作。先后经北京数家医院均诊断为“ 功能性子宫出血 ”并发“ 失血性贫血症 ”。曾转外地医院，诊断如前，经治疗无效。1978年6月12日来诊，按太阴少阴同病论治。前后治疗四个月，诸证痊愈，恢复工作。

[初诊]行经不定期，停后数日复至，淋漓不断，色暗淡，夹乌黑淤块甚多。头痛、浮肿．纳呆、踡卧，失寐惊悸，气短神疲，肢软腹冷，恶寒身痛。面色苍白，形容憔悴。舌质淡，苔白滑，根部微腻。脉沉而微细。乃太阴少阴证崩漏。法宜温经散寒，复阳守中，以甘草干姜汤主之。

处方：

炮姜30克 炙甘草30克

三剂

[辨证]患者面色苍白，少腹冷痛，食少纳呆，舌淡苔白，皆足太阴脾亏损之证。脾主中气，统摄血液。脾气既亏，则血溢下流。且脾为生化之源，后天之本。脾气虚，则不能正常消化吸收营养物质。故本例崩漏，首责太阴虚寒，不能摄血归经。

崩漏失血，与足少阴肾关系尤为密切。因少阴肾为冲任之本，专司封藏。封藏不固，则冲任失守。患者恶寒踏卧，四肢清冷，脉沉微细，皆命门火衰，阴寒内盛之象。肾阳虚损，固摄无权，故月事不定而下，持续不断。阳气不振，不能温化血液，故下血暗淡，淤块甚多。腰为肾之外府，肾虚并湿寒阻滞，故腰背骨节酸痛。肾生髓，脑为髓海，肾虚则髓海不足，故头昏目眩。同时病入少阴，损及手少阴心，

故心悸怔忡，气短神疲，睡卧不安。加以漏下失治，失血耗血过多，妇女本以血为本，长此以往，终于病卧难支。此病关键在于心肾阳衰，阴寒内盛，脾肾虚寒，中阳不振。法宜扶阳祛阴，引血归经，从崩漏之根本入手，投以甘草干姜汤施治。

(二诊]服药后胃口略开，仍恶寒身痛。继以甘草干姜汤合麻黄附子细辛汤，温经散寒，表里兼治。

处方：

炮姜30克 炙甘草30克 麻黄9克 制附片60克(久煎) 辽细辛3克

上方随证加减，附片加至每剂120克，炮姜120克，共服二十五剂。

[方义]甘草干姜汤，《伤寒论》原治太阳病阴阳两虚之变证，《金匮要略》以主肺痿之属于虚寒者；后贤借治失血，引血归经。干姜辛温，辛与甘和，则从阳化；干姜炮黑，其味即苦，苦与甘和，则从阴化。今取其甘以化热，守中而复阳，阳升则能统血；取其苦甘以化阴，则阴血得养。《直指方》说：“甘草干姜汤，治男女诸虚出血，胃寒，不能引气归源，无以收约其血。”故本例选用此方。今合麻黄附子细辛汤，因有寒中少阴之象，而复连太阳之邪。以附子、细辛，专温少阴之经；麻黄得附子之助阳托里，俾外邪之深入者可出，而阳气亦不致随汗而越。再与甘草干姜汤合而用之，更有相得益彰之妙。

[三诊]全身浮肿渐消，畏寒蹑卧、头痛身痛均好转。崩漏止，月事趋于正常，淤块显著减少。舌质转红，仍偏淡，苔白滑，根腻渐退。病已明显好转，阳气渐复，阳升则阴长；但仍有脾湿肾寒之象。法宜扶阳和阴，补中益气。以甘草干姜汤并理中汤加味主之，随证增减，共服四十余剂。

处方：

制附片60克(久煎) 干姜15克 炙甘草30克 党参30克 炒白术24克 茯苓20克 炮姜30克 血余炭30克 上肉桂10克(冲服) 鹿角胶6克(烊化)

至1978年10月中旬，月经周期、经量、经色已正常，诸证悉愈，恢复全日工作。春节前后，因任务急迫，每日坚持工作十二小时以上，自觉精力旺盛。1979年3月临出国体检时，均属正常。

(按语]“妇人之生，有余于气，不足于血，以其数脱血也”。患者长期漏下，大量失血，已虚衰难支。必须从病根入手，方能奏效。李东垣云：“凡下血证，无不由于脾胃之首先亏损，不能摄血归源”。张景岳云：“凡见血脱等证，必当用甘药先补脾胃以益发生之气……则阳升阴长，而血自归经矣”。结合患者舌象脉证，其长期漏下失血，首“属太阴，以其脏有寒故也”。为此，始终以温脾为主，连用甘草干姜汤，守中而复阳，以摄血而生血。

再者，三阴证虽无合病、并病之名；但临床所见，三阴经证亦多交叉出现。本例患者即由脾胃虚寒性之太阴证未愈，进而发展为全身虚寒性之少阴证。肾阳虚衰，封藏无权，导致冲任不固而崩漏下血不止。为此，复以太阴少阴同病辨证论治。

又患者少阴里寒，并外连太阳之证；阴阳两经，表里皆病。里寒宜温，表实当解；而三阴表法，又与三阳不同。“三阴必以温经之药为表，而少阴尤为紧关”。故以散邪温经之剂主之，并重用附子至120克。《金匮要略》曾载：一妇人怀娠六、七月，脉弦发热，似有表证。而其少腹恶寒之状，如扇风之侵袭。所以然者，因其人阳虚子藏开．寒邪侵入。故仲景以“附子汤”温子藏而驱寒。但可惜此方早已失传，现存经文亦不纯，必有残缺。李 彣 注：按子藏即子宫。尤怡曰：附子汤未见，然温里散寒之意概可推矣(《订正仲景全书》)。关于本例漏下诊治，一再重用附子者，亦即仿效仲景佚方之意。

35、太阴少阴证嘴眼畸形

傅×，男，15岁。重庆市某中学学生。

[病史]患儿从小身体较好，在校一直为“三好”学生，喜爱文体活动。1974年春，家长发现患儿时常噘嘴，眼珠略向外鼓，性急躁。同学见之，或说故装怪象，或取“翘嘴”、“八戒”等绰号。虽经家长、老师一再纠正，患儿反变得日益畸形怪状：双唇外翻，越翘越高，两眼稍突，不愿平视。白日想方设法遮其丑。入睡嘴唇仍高努不收，并逐渐发展到睡眠减少，食欲下降，记忆力显著减退。尤其畏惧他人视其面，出门则紧压帽沿，戴大口罩。如有人指点其状，则忿忿

不已，忧心忡忡。对医生之检查、询问，异常反感，稍有触犯，则拒绝就诊。其后，病情益重，神情举止异常：时伫立窗前，盲目向外凝视；甚至以嘴唇触室内墙壁，直至出血染印。低处尽染，再爬上桌椅，登高用嘴唇触之，室内满墙竟染成斑斑血印。家人见此，为之骇然。

开始在重庆××医院，经内科、口腔科、神经内科、脑外科、新医科和精神科等科检查，皆无结果，病因不明。1974年8月，曾转数处中医院求诊，分别按“风毒”、“邪风入络”、“肝火”及“水湿伤肾”论治，服药百余剂，均未获效。1975年初，转成都××中医院，诊其病因，一日风，二日脾．“脾僵则唇翻眼鼓”。同年1月底，遂转来求诊。

[初诊]1975年7月25日。患儿嘴唇翻翘， 高高努起。双眼上胞浮肿，眼珠微突，似睁似闭。神情忧郁，沉默寡言，坐立不安。纳差，便溏，四肢清冷，面色萎黄，舌质淡，边缘有齿痕，少苔。范老沉思良久日：此病罕见，应属足太阴寒邪凝滞，脾阳受戕；并因失治误治，损及少阴心肾，试投四逆汤以温之。

处方：

制附片30克(久煎) 干姜30克 炙甘草18克

四剂

[辨证]祖国医学认为：眼胞属脾，脾主肌肉，肌肉之精为“约束”(即眼轮匝肌)。《素问?五脏生成篇》又明确指出：“脾之合肉也，其荣唇也”。《素问?六节脏象论篇》云：“其华在唇四白”。今患儿眼睑浮肿，嘴唇翻翘高努，参看食欲不振，面色萎黄，少苔，显系脾阳衰败，阴寒凝聚，外现为眼胞与嘴唇之病变，甚则呈僵鼓之异状，不能收缩自如。故证属足太阴。

患儿阳气之伤，阴寒之甚，还表现于： 四肢清冷，神靡，烦躁，失寐，甚则神态呆滞，举止异常，参之舌象，此为太阴寒极，传及少阴，心肾皆伤。而少阴本有但欲寐，恶寒踡卧之证；但亦有烦躁，不得卧之变证。后者多因失治误治，失于急温所致；乃肾中真阳不潜，

心气亏耗，阳虚而扰乱不宁，病情尤重。故本例兼属少阴坏病。
可见，此病虽奇，而其特点在于“其脏有寒”。治疗之正法，首“当温之”。前人曾说：“盖脾为后天，肾为先天，少阴之火所以生太阴之土。脾为五脏之母，少阴更太阴之母。与四逆之为剂，重于理中也。”(《伤寒附翼?太阴方总论》)故首用四逆汤回阳救逆，急追欲失之元阳，峻逐凝聚之群阴。
[二诊]1975年1月29日。服药后无不适之感，诸证无明显变化。中州沉寒已久．坎宫生气衰弱亦甚，宜四逆与理中合剂，损益续服。加上肉桂、辽细辛，以增峻逐寒凝之力。
处方：
制附片30克(久煎) 干姜30克 炙甘草18克 白术18克 茯苓15克 上肉桂10克(冲服) 辽细辛3克
四剂
[三诊]2月5日。食欲略增，睡眠稍好。中焦沉寒，必致气血生化乏源，阴阳俱虚。在温里逐寒，峻补命火之同时，亦须调补阴阳，培土益气。拟黄芪建中汤再服。
处方：
桂枝10克 白芍10克 炙甘草3克 生姜30克 大枣10枚 黄芪15克 饴糖60克(兑服)
十剂
[四诊]2月19日。食纳增加，神靡恍惚之象好转，不再用嘴触墙壁。但唇翻眼鼓，上胞浮肿，仍无改变。此为脾僵土亏，阳衰阴盛，寒湿凝聚，蕴积已深，改投大剂四逆。加桂枝、麻黄，并重用生姜，通凝聚之寒湿，开气血之痹阻，使之外达；因重用干姜、附片，则无发汗伤阳之虞。再加童便为反佐，引药下行，兼取其消淤之效。
处方：
制附片120克 干姜60克 炙甘草30克 桂枝18克 麻黄18克 生姜240克
童便为引
[五诊]2月28日。皮现红疹。眼胞浮肿略消，神情呆滞好转，余证同

前。改用自制不二丹，开窍散淤。另加砂仁30克、白蔻30克、草果30克共为细末，饭后冲服少许，健脾行气，温中燥湿。
[六诊]3月9日。红疹消，食纳增，病情稳定。再以大剂四逆汤加昧，大补命火，峻逐阴寒。
处方：
制附片120克(久煎) 干姜60克 炙甘草60克 桂枝30克 麻黄12克 生姜60克 童便为引
三剂
[七诊]3月13日。便溏、肢冷好转。入睡后，唇翻嘴翘之象略平。再以黄芪建中汤，调补阴阳，培土益气。
处方：
桂枝10克 白芍10克 炙甘草3克 生姜30克 大枣10枚 黄芪30克 饴糖60克(兑服)
八剂
[八诊]3月26日。病情无明显变化，为增强通阳行气之力，重用桂枝，再加葱白；为峻补命门，益火消阴，制附片加至250克，另加上肉桂以助之；汤剂共服30余剂。间服砂仁、白蔻，以增温中健脾之效；再配合服自制“坎离丹”，调补阴阳，温肾逐寒，养心安神。
处方一：
制附片250克(久煎) 干姜120克 甘草120克 桂枝30克 上肉桂10克 葱白250克
处方二：
砂仁30克 白蔻30克
共研细末，饭后冲服2克
处方三：
川附片三份半 上肉桂一份 真琥珀二份 柏子仁二份 飞朱砂一份 麝香半份
共研细末，水打丸。每日一次，每次3—4粒。
[九诊]5月8日。唇翻嘴翘、眼胞浮肿显著消退，神情举止日渐正常，

畸形怪状基本消失。舌质稍现红润，苔薄白，边缘略有齿印。阳气渐升，出现沉疴向愈之佳兆，虑其脾僵肾寒日久，宜四逆、理中加味续服。
处方：
制附片120克(久煎) 干姜60克 炙甘草30克 白术18克 茯苓20克 黄芪20克 红枣30克 上肉桂10克(冲服)
服四剂，间隔数日再眼
[十诊]10月20日。上方随证加减，服40余剂，诸证愈。遂停药，以自制不二丹养心安神、化淤通窍、燥湿健脾，缓缓服之，并注意忌食生冷，以巩固疗效。
1979年5月，患者父亲来信说：病愈以后，三年多来，身体日益健壮，智力恢复良好。学习成绩已跟上高中快班。现身高1．75米，体重124斤，已成为校足球运动员。
[按语] 此例太阴少阴证嘴眼畸形，临床诚属罕见。“ 其脏有寒 ”，温之以四逆辈，间以建中之补而愈者，乃遵仲景之法度也。
《伤寒论?太阴篇》云：“ 自利不渴者，属太阴，以其脏有寒故也，当温之，宜服四逆辈 ”。此条固然原以不渴一证，识太阴，辨寒热自利，实则已括尽太阴里寒之形成与治法。其“ 脏 ”，虽主要指太阴本脏，有的注家曾指出，亦可泛指诸阴经有“ 寒 ”。故可有双重涵义：一为里寒、属阴、属虚，指机能衰退，寒邪凝滞，以致运化失职，诸证丛生；一为失治误治，脾阳受戕，寒气陷入太阴。前医曾正确提出：“ 脾僵则唇翻眼鼓 ”。这对于明确诊断，具有重要意义。但关键在于，如何进而掌握其传变规律，辨证施治。
以六经传变而论，太阴寒邪是否可循经而传?这一问题，古今注家争论颇多。清?吴谦等认为：“ 自后汉迄今，千载以来，皆谓三阴寒邪不传……是皆未曾熟读仲景之书，故有此误耳 ”(《订正仲景全书伤寒论?太阴全篇》)。证之临床，本例即由太阴湿土寒极，失于急温，以致病传少阴者。虽出现“ 心中烦，不得卧 ”等证，但又与少阴热化证异。实为肾阳不潜，心气亏耗，太阴寒邪传入少阴。仲景治疗“ 其脏

有寒 ”，正法即 “ 当温之 ”，主方不外四逆辈。故本例首选四逆汤，并理中合剂，或间服建中者，皆温之、补之之意。可见疾病纵然千奇百怪，人之形脏又厚薄虚实不一，但归根到底，仍不离三阴三阳之传经变化规律。诚然，若临床掌握这一根本，“ 虽未能尽愈诸病，庶可以见病知源 ”。常见之病如此，罕见之怪证焉能例外!

36、太阴少阴证虚劳(脑血管硬化、美尼尔氏综合症)

李××，女，48岁。成都某厂家属。

[病史]患头痛，眩晕约十年。1971年3月，病情逐渐加重，经常昏倒，头晕如天旋地转，并发展到头项及四肢僵直，俯仰伸屈不利，身觉麻木，一年中有半载卧床不起。1974年6月专程赴西安某军医院，经内科、骨科、神经内科和神经外科检查，确诊为 “ 脑血管硬化 ” 及 “ 美尼尔氏综合症 ”。后转回成都，病情未见好转。同年11月前来就诊。

[初诊]已卧床不起，神志不清，心悸气喘，呼吸困难，头剧痛频繁，自觉似铁箍紧束，昏眩甚则如天地旋游。头项强硬，手足厥冷，全身浮肿，不欲食，三天来只略进少许流质。两手麻木，感觉迟钝，小便短少，大便先秘后溏。经期紊乱，每月三、 四次，色暗黑，血块甚多。面色苍白，眼胞双颧浮聃，，眼圈乌黑，舌质暗淡，苔白滑浊腻，脉微细。此证属太少二阴，脾肾阳虚日甚，已成虚劳。法宜调阴阳，利气化，’逐水饮，以桂枝去芍药加麻黄细辛附予汤主之。

处方：

桂枝10克 生姜60克 甘草30克 大枣30克 麻黄lO克 辽细辛6克 制附片60克(久煎)

三剂

[二诊]上方服三剂，神志渐清，头剧痛减，可半卧于床，原方再服八剂。

[三诊]身肿、手麻稍有好转，神志已清；仍头痛眩晕。肢体尚觉沉重，稍动则气喘心累。苔腻稍减，病有转机；唯阳气虚弱，阴寒凝滞已深。方药虽对证，力嫌不足。原方附子加重至120克；另加干姜、炮姜各60克，以增强温经散寒，祛脏腑痼冷之效。连进十剂，头痛、眩

晕著减，可起床稍事活动。原方附子减至60克，去干姜、生姜，再服十剂。
[四诊]头痛止，尚有轻度眩晕。活动稍久，略有心悸气喘。浮肿已不明显，头项及四肢强直感消失，四肢渐温，食纳增加，诸证显著好转。但痼疾日久，脾肾阳虚已甚，须进而温中健脾，扶阳补肾，兼顾阴阳，拟理中汤加味缓服。
处方：
党参30克 干姜30克 炒白术20克 炙甘草20克 制附片60克(久煎) 茯苓20克 菟丝子30克 枸杞20克 鹿角胶30克(烊) 龟板胶30克(烊) 上肉桂12克(冲服)
服上方月余病愈。1979年12月25日追访：患者谈到治病经过，精神振奋，五年来病未复发，并承担全部家务劳动，身体如常。
[按语] 此例迁延日久，病情复杂，酿致沉疴，而出现多种衰弱证候，故病属虚劳。按六经辨证，其手足厥冷，心悸神靡，食不下而自利，舌淡苔白，实为太阴、少阴同病，一派阴气弥漫。进而剖析，头目昏眩，痛如紧捆；全身浮肿，上肢麻木不仁；自利稀溏。此为阴气上腾，阳气下陷，阴阳相隔，气血无所统制，水饮搏于气，壅滞于周身，《金匮要略》桂枝去芍药加麻黄细辛附子汤方，原主“气分，心下坚……水饮所作”。尤怡注：“气分者，谓寒气乘阳气之虚而病于气也”。“不直攻其气，而以辛甘温药行阳以化气”。工藤球卿云：曾用此汤治多种气血虚损坏病，每获奇效……。据金匮阴阳相得，其气乃行，大气一转，其气乃散，故拟用此方也(《方函口诀》引)。今变通用于本例，以寒气乘阳之虚而病于气之理，温养营卫，行阳化气，助阳化饮，发散寒邪，诸证自当迎刃而解。

37、太阳少阴证头痛
李××，男，48岁。解放军某部老红军。
[病史]1957年12月，患剧烈头痛，夜间尤甚。痛时自觉头部紧缩似鸡蛋大小，如铁箍紧束，不能入睡。在四川××医院住院八个多月，病因不明，按“神经官能症”治疗。每日服安眠药强行控制。出院后，头

痛复发时，又增肩背痛楚如缚。后转部队××医院，采用睡眠疗法等治疗。又入××医院，按“癔病”论治。病情未见好转，被迫全休。每日剧痛发作一至数次。发展严重时，舌强目呆，手不能抬，脚不能移，说不出话。1965年来诊。

[初诊]头剧痛，连及肩背，每日发作数次。神衰气短，四肢无力，手足不温，经常下利。面色萎黄，舌质暗淡，苔黄夹白，根部厚腻。此为太阳少阴证，多年陈寒凝聚已深，表里之邪交织难解。法宜扶阳解表，峻逐阴寒。以麻黄细辛附子汤加味主之。

处方：

麻黄10克 制附片60克(久煎) 辽细辛6克 桂枝12克 干姜60克 生姜120克 甘草30克

[二诊]上方连服十余剂，头痛减轻，余证同前。病重药轻，熟附久煎，难奏其功。遂令将上方加倍重用附子，改久煎制附片为略煎(煮沸后二十分钟下群药)。嘱其尽量多服，若身麻，甚则失去知觉，不必惊骇，任其自行恢复。

处方：

麻黄10克 制附片120克(略煎) 辽细辛6克 桂枝12克 干姜60克 生姜120克 甘草30克

患者遵法服之，服后等待药性发作。半小时后，信步庭院，忽然倒下。被家人抬进卧室，很快清醒。除全身发麻外，无明显不适。起身后，又倒在地上，口中流出不少清泫粘液。数小时后，逐渐恢复常态。间隔数日，依上法又重复一次。从此，多年剧痛明显减轻，头、肩、背如紧箍重压之苦，皆如释。其后将初诊方附片久煎又连续服用两月，病遂基本治愈。十余年来，未再复发。

1979年10月31日追访：患者已年逾花甲，谈笑风生，介绍二十年来患此奇病之种种经历，不胜感慨之至。

(按语] 此例头部之剧痛，如绳索捆绑，似头戴“紧箍”之状，乃寒湿之邪久聚，循太阳经入里，日积月深而不解。此所谓“寒中少阴之经，而复外连太阳”。以麻黄细辛附子汤加味，峻逐表里寒湿之凝

滞。钱潢称此方为“温经散寒之神剂”，实临床经验之谈。

38、太阳少阴证胸痹

陈××，女，32岁。成都某乡，农民。

[病史]1g76年8月，妊娠期外感，头疼，身痛，失眠，尤以胸背疼痛、胸中满闷为甚。因怕服药动胎早产，未治疗。产后七日，正值地震，露宿于外，病势加剧。先后到省市数处医院胸透，并作心电图、超声波等检查，均无异常，诊为“神经官能症”。1977年11月初来诊。

[初诊]胸部疼痛年余，痞满不舒，呃逆气阻。畏寒头昏，耳如蝉鸣，骨节酸痛，纳差，多梦，行经腹痛，淤块甚多。舌质偏淡，苔黄滑。此为产前感受外邪，产后血海空虚，又受寒湿侵袭，寒凝气滞，胸阳痹阻，清阳不升，故出现胸痞，头晕、耳鸣、失眠，身痛等证，亦即俗称之“月后寒”。法宜助阳化气，温经散寒。以桂枝去芍药加麻黄细辛附子汤主之。

处方：

桂枝lO克 炮姜30克 甘草15克 大枣20克 麻黄10克 制附片60克(久煎) 辽细辛6克 吴茱萸10克三剂

[二诊]上方服后胸痛减，头晕耳鸣好转，仍觉身痛，经前小腹冷痛。少阴阳虚，风寒湿郁闭未解，原方加减，兼佐活血化淤之品以调其经血。

处方：

桂枝10克 炮姜30克 炙甘草12克 麻黄10克 制附片30克(久煎) 吴茱萸10克 血余炭30克 当归10克

嘱此方服至经行即止。

[三诊]上方服至四剂，月事来潮。经色、经量、疼痛均大有好转，胸痛、头晕、耳鸣、体痛、失眠、纳呆亦明显减轻。原方去炮姜、血余炭、吴茱萸，加茯苓安神渗湿之品。

处方：

桂枝10克 生姜30克 炙甘草12克 大枣20克 麻黄10克 制附片30克(久煎) 辽细辛3克 茯苓15克 当归10克

上方服十余剂后，病基本治愈。1979年7月20日追访，近年来身体一直良好。
[按语] 《金匮要略?水气病脉证并治篇》云：“ 气分，心下坚，大如盘，边如旋杯，水饮所作，桂枝去芍药加麻辛附子汤主之 ”。本例并无“ 心下坚，大如盘 ”之证，又非单纯水气所作，为何移用之?因此证系真阳不足，寒湿之邪乘产后阳虚而逆僭清阳之位，故不必拘泥“ 坚 ”与“ 盘 ”及水气之轻与重，亦可辨证投以本方。既解太阳之邪，又温少阴之经。阳气升，气化行，寒凝解，胸痹诸证自平。

39、太阳少阴证瘿病(甲状腺左叶囊肿)
宋××，女，36岁。成都市某厂工人。
[病史]体质素弱，常患感冒。1977年5月，患外感咳嗽，服清热止咳中药数剂后，表证解。但越数日，忽发现颈部左侧有一包块，约2×3厘米，触之稍硬，随吞咽活动，无痛感。自觉心累，无其他明显症状。曾注射青霉素，服消炎药，后加服中药。同年6月，经××医学院附院诊断为“ 甲状腺左叶囊肿 ”，建议手术治疗。患者未接受，同年7月初转来求诊。
[初诊]左侧颈部出现包块已两月。神疲乏力，食欲不振，入夜难寐，手足清冷，恶寒，头昏。舌暗淡，苔淡黄而腻。此为瘿病，主证在少阴，兼太阳伤寒之表，法宜扶正驱邪，温经解表，以麻黄细辛附子汤加味主之。
处方：
麻黄10克 制附片60克(久煎) 辽细辛6克 桂枝10克 于姜30克 甘草30克
三剂
(二诊]上方服三剂后，包块开始变软，心累乏力略有好转。药证相符，重剂方能速效。上方姜、附、草三味加倍，再服三剂。包块明显变小，舌质稍转淡红，苔黄腻减。又以初诊方续进十剂，包块逐渐消失。
1979年7月13日，患者来信说：服药十余剂颈下包块消失，食欲睡眠大为好转。两年来未再复发。

[按语] 本例患者颈侧长包块，触之硬结，不与皮肤粘连，皮色如常，随吞咽而动，系瘿病之主要证候。《灵枢?寒热篇》谈及寒热瘰疬、鼠瘘之类，病在颈腋者，其病理之本：“ 皆在于脏，其末上出于颈腋之间 ”。本例瘿病，正是如此。太阳与少阴相表里，风寒湿邪，日久深入少阴，表里同病。阳气渐衰，营卫不固，寒凝气滞，日益壅于颈侧而成结。故此案未泥于一般瘿肿多属痰气郁结，或火郁伤阴之常规。以太阳少阴证论治，温经解表，以畅气血；通阳散寒，以开凝聚。同样可收软坚散结之效。

40、太阳少阴证咳喘并二便失禁(慢性气管炎、肠炎、尿道萎缩)

叶××，男，68岁。成都市居民，盲人。

[病史]患慢性气管炎十余年，经常头昏头痛，咳喘痰多，不能平卧；其后，二便失禁五、六载，每日大小便约二十余次，每解小便，大便即出，时稀时秘。成都某医院曾诊断为慢性支气管炎并发感染、慢性肠炎、尿道萎缩。经常服用氨茶碱及多种抗菌素等，病情未见改善，自觉全身发凉，四肢乏力，恶心呕吐不已。1975年转某院就诊，曾服清热中药及抗菌素后，至深夜，忽感心烦，四肢冰冷，大小便顿失控制，神志昏迷约半小时方苏醒，数日后又出现口眼歪斜，诊断为“ 面神经麻痹 ”。经针灸治疗，口眼歪斜有好转，余证如故。长期病魔缠身，痛苦不可言状。1975年12月来诊，按太阳少阴同病论治，服药两月基本痊愈。

[初诊]时腹痛，每日大便频繁，常呈灰白粘液；间有秘结，如筷头状，临厕努挣，憋胀难忍。小便淋漓不尽，量少刺痛，欲解而不畅。咳嗽、痰多，稀白。心累喘急，只能半卧；头昏头痛，恶寒乏力，四肢清冷。面色苍白，体虚胖。舌质淡，微紫暗，前半部无苔，舌根部白腻夹黄而厚，脉沉微。此为太阳寒实郁久，阴邪深结于脏，肺失肃降，肾气内伤，下焦不固，以致二便失常。乃少阴寒化，兼太阳表实证。法宜内护元阳而散寒，外开腠理而固中。以麻黄附子甘草汤主之，

处方：

麻黄10克 制附片30克(久煎) 甘草15克
四剂
[辨证]患者早年双目失明，生活艰苦无人照顾，以致沉疾迁延，病情日益复杂，阴阳及表里虚实交错；患者面苍白，舌质偏淡微现紫暗，苔白厚腻；加以脉沉微，肢冷、恶寒、心累、乏力，显系心肾阳衰，气血不足。应属阴、寒、里、虚，病入少阴之证。
察其腹胀痛之证，虽非阴证虚寒所独有，但阳证实热则与此又不同。本例腹胀，时痛时止， 时利时秘，恶寒无热，口不渴；舌质淡，前半部无苔，舌根部白滑而腻，显然，此为阴盛腹痛胀满之象。
二便失其约制，又与热迫大肠或热结旁流而下利者不同。患者多年来时溏时秘，常有便意；秘而并不坚硬，溏而排泄不尽。解小便时，大便憋胀欲行；解大便时，小便复觉淋漓不尽。由此可知，此证当属少阴寒化，下焦失固之二便失禁无疑。
病入少阴，必损及心肾与膀胱诸脏腑。以本例而言，其根本首在肾阳虚衰。今久病之后，肾气日衰，开阖失司，二便排泄随之失调。肾累及脾， 脾失健运，故更增腹胀满。脾湿盛，致大便色白；上泛为痰，阻塞气机而咳嗽痰多。肾之元阳衰微，必影响肺气之肃降，加重气机之不畅，致使患者不能平卧：此乃患者多年以来，诸证蜂起，相互缠绵，迁延不愈之病根。
患者初诊时，恶寒、头痛，舌质淡润而苔白夹黄，乃兼有太阳外感表实之邪。单解表则里证不去，单治里则表实不解。为此，投以麻黄附子甘草汤，兼顾阴阳表里。附子与麻黄并用，寒气散而不伤元阳，救其里而及其表；且以甘草缓之，微发其汗也。此与单纯治疗少阴虚寒里证，或病仅属太阳表实，脉阴阳俱紧而发汗者，径庭也。
[二诊]上方服四剂，恶寒、咳嗽、头痛等减轻。太阳表寒初解，腹胀、便难等稍有好转。但阴寒凝聚于里，非通下不足以破其结。惟大便不通，当分阳结阴结。查前人固有少阴急下三证之说，但有严格之界限。此证与少阴三急下证又不相同，应为少阴寒证阴结为主的二便失常，乃少阴之变，而非少阴之常，当用温通之法。为此投以阴阳共

济，寒热同炉之大黄附子汤主之。
处方：
生大黄9克 川附片45克(久煎) 辽细辛3克
四剂
服药四剂，二便皆觉通畅；憋胀、急迫等多年痛楚消失；咳喘、痰涎亦进而减轻。以后改服理中汤，随证加减，又服药月余，调理而安。
1978年12月10日，至患者家中访问，得知几年来身体一直良好。老人兴奋地说：往年冬季， 早已卧床；病愈至今，既无手足清冷，又无恶寒咳喘之病，二便亦已正常，对范老十分感激。
[按语] 本例上、中、下三焦，肺、脾、肾、胃、大小肠、膀胱等多脏腑皆已受病，互相连累和交织。病之症结，在于肾阳虚衰，致使下焦佚固，咳喘缠绵。病邪传变之趋向，为寒湿浸入太阳，日久失治，阳消阴长，邪进正衰；病传少阴，则寒化益深，机体抗病力更弱，以致缠绵数载，变证蜂起。病情虽然如此复杂，由于紧紧抓住六经辨证的基本线索，故其特征、本质和各个阶段之主要症结清晰可见，从而为临床施治提供了可靠的依据。

41、太阳少阴证鼻衄
冉××，女，72岁。成都市居民。
[病史]1975年4月，感冒后鼻内出血。就近至某医院请中医治疗，诊为肺热。连服清热解表剂，病势不减。家人急用云南白药塞鼻内，用三、四瓶后，血仍渗出不止。延至第六日，到××医院五官科诊治，无效，遂来就诊。
[初诊]鼻衄已十日，鼻腔出血仍阵阵外渗，血色暗红，面色苍白。饮食难下，四肢逆冷，恶寒身痛，微咳。舌质暗淡，苔白滑，根部微黄腻。阳虚之 人，外感寒邪，正气虚弱，失血统摄，阳气被遏，脉络淤滞，血不循常道而外溢。此属太阳少阴证鼻衄。法宜助阳解表，温经摄血，以麻黄附子细辛汤加味主之。
处方：
麻黄10克 制附片60克(久煎) 辽细辛3克 炮姜30克 荷叶10克(醋炒) 炙甘

草20克
二剂
[二诊]上方服一剂，出血减；二剂后，血全止。因年迈体弱，难以复元，再以四逆汤加益气之品续服。
处方：
制附片30克(久煎) 炮姜15克 炙甘草10克 党参10克 上肉桂10克(冲服) 大枣30克
三剂
[三诊]精神好转，饮食增加。但气血亏甚，嘱其以生姜羊肉汤加当归、黄芪炖服调补。
1979年2月追访：患者已76岁，病愈后身体尚好。
[按语] 本例鼻衄，证属寒中少阴，外连太阳。治以表里双解，佐以温经摄血，三诊而衄止。
或问：仲景有“衄家不可汗”之戒，此例何以用麻黄?因患者兼有太阳伤寒之表，具麻黄证。方巾重用附子，温少阴之经，解表而不伤阳气；麻黄不配桂枝，并重用炙甘草以制之，则不发汗而祛邪。临床所见，衄家并非皆不可汗；亦有用汗法而愈者。不同病情，须具体分析。

42、少阴证鼻衄
刘××，男，5岁。成都市某厂职工之子。
[病史j 1948年春，其父背来就诊时说：“小儿一人在家，中午忽发现他鼻出血不止，倦怠无力，躺在椅上，面色苍白。曾频频用凉水冷敷，流血反而加剧，急请范老诊治”。
[初诊]患儿精神萎靡，四肢逆冷，唇舌淡白。此为少阴寒证，阳气衰微，不能摄血，阴气较盛，势必上僭。徒止血，岂能止?法宜壮阳驱阴，温经摄血。急投四逆以救其里。
处方：
天雄片30克 炮姜30克 炙甘草20克
一剂

嘱急火煮半小时许，先取少量服之；余药再煮半小时，续服。
患儿父亲将处方拿回家中，其母见之，大吵大闹：“从古到今，未见鼻流血用干姜附片！”。其父仍坚持服用。一剂未尽，血立止。傍晚，患儿在院内玩耍如常。
[按语] 鼻衄一证，现代医学认为，鼻腔疾病与全身性疾病均可引起。祖国医学认为，与肺、胃、肝、肾等脏腑，关系尤为密切。通常外感风邪，肺郁化热；过食辛辣厚味，胃火上逆；暴怒气逆，肝火妄动；肾阴耗损，虚火上炎等等，均可热伤脉络，迫血妄行，治则常以清热凉血为主。但临证确属虚寒，因血失统摄而致衄者，亦菲罕见。后者若误用凉药每成偾事。范老对虚寒型鼻衄，治验颇多，今选两例，以资参考。

43、少阴证头痛
张××，男，38岁。成都某厂工会干部。
[病史]1970年患头痛，逐渐加重，看书、写字时，头痛目胀尤甚。先后经几处医院，未明确诊断。至1976年，病情转剧，10月来诊，按少阴证论治而愈。
[初诊]数日前，头暴痛如裂，不敢睁眼。卧床休息并服药，未见减轻，仍阵阵发作。心烦、气短、四肢厥冷；面色青暗萎白，舌质淡而乌暗，边缘有明显齿痕，苔灰白薄润，脉沉微。此少阴阳衰阴盛证头痛，有阴阳格拒之象。法宜通脉回阳，宣通上下，以白通汤主之。
处方：
葱白头60克 干姜30克 制附片60克(久煎)
四剂
[辨证]按《伤寒论》白通汤，原为少阴病阴盛戴阳并下利而设。为什么本例头痛，却用白通汤?
考白通汤证之下利，是下焦虚寒不能制水；而戴阳面赤，乃虚阳浮越于上。无论下利或面赤，其病因和病机，皆属于阴寒内盛，阴阳格拒。从本例来看，不仅阴寒内盛十分突出，而且阴阳格拒之象比较明显。其面色青暗，四肢厥冷，全身乏力，舌淡乌暗，苔白灰滑，脉

微，反不恶寒，而心烦气短；此属阳为阴困，阴盛于内，格阳于外之象。虽不表现于下焦虚寒不能制水，却体现在阳气不能镇纳，浊阴腾越于上。这与真阳不能内守而致格阳于上，只属证候上之差别，其病机皆应归于阴阳格拒。由此可见，投白通汤仍药证相符。以附子补先天之火种；佐干姜温中焦之土气；葱白能通上下之阳气。姜附并用，逐阴回阳。阴阳交媾，浊降清升，即可通其被格之阳。

[二诊]连进四剂，头痛和精神好转。但阳衰阴盛日久，须温补少阴，兼顾太阴。法宜继用驱阴助阳，温中益气，以四逆合理中加味，配成丸药服用。

处方：

制附片60克 干姜30克 炙甘草20克 生晒参30克 炒白术30克 茯苓30克 上肉桂15克 宁枸杞20克 菟丝子30克

十剂、水打为丸。

1979年7月追访，三年来，虽经常加夜班，头痛始终未犯。

[按语] 或问：太阴少阴，本无头痛一证，为何此例病属少阴阳虚阴盛而头暴痛如裂?

对这个问题，历史上某些医学家曾有过不同意见。有的认为，头痛证只及太阳．少阳、厥阴。还有人提出，头为诸阳之会，与厥阴肝脉会于巅，诸阴寒邪不能上逆。

另一种意见与此不同。有人认为：“ 太阴、少阴二经，虽不上头，然痰与气逆壅于膈，头上气不得畅而亦痛。 ” (《冷庐医话》)还有人明确提出；三阳三阴皆有头痛，内伤日久，七情过度，亦作头痛，其中：“ 因阳虚日久，不能镇纳浊阴，阴气上腾，有头痛如裂，如劈，如泰山压顶，有欲绳索紧捆者，其人定见气喘唇舌青黑，渴饮滚汤，此属阳脱于上，乃属危候，法宜回阳收纳为要，如大剂白通四逆之类，缓则不救 ” 。 (《医法圆通》)

范老根据多年经验认为，后一种意见，比较符合临床实际。在临证中，头痛一证十分普遍，属少阴病头痛者，亦屡见不鲜。一般来说，少阴寒化证头痛，必须具备少阴病之主证，参之舌现淡白，皆应以白

通、四逆辈主之。

44、少阴证哮喘(支气管哮喘、肺气肿)
刘××，男，49岁。安徽省某局干部。
[病史]十余年前，患慢性支气管炎，后发展为哮喘，经常发作，每冬必重，常须住院治疗。经安徽省××医院确诊为“支气管哮喘”、“肺气肿”，久治未愈。1978年7月4日来诊，按少阴证论治。前后八诊，已一年未再复发。
[初诊]气紧，心累，乏力，偶有咳嗽，痰少，清稀色白。体稍胖，两颧赤暗，唇乌，舌淡白，苔灰白厚腻。时值伏天，哮喘虽未大作，但病根犹存，此证属少阴。法宜扶先天之元阳，镇纳浊阴之气，以四逆加味主之。
处方：
制附片60克(久煎) 干姜片60克 炙甘草18克 上肉桂15克 生白术30克
[二诊]上方加减服二十余剂，渚证皆减。活动后还觉气紧、心累。舌质仍淡，苔腻稍退。阳衰阴盛，日久难复，守原法再进。
[三诊]上方加减又服二十余剂，气紧、心累明显减轻。双颧暗赤色稍退，舌质微现淡红，苔厚腻减。为扶正驱邪，巩固疗效，拟四逆、理中合方加味，配成丸药，坚持服用两月。
处方：
制附片150克 干姜片150克 炙甘草60克 红参30克 炒白术120克 上肉桂60克 宁枸杞120克 菟丝子120克 紫河车120克
共研细末，加红糖为丸，如枣大，每日2次，每次2丸。
1978年冬季，在中央党校学习时，经服药后，与往年冬季截然不同：在严寒之晨，可在室外坚持打太极拳和跑步约1小时，咳喘未再发作。
1979年4月，患者从安徽来京，特来看望范老，介绍自去冬以来，至今良好。过去走一、二里路，上二、三层楼，皆觉困难，经常住院。现在，一直坚持工作和体育锻炼，身体日益康复。
[按语] 患者于1979年1月，向有关研究部门反映，着重提出两个问题：(一)据说川附片超过四钱，就要中毒，多服干姜有害于肾。但范老所

处药方，每剂药附片用到二两以上，干姜用量亦不少，四个月内，附片累计服用二十余斤，不仅没有中毒和其他反应，而且疗效显著，究竟是何缘故?
(二)我在京服汤药，是从1978年7月12日开始，至9月20日。时值伏天，每天一剂，早中晚三次分服。有的医生，对盛暑服用如此大量热药很担心。象类似陈规，范老为什么敢于突破?建议一并作为专门课题研究总结。
我们认为，病人提出的这些问题十分中肯。如能采取现代科学手段，加以认真研究，是有现实意义的。

45、少阴证哮喘(支气管哮喘)
曹××，女，40岁。成都某厂工人。
[病史]十余岁开始患支气管哮喘。每年冬季发作。1960年以后，病情日趋严重，发作频繁。屡至××医院急诊，输氧抢救。1965年4月来诊。
[初诊]咳嗽，气紧，心累，痰多不易咳出，呈泡沫状。喘则张口抬肩，哮鸣不已，出多入少，动则尤甚。又身恶寒，经常头晕眩，曾诊断为“美尼尔氏综合症”。食欲不振，形体消瘦。月经量多，色乌暗，挟紫黑色淤血，某院妇科诊断为“功能性子宫出血”。查血色素仅有5克。面色萎白无华，眼胞及双颧浮肿，唇乌，舌质淡而紫暗，苔灰白黄、浊腻、根部厚。此为少阴寒化证，兼太阳表证未解。须表里同治，法宜散外寒，涤内饮，以小青龙汤加减主之。
处方：
麻黄10克 干姜15克 甘草15克 桂枝10克 法夏18克 辽细辛5克 炮姜20克 生姜20克
四剂
[二诊]服四剂，咳嗽减轻，气喘稍减，痰易咳出。此病积之已久，脾肾阳气日衰，喘时呼多吸少，肾不纳气之虚象甚显。故不宜过表，须峻补脾肾之阳，固肺气之根，扶正以涤饮驱邪。以四逆加味主之。
处方：

制附片120克(久煎) 干姜60克 炙甘草45克 茯苓20克 上肉桂10克(冲服)
[三诊]上方随证加减，服十余剂。咳喘， 畏寒，眩晕等证，皆显著好转。宜扶阳益气，培补二天，损益续服。
处方：
制附片60克(久煎) 炮干姜30克 炙甘草25克 炒白术30克 茯苓20克 菟丝子20克 宁枸杞20克北沙参20克 砂仁10克
上方出入增减，服两月余。咳喘皆平，月事正常，体质逐渐恢复。
1979年7月，在成都偶遇范老，特来家致谢，谈及十余年前患哮喘重证，经治愈后，仅去年有轻度发作，一周后即愈。表示不胜感激之意。
[按语] 刘、曹二例，分属北京、成都南北两 地，均系少阴证哮喘。其年龄、病情、西医诊断，以及理法方药皆大体相似，故一并选于此，以资参照。
有人认为，中医诊籍，所选若干病例，其疗效是否可以重复?颇值得怀疑。其实，祖国临床医学，正是千百年来医疗实践的结晶，反过来又指导临床实践。有是证，有是病，则用是方是药，哪有不能重复之理?以《伤寒论》为例，从问世以来，迄今近两千年，其理法方药，临床治验，经重复疗效之检验，则难以数计。若不能重复，焉能历代一脉相承，且扬之海外。时至今日，仍为中医之典籍?!
但所谓重复，亦必须有正确理解。仍以刘、曹二例而言，现代医学辨病大体相似。祖国医学不仅辨证，也要辨病：少阴属证，可谓辨证之分类与纲要，而哮喘才是病名。证属少阴，又有热化寒化之分，证同气异之别。深入分析，证中有证；合而言之，纲目分明。论其辨病，依然如此。所以，我们所理解的重复，并非同一病名，即可搬用同一方药的机械重复；而是病证合参，具体病证具体分析、辨证施治的重复。这正是祖国医学的精华所在。张仲景曾针对自己的著作，满育抱负地说过：“ 为《伤寒杂病论》，合十六卷，虽未能尽愈诸病，庶可以见病知源 ”。此乃这一巨著，千百年来强大生命力之所在。

46、少阴证虚喘(支气管哮喘)

罗×，男，26岁。四川双流县某乡，农民。
[病史]1962年4月，因风寒咳嗽，痰多，气紧，不能平卧，××医院诊断为“支气管哮喘”，经治疗，病情好转。1963年冬季，咳嗽加剧，心累气紧，动则尤甚，致卧床不起。治疗一段时间，基本缓解。1964年春，旧病复发，遂来求诊。
[初诊]喉间痰声漉漉，张口抬肩，气不接续，喘时汗出，痰多清稀，精神萎靡，恶寒肢冷，面肿。舌质淡暗，苔白滑腻。此为少阴阳衰阴盛，气不归元，寒饮上逆而致。法宜壮阳驱阴，纳气归肾，以四逆汤加味主之。
处方：
制附片30克(久煎) 生姜30克 炙甘草15克 上肉桂10克(冲服) 砂仁12克 白术12克
四剂
[二诊]服上方后哮喘减。原方加茯苓，以增强利水、渗湿、化痰之效。续服五剂。
[三诊]哮喘明显减轻。其后又继续服上方月余，以巩固疗效。
1979年6月追访：患者病愈后，次年即由农村调某厂工作，患者始终坚持全日工作，十四年来病未复发。
[按语] 本例气急喘促，不能续接，张口抬肩，得长引一息为快，应属元气不足之虚证。这与气促壅塞，不能布息，得呼出余气为快之实证不同。
虚喘之证，无非气虚。气藏于肺而根于肾。此证虚喘，喘则汗出，动则尤甚，恶寒肢冷，面浮神疲，痰涎稀薄，舌淡苔白，一派少阴虚喘之象。故自始至终，坚持壮阳驱阴，补肾纳气之法。阳旺邪消，哮喘自平。

47、少阴证咳嗽(慢性支气管炎)
安××，女，54岁。北京某部队家属。
[病史]1966年因受风寒，咳嗽迁延十二年。每年入秋则发，冬季加剧，甚则不能平卧。××医院诊断为慢性支气管炎。发作时服药虽可暂

时缓解，但经常反复，日益加重。1978年8月来诊，按少阴证水寒内结论治，三个月基本治愈。
[初诊]每日阵发性剧咳，痰清稀，量多，头晕心累，气短，昼夜不能平卧。畏寒恶风，面足浮肿，脸色萎黄。舌质淡暗有淤斑，舌体畔嫩而边缘多齿痕，苔白滑，根部厚腻。此为少阴阳虚水泛，寒痰阻肺咳嗽。法宜温阳化气行水，以真武汤加减主之。
处方：
茯苓24克 生姜30克 白术20克 制附片60克(久煎) 桂枝10克
六剂
[辨证]患者每年秋冬外感，咳必复发，神疲身倦，恶寒肢冷，气短倚息难卧，面色晦滞，舌质暗淡无华，皆肾阳衰微之明证。因肾为水脏，肾中真阳衰微不能化气，则水饮内停。水寒之气上泛，则头眩、心累。水气停于胸肺，则咳嗽不已，痰涎清稀量多，气短难卧。水气溢于肌表，故面足浮肿沉重。舌质胖嫩，兼有齿印与淤斑，舌苔白而厚腻，皆为水泛寒凝之象。同时年逾半百，阳虚益甚。多年前，初感寒邪病咳，正气未衰，逐风寒之邪从外而解，或可速愈；今则迥然不同，断不可舍本求标。综上所述，此属少阴肾阳衰微，水寒射肺，故投以温阳散寒、化气行水之真武汤为宜。
上方真武汤加减，以附子之辛热，壮肾之元阳，则水有所主；白术之苦燥，建立中土，则水有所制；兼生姜之辛散，佐附子以补阳；茯苓之淡渗，佐白术以燠土，并寓散水渗湿之意；以芍药易桂枝者，加速温经敞寒，化气行水之功。
[二诊]原方连服六剂，咳嗽明显好转，痰亦减少过半，呼吸较前通畅，渐能平卧。面已不觉肿，舌质稍转红润，厚腻苔减。多年之患，已获初效。宜守原法，以干姜易生姜，加强温中补脾之效。
[三诊]上方续服六剂，诸证显著减轻。尚有轻微咳嗽，清痰少许。舌质转为淡红，乌暗淤斑与白腻苔渐退，舌边齿痕已不明显。有时尚觉气短，心累。病有从阴出阳之势。须适应转机，通阳和中，燥湿涤饮。以苓桂术甘汤加味，缓缓服之。

处方：
茯苓20克 桂枝10克 白术20克 法夏15克 生姜20克 甘草3克
十二剂
服十二剂后，诸证基本痊愈。入冬以来，再未重犯。1979年5月4日至患者家中追访，自觉始终良好。
[按语] 咳嗽一证，有从外而入者，有从内而出者。不论其外入或内出，皆可按六经辨证。本例咳嗽，应属少阴阳虚，水泛成痰，水寒袭肺，肾阳虚而累及于肺。既有水气，又系少阴寒化。故投以真武汤，壮元阳以消阴翳，逐寒痰以清水源。不攻肺而肺之病自愈，不止咳而咳嗽自平。

48、少阴证喉痹(慢性喉炎、瘜肉)
黄××，女，44岁。四川郫县团结乡，农民。
[病史]1975年4月，因兄病故，目睹火化现场，不胜悲戚。次日，自觉喉部不适，似有物梗塞。继而发展至呼吸不畅，甚至憋气，心悸，身麻。××医院五官科检查，诊为“喉炎”、“瘜肉”，治疗无效。又转几处医院医治，其效不显，病情日益加重。1976年5月来诊。
[初诊]患者觉喉部明显堵塞，轻微疼痛。向左侧躺卧，气憋心慌，全身发麻。头昏，体痛，乏力，咳嗽吐泡沫痰甚多，自觉周身血管常有轻微颤动，精神倦怠，食欲不振，每进一餐，皆须休息几次，胃脘常隐痛，喜热敷，形体消瘦，步履艰难。前医均以清热解毒，养阴散结为治，服药百余剂，仅夏枯草一味，自采煎服共两萝筐之多。医治年余，越清火，自觉火益上炎，舌上沾少许温水均觉灼痛，满口牙齿松动，疼痛。唇乌，舌质偏淡微暗，少苔不润，脉沉细。此忧思郁结而成梅核气，并因正气不足，过服凉药，转为少阴证喉痹。先以半夏厚朴汤加味，调气散郁为治。
处方：
法夏15克 厚朴12克 茯苓12克 生姜15克 苏叶10克 干姜12克 甘草10克
四剂
[二诊]上方服四剂，觉喉部较前舒畅，憋气感消失，吞咽自如。仍咳

嗽、头昏、身痛，为太阳表证未解；法宜温通少阴经脉，兼解太阳之表，以麻黄附子甘草汤加味主之。
处方：
麻黄10克 制附片120克(久煎) 炙甘草60克 干姜60克 辽细辛6克
六剂
[三诊]服六剂，咳嗽，头昏、体痛基本消失，痰涎减少，心悸好转。惟喉间瘿肉未全消，左侧躺卧仍有不适。尚觉神疲，牙疼松动，舌触温水仍有痛感。此为少阴虚火上腾，宜壮阳温肾，引火归原，以四逆汤加味主之。
处方：
制附片120克(久煎) 干姜片60克 炙甘草45克 上肉桂12克(研末、冲服) 辽细辛6克
[辨证]此病得于七情，忧思郁气，致痰涎滞：于：咽中，如同有物梗塞，咯之不出，咽之不下，显系梅核气。正如《金匮要略》所说：“妇人咽中如有炙脔，半夏厚朴汤主之”。但是，从患者全身证状，参之舌脉来看，神疲、乏力、心悸、舌淡、脉沉细，乃阴盛阳郁，少阴寒化之象。少阴之经脉循行于咽喉，心肾阳衰，正气不固，阴气上腾，与郁气凝涎相结，使咽喉堵塞，疼痛，甚则聚而生变，不仅“如有炙脔”，而且凝结为有形之瘿肉。进一步阻滞经脉，影响气机，故梗塞，憋气，心悸，身麻等诸症接踵而生。
病情虽较复杂，但纵观全局：病根在于少阴心肾阳虚，无根之火上扰；主证在于喉部气血痹阻，病属虚火喉痹；诱因为忧伤太过，致痰气郁结而上逆；兼证为太阳风寒之表。治宜先开痹阻，利气化痰，然后表里同治，再集中优势兵力，引火归原，关键得以突破。
[四诊]上方连进四剂后，上述诸证皆显著减轻。过服凉药，元气亏损，魁伐太过，短期难奏全功，宜培补脾肾，助阳益气，以理中汤加味再服。
处方：
潞党参15克 干姜片20克 炒白术15克 炙甘草12克 制附片30克(久煎) 上

肉桂10克
嘱其继服十余剂，忌食生冷，戒忧虑， 注意调养。
1979年7月追访，患者说：“ 我第一次服这样重的热药，很怕上火，小心试着服，结果几剂药后，反觉得比较舒服，喉部就不堵了，从此，三年来未再发病 ”。
[按语] 《素问?阴阳别论篇》云：“ 一阴一阳结谓之喉痹 ”。结者，气结痰凝；痹者，闭也。既然如此，辨证施治之症结，在于如何辨其阴阳，突破其闭阻。一般治疗此类喉证，多以属阳、属热，药用甘寒之品。而干姜之燥，附子之热，则视为大忌。
范老针对此类病证常说：“ 口内少实火 ”。临床所见，凡虚火上炎，郁结于喉；尤以正气不足，证属少阴者，概用寒凉之剂，则邪聚益甚。而投以辛温，则其郁反通。不仅郁结于咽嗌之客寒，温之能散；且怫郁于咽喉之客热，散之即通。此即“ 微者逆之，甚者从之 ”(《素问?至真要大论篇》)之意也。

49、少阴证喉痹(慢性咽炎)
李××，男，36岁。四川三台县某厂干部。
[病史]1971年5月，咽部有异物感，吞咽不利，并伴有项强、胸满、肩酸、背痛等证。××医院诊为“ 慢性咽炎 ”，服用炎得平、六神丸、四环素类，并外用冰硼散治疗，病势不减。后续服清咽利膈、泄热解毒中药约半年，咽喉疾患益重，并出现恶寒身痛，胸憋气短，胃腹胀痛，完谷不化等证，自疑“ 癌 ”变，思想包袱沉重。于1972年2月22日来蓉求治。
[初诊]咽痛，吞咽如有阻塞，胸满，纳呆，便溏，头痛，咳痰，四肢清冷。舌质偏淡，苔微黄滑，脉弱无力。此病乃过服凉药，以致阳气虚微，复因旅途劳累，受风寒侵袭。本少阴喉痹，今又兼太阳外邪。以麻黄附子甘草汤加细辛、生姜，扶阳解表，通达内外。
处方：
麻黄10克 制附片60克(久煎) 甘草20克 细辛3克 生姜30克
四剂

[二诊]头痛，胸满，咳痰俱减，余证无明显变化，原方再服四剂。
[三诊]身疼减，饮食增，便溏止，咽痛痹阻稍有好转。因肾阳虚衰，阴气上腾，痰湿上干清道，日久凝聚较深，致喉痹难愈。以大剂四逆汤， 壮阳驱阴，加上肉桂温营血，助气化，益火消阴，散寒止痛。
处方：
制附片120克(久煎) 干姜60克 炙甘草30克 上肉桂12克(冲服)
三剂
[四诊]咽痛痹阻之证基本消失，精神大振。久病气血皆亏，应培补脾肾，以理中丸加阴阳平补之品，嘱其缓服。
处方：
党参30克 白术30克 干姜30克 制附片60克 上肉桂15克 紫河车30克 冬虫夏草30克 菟丝子30克 炙甘草20克
共研细末，水打丸。日服三次，每次10克月余后，其友来告，患者已病愈上班。
1979年8月3日追访，至今良好。
[按语] 本例喉痹，曾服大量清凉退热之品，病势不减而反增；参之舌、脉诸证，显然与风热、燥热等邪实上犯之喉痛，有原则区别。
喉痹之证，须分阴阳。由于少阴经脉循于咽喉，故咽喉疼痛与痹阻，属少阴病者屡见不鲜。 《伤寒论》中，少阴咽痛证，大致有虚热咽痛，客热咽痛，痰热闭阻咽痛及客寒咽痛几种。考此例属客寒咽痛，因喉痹日久，邪聚益甚，且少阴寒化之证突出；而初诊时，太阳伤寒之兼证又比较明显。故首以太阳少阴两经同治，寓解表于壮阳。再峻投四逆汤加味，以补命门，散寒滞。最后，培补脾肾以收功。

50、少阴证舌强
王××，男，60岁。内蒙古某厂干部。
[病史]1970年末，在架设变压器时，被钢丝绳撞击头部，当即昏迷约8分钟，急送当地×x医院，诊为“急性脑震荡”。约一月内均处于意识模糊，吐字不清，口角流涎状态。其后仍觉头晕、头胀、恶心、呕吐、畏声音刺激。经治疗两月，上述诸症有好转，但严重失眠，且似

睡非睡之状，持续7年余。头左侧偶有闪电般剧痛，发作后则全身汗出。1976年5月开始觉舌干、舌强，说话不灵，下肢沉重，后逐渐发展至左上肢厥冷麻木。到1979年2月，出现神志恍惚，气短，动则尤甚，纳呆，病情加重。同年11月内蒙××医院诊断为“脑震荡后遗症”，转北京治疗，于1980年1月3日来诊。

[初诊]舌强，舌干，难以转动已三年余。尤其晨起为甚，须温水饮漱之后，才能说话，舌苔干厚，刮之有声。纳差，畏寒，左上肢麻木，活动不灵，下肢沉重无力，左肢较甚。七年来双足反觉热，卧时不能覆盖，否则心烦不安。步履艰难，扶杖可以勉强缓行数十米，动则喘息不已。小便清长频数。面色黄滞晦暗，眼睑浮肿，精神萎靡。舌质暗淡，少津，伸出向左偏斜，苔灰白腻，脉沉。此为少阴阳衰阴盛证，以四逆汤主之。

处方：

制附片60克(久煎) 干姜30克 炙甘草30克

二剂

[辨证]此例脑外伤，酿成后遗之证多年。来诊时，神靡，恶寒，内寒外热，四肢沉重， 舌淡，脉沉，一派少阴阳衰阴盛之候。陆渊雷云：“少阴病者，心力不振，全身机能衰减之病也。”患者头部受重物撞击，长期失眠，纳呆，甚则神志恍惚，肢体麻木，迁延过久，必致全身机能衰减，心肾阳气俱伤。盖头为诸阳之会，舌为心之苗。心力不振， 肾阳衰微，津液不能上达，可引起舌强难言。证属少阴寒化，阳衰阴盛，即投以四逆汤为治。

[二诊]11月7口。主诉：服完一剂，半夜醒来，自觉舌有津液，已能转动，遂情不自禁，唤醒陪伴说：舌头好多啦，我能说话了!起床后，下肢沉重感亦减轻。服完两剂，舌强、舌干、转动困难之症显著减轻。守原方再进五剂。

[三诊]1月14日。舌强、舌干进一步好转。左上肢麻木、畏寒减轻。舌根部尚有强硬感，仍稍觉气一短，眼睑浮肿，食少寐差，舌淡苔白。少阴寒化已深，又累及太阴脾阳衰惫，以四逆、理中合方加减为治。

处方：
制附片60克(久煎) 干姜30克 炙甘草20克 白术30克 茯苓30克 桂枝lO克
五剂
[四诊]1月21日。舌强、舌干已愈大半。可离杖行动，独自登上四楼，左上肢凉麻消失，摆动有力。双足已无发热感，夜卧覆被如常，寐安，食欲增加。以上方加上肉桂10克，增强益阳消阴，峻补命火之效，再进五剂。
[五诊]1月28日。患者精神振奋，诸症显著好转，要求回家过春节。为巩固疗效，嘱其原方续服十剂。
[按语] 此例虽属外伤，但其主证，已不在外而在里，属少阴寒化。外伤可循经入里，伤科亦能从内而治。《伤寒论翼》云：“ 仲景治法，悉本内经。按歧伯日：调治之方，必别阴阳：阳病治阴， 阴病治阳。定其中外，各守其乡 ”。又云：“ 仲景约法，能合百病 ”。范老在临证中，对于某些外科疾病，亦遵仲景六经学术思想，扩展加以运用。抓住六经主证及其变化，内外相参，立法处方，外伤每随之迎刃而解；或配合外治之法，常获捷效。

51、少阴证心悸(植物神经功能紊乱)
于××，女，40岁。北京市某商店职工。
[病史]1973年初，自觉眩晕。至1976年病情加重，心悸，手麻，上肢震颤。××医院诊断为：“ 植物神经功能紊乱 ”。长期服中药调补，疗效不显。
[初诊]1978年10月13日。心悸，气短，胸闷，眩晕，纳呆，夜卧不宁，背畏寒，膝关节疼痛，肩臂肌肉时有颤抖。月经提前一周，色暗，有淤块。面浮肿，舌淡，苔白滑，脉沉细。病情虽错综复杂，主证乃少阴心肾阳衰，法宜温通心阳，益火之源，以桂枝甘草汤加味主之。
处方：
桂枝10克 炙甘草20克 制附片30克(久煎) 生姜30克
四剂

[二诊]10月17日。服上方后，心悸头晕减，余证如前。原方再进四剂。
[三诊]10月23日。心悸．头晕、失眠、乏力，均明显好转。但仍面浮、背凉，关节痛，肌肉震颤。上方加麻黄lO克，辽细辛3克，以散经络之寒湿。服三剂。
[四诊]10月28日。自觉胸中宽舒，关节痛减。守原法，加炮姜、血余炭各30克，再进五剂，以温经逐淤而生新。
[五诊]11月17日。心悸、头晕基本消失，余证 均已好转。令再服五剂。
1979年5月10日随访，病未复发。
[按语] 本例心悸诸证，病情交织错杂。但其主证乃手足少阴心肾虚衰之病变。正如《伤寒明理论1)>所说：“ 其气虚者，由阳气虚弱，心下空虚，内动而为悸也 ”。其病根又在于肾阳不振，不能升腾上济于心所致。始终以补肾气、通心阳为治。故投桂枝甘草汤加味，以桂枝为君，入心助阳；甘草佐之，以补中气；二者相得，辛甘合化，则有温通心阳之功。真气之根既藏于肾，故加附子，大补命门火种，配生姜开提散郁，逐阴行阳之意也。因兼有经络之寒郁，故少佐麻黄、辽细辛。肾气旺而气血和，诸证即可迎刃而解。

52、少阴证虚损
陈××，男，28岁。解放军某部医生。
[病史]1971年，到西藏某地执行任务，长期风餐露宿而致病。开始自觉指尖、手掌、下肢关节咯咯作响，继而面肿，心悸，腰痛，彻夜不眠。某部医院曾按“ 肾炎 ”治疗一段时问。后又改服清热解毒之品，包括犀角、羚角等。逐渐行走乏力，神疲纳呆。其后按“ 肝肾虚损，气血亏耗 ”论治，服滋补之剂。曾出现脑内如鸣，头顶发脱，心悸加重，动则气喘，身出冷汗，肢体皆痛，四肢麻木等证。至1977年1月3日，自觉口内从左侧冒出一股凉气，频吐白泡沫痰涎，胸中如有水荡漾，左耳不断渗出黄水，听力减退，走路摇摆不定。血压70／50毫米汞柱。同年5月22日，突然昏倒。急入××医院，住院治疗三月，未查

明病因。面部及双下肢浮肿加重，头昏胀难忍，转送××医院会诊。左半身痛、温觉明显减退，左上肢难举，提睾反射消失，悬雍垂向左弯曲，舌向左偏。结论为：“ 左半身麻木，感痛觉障碍，左上肢无力，水肿待诊。 ”数年来，服中药千余剂。1977年9月，转来就诊。

[初诊]面部与双下肢肿胀，左半身及手足麻木，四肢厥冷，脑鸣，头摇，神疲，心悸，失眠，记忆力及听力减退，身痛，胁痛。口中频频冒冷气，吐大量泡沫痰涎，纳呆，大便稀薄，小便失禁。舌质暗淡、胖嫩，边缘齿痕明显，苔白滑厚腻而紧密，脉沉细。此为少阴寒化，迁延日久，阴盛阳微， 气血亏损，已成坏病。法宜回阳救逆，化气行水。以四逆汤、真武汤加减主之。

处方：

制附片120克(久煎) 干姜60克 生姜120克 炙甘草30克 茯苓30克 白术30克 桂枝lO克 辽细辛6克

[二诊]上方服二十剂，脑鸣消失，心悸好转，面部及下肢浮肿显著消退，小便失禁转为余沥。多年痼疾初见成效，守原方续服。

制附片120克(久煎) 干姜60克 炙甘草60克 桂枝10克 生姜皮60克 辽细辛3克 茯苓30克

[三诊]服十剂后，口中已不冒凉气，神疲、肢冷、纳呆。便溏均有好转，但仍不断吐白沫，余证尚无明显改善。少阴阳衰日久，沉寒痼冷已深，积重难返。法宜益火消阴，温补肾阳，以四逆汤加上肉桂，嘱其坚持服用。可连服四、五剂后，停药两天再服，直至身体自觉温暖为止。并配服自制坎离丹。

处方：

制附片60克(久煎) 干姜30克 炙甘草30克 上肉桂10克(冲服)

上方连服半年，全身肿胀消退，摇头基本控制，身痛和手足麻木显著减轻，心悸明显消失，吐白沫：欠减，二便正常。血压回升到120／80毫米汞柱，身体逐渐恢复正常。

1979年11月20日随访：于1978年下半年病基本痊愈，重新走上工作岗位。

[按语] 本例患者，病情较重，迁延日久，加以误补误治，日益恶化。初诊时已明显可见三阴俱病，五脏虚损：心悸失眠，神疲肢冷，舌淡胖嫩，为手少阴心阳虚弱；头摇。脑鸣、发脱、胁痛，为足厥阴肝血亏损；浮肿、纳呆、便溏，为足太阴脾土虚甚；口中频冒冷气，吐大量泡沫痰涎，为手太阴肺气内伤；四肢厥逆，小便失禁，精神萎靡，记忆力和听力减退，为足少阴肾阳衰微。身痛、左半身及手足麻木，为风寒湿长期留滞肌肉经络，逐渐深入筋骨，正气日虚，精血耗损。可见，患者全身性之里虚寒证，十分明显。病情虽复杂，其症结实属少阴寒化，心肾阳微，尤以肾阳衰败为甚。所谓“五脏之伤，穷必及肾”。故抓住根本，坚持回阳救逆，益火消阴，大补命门真火，峻逐脏腑沉寒，守四逆辈，连服半载，多年痼疾始得突破。

53、少阴证偏枯(脑血管意外)

陈××，女，65岁。成都市某公司职工家属。

[病史]平素身体尚好，未患过大病。1963年10月间，正从事家务劳动，忽觉头似重物压顶，旋即昏仆，不省人事。急邀某中医来诊，用温针刺百会穴，约十五分钟，苏醒。左侧上下肢已偏瘫，口歪斜，流清泫涎不止，成都××中医院诊为：“中风”。××医院确诊为：“脑血管意外”。其后，由中医诊治，病未发展。每年秋冬开始卧床，直到次年春，天暖后可扶床缓慢移步。1971年冬，病势沉重，患者一再告之家人：今冬难以熬过，命备后事。遂来求诊。

[初诊]入冬以来，畏寒蹑卧，重被覆盖，左侧手足仍厥冷。头部发木，如盛盒内。左侧偏枯，骨瘦如柴。脸面浮肿，面色苍白。舌质淡，苔白腻。半身不遂多年，阳气日衰，属少阴寒化，阴寒内盛，阳虚水泛已极。急须回阳救逆，化气行水，以四逆汤并真武汤加减主之。

处方：

制附片120克(久煎) 干姜60克 炙甘草60克 白术30克 茯苓30克 炮姜60克 上肉桂15克(冲服)

[二诊]上方服一剂后，全身发痒，如虫爬行。连服四剂，身上开始感

觉轻松，头木之感渐消。上方随证加减：遇有外感风寒、关节疼痛，加麻黄、桂枝、细辛；阳气渐回，则姜附酌减。其后，又酌加人参、黄芪、当归、菟丝子等，以增助阳益气、活血养血之效。如此坚持服药半年，面色渐转正常，浮肿消退，食欲倍增，四肢变温，精神好转。1972年4月已能起床，依靠拐杖或他人搀扶，能缓缓移步；到同年7月，即可丢掉拐杖而行。

1979年11月23日追访：患者已73岁，向来访者兴奋地介绍，从1972年底，在冬季继续服些温阳补肾药，七年来再未卧床不起。这几年一直能料理家务。

[按语] 中风之发生，总不外乎阴阳失调，气血逆乱。本例初诊时，患者已成中风后遗证，偏枯达八年，病势沉重，显然不能按一般中风之常规论治。观其诸证，少阴寒化，阴盛阳衰已极。故投大剂四逆，随证加减，始终按少阴寒化证论治。

54、少阴证气厥

黄××，女，48岁。成都市街道居民。

[病史]经常头晕，咳嗽气紧，心累心悸，四肢乏力，头面及双膝以下腿足浮肿，迁延已有五年。严重时，自觉心往下坠，甚至短暂昏迷。1964年3月，因劳累后，突觉心累心悸加重，旋即昏迷， 不醒人事。邻友见危，欲急送医院；但家属恐途中颠簸而致气绝，遂来邀至家中急诊。

[初诊]昏迷不醒，四肢不温，面色苍白，呼吸微弱。脉沉微，舌淡苔黑润。此为少阴证气厥，立即以自制坎离丹五粒，温开水灌服，同时速煎温中扶阳之剂急救。

处方一：

川附片三份半 上肉桂一份 真琥珀二份 柏子仁二份 飞朱砂一份 麝香半份

研细末，水打丸。

处方二：

炮干姜15克 炙甘草10克

一剂煎服。
[二诊]灌下坎离丹后，约时许，病人慢慢苏醒过来。然后急进汤剂，每二小时一服。次日，自己坐车前来就诊。心累心悸稍减，四肢微觉有力，精神亦好转。黑苔减少，脉沉弱。法宜温脾补肾，以干姜附子汤主之。
处方：
干姜60克 制附片60克(久煎)
三剂
[三诊]上方连服三剂，诸证虽有好转，但久病大衰，心气亏耗，肺脾肾皆虚。宜温阳益气，健脾补中为治，以脾胃着手，滋气血之源，以理中汤加味主之。
处方：
潞党参12克 干姜片15克 炒白术15克 炙甘草6克 茯苓25克 法半夏15克
连进十余剂，诸证显著好转，操持家务如常。1979年7月追访，患者已年逾六旬，十余年来仅复发过一次，但病情较轻，恢复正常后，一直比较稳定。
[辨证]患者元气素虚，久病更加衰惫，遇劳累诱发而病势沉重。呼吸弱，脉沉微，为心气亏耗；舌淡苔黑，浮肿，肢冷，属阳气不振，肾水上泛；突然昏迷，系一时气机逆乱，中气下陷，阴气上腾，心肾不交。所幸尚未发现下利、汗出、面赤、四肢厥逆、脉微欲绝之危候，故不必立投四逆，宜用温肾补心，安神利窍之剂，令坎离相济，再以温中扶阳之品，使清阳升，浊阴降，呼吸为之条畅，神志立转清醒。然后继进驱阴助阳，温补脾肾之方，培植根本，最终以温阳益气，滋养气血为治，逐渐康复而安。
[按语] 《素问?方盛衰论篇》云：“ 是以少气之厥，令人忘梦，其极至迷 ”。论其治疗，因五脏气虚，阳气不足等皆可致病，主张应参合五脏见证，调和阴阳之气，据其经脉盛衰而f台之。本例患者，即属少气之候涉及五脏，而以心肾气虚为主。始终以温通之法，扶其心肾之阳，注意以 “ 弃阴附阳，不知并合 ” 为戒。得其要领，故沉疾较快扭

转，十余年来颇为稳定。

55、少阴证寒厥

王××，男，28岁。成都市某厂工人。

[病史]患者性情比较孤僻，善愁多郁，日久成疾，未予医治。1947年初，发现胃脘长一包块，如拳头大，以手按之，活动、有声，但不痛。急赴某地，请中医治疗。所服之药，多系桃仁、红花、三棱、莪术等活血化淤之品。治疗约半年，疗效不显，食欲日减，形萎神衰。虽七月炎暑，穿绒衣，夜覆被，仍觉不暖。后就地改请他医治疗，至次年四月，病势更加沉重。某日突然昏厥，家人误认为暴死，将其放置屋外木板之上，待殓。此时范老恰在邻舍诊病，有人急忙叩门而入曰：“ 知先生在此，余邻友病危，似已断气，盼先生亲临视之，有无救药? ” 遂前往诊视。

[初诊]只见患者面色苍白，唇乌，四肢厥冷。当即用细灯芯探试鼻息，略有微动。触胸窝， 微热尚存。切脉，似有似无。日：犹有一毫生机， 可试服药，看能否救之。并留其家中，亲自指导用药，以观察疗效。

处方一：

炙甘草30克 炮干姜15克

处方二：

炙甘草60克 干姜120克 制附片120克(久煎) 党参45克 童便为引。

令其家人，将以上两剂药，同时急火分罐煎煮。先取首方煎好之汤剂半盅，频频灌之。服后约一刻钟，患者逐渐发出轻微鼻息声，手足微微蠕动。待等二方煎成，又立即灌服。药后二时许，慢慢苏醒过来，神志逐渐清楚，方知已将自己抬出室外，家人正备后事。

[辨证]初诊时，患者已待殓。试鼻息，触胸窝，切其脉，观其色，问其病史，此乃属少阴病阳衰阴盛已极，尚存一丝微阳，有倾刻欲脱之危。应急投四逆汤驱阴回阳。但附子须久煎，恐失救逆之机，故先投以甘草干姜汤，辛甘合用，专复胸中之阳，肺气得温，呼吸通利，而垂绝之阳不致立断。然后再以大剂四逆加参，回阳益阴，救元气于垂

绝之乡；加童便引阳入阴，使阳昌阴和而回生。
[二诊]语气低微，气不接续；阳气虽回，但气血虚衰已甚。再拟理中汤加味，补脾壮肾；又因其胃脘尚有寒凝积聚，故少佐驱寒散结之品。
处方：
党参18克 干姜120克 炙甘草120克 白术18克 制附片250克(久煎) 茯苓15克 补骨脂12克 枸杞60克 吴茱萸10克 山萸肉30克 白胡椒10克
上方服一剂，略知饥欲食，可进流质少许。原方再进四剂，病情大有好转，每餐能食稀粥一小碗。
[三诊]面色略有润泽，精神转佳，但萎黄未消，食欲不振。仍以理中汤加味，俾土气旺，以助生机。
处方一：
党参15克 炒白术30克 炙甘草60克 干姜120克 制附片250克(久煎) 上肉桂20克(冲服) 枸杞30克 桂枝15克 茯苓25克
处方二：
砂仁30克 白蔻30克
共研细末，饭后冲服少许。
根据病情，上方加减共服两月余，诸证消除，身体复原。1979年追访，患者已五十九岁，三十多年来，能经常上夜班，身体一直较好。
[按语]“厥”证之病理，乃阴阳气不相贯通。轻者手足厥冷，猝然昏倒；重者一厥不复，以致死亡。故《内经》论厥逆甚详，《伤寒论》多救逆之法。但就厥之属性，非寒即热。故《素问?厥论篇》云：“阳气衰于下，则为寒厥；阴气衰于下，则为热厥”。临证救逆，必须详辨。
本例寒厥之证，审查内外，辨证求因，可知其寒不从外，皆从内。法宜调其阴阳，治其主经之病。此少阴病阳衰阴盛已极之证，急投辛甘复阳救逆之剂，使阴阳气得以顺接。故待殓之患者，顿时回春。

56、少阴证真寒假热(高热)
车××，男，74岁。成都市居民。

[病史]1975年4月初，感受风寒，全身不适。自以为年迈体衰，营卫不固，加之经济困难，略知方药，遂自拟温补汤剂服之。拖延十余日，病未减轻，勉强外出散步，受风而病情加重。头昏体痛，面赤高热，神志恍惚。邻友见之急送××医院。查体温39℃，诊为感冒高热，注射庆大霉素，并服西药，高烧仍不退，病势危重，邀范老至家中急诊。
[初诊]患者阵阵昏迷不醒，脉微欲绝。已高烧三日，虽身热异常，但重被覆盖，仍觉心中寒冷。饮食未进，二便闭塞。双颧潮红，舌淡润滑，苔厚腻而黑。患者年逾七旬，阴寒过胜，恐有立亡之危。虽兼太阳表证，应先救其里，急投通脉四逆汤抢救之。
处方：
生甘草30克 干姜60克 制附片60克(久煎) 葱白60克
[辨证]患者高热，神昏，面赤，苔黑，二便不通，似阳热之象。虽高热，反欲重被覆身；身热面赤，而四肢厥冷。二便不通，却腹无所苦。苔黑厚腻，但舌润有津。高烧神昏，无谵妄狂乱之象，而脉现沉微。参之年已古稀，体弱气衰，实一派少阴孤阳飞越之候，生气欲离，亡在倾刻。故应急投通脉四逆加葱，直追其散失欲绝之阳。
[二诊]服上方二剂，热退，黑苔显著减少。阳回而阴霾之气初消，阴阳格拒之象已解。但头痛、身痛，表证仍在；肾阳虚衰，不能化气，故仍二便不利。以麻黄附子甘草汤驱其寒而固其阳，加葱生少阳生发之气。
处方：
麻黄10克 制附片60克(久煎) 生甘草20克 葱白120克
四剂
[三诊]上方服四剂，头不觉昏，二便通利，黑苔退尽。唯身痛未除。虽阳回、表解，仍舌淡， 肢冷，阴寒内盛，呈阳虚身痛之象。宜温升元m而祛寒邪，以四逆加辽细辛主之。
处方：
炙甘草20克 干姜30克 制附片60克(久煎) 辽细辛6克
二剂

[四诊]服二剂，余证悉除。其大病瘥后，真阳虚衰，以理中汤加味调理之。
处方：
潞党参15克 炒白术10克 炙甘草10克 干姜片15克 制附片30克 茯苓12克
1979年7月18日追访，患者已79岁高龄，自病愈后，几年来身体一直较好。
[按语] 临证辨别寒热，并不太难。但物极必反，“ 寒极生热，热极生寒 ”。此等寒热真假之辨，一旦有误，危情叵测。前人对此，曾有较多之阐发。
本例证似阳热，而脉微欲绝，脉证不符。范老遇此寒热真假难分之际，全面审度，突出舌诊：其舌质淡，为阴寒盛；苔黑而润滑有津，乃肾水上泛。断不可误认为阳热，实为阴寒内盛已极，虚寒外露之假象。故遇此类危证，效仲景之法，敢于突破，常获显效。

57、少阴证下利虚脱(正伤寒)
黄××，男，11岁。原四川成都市学生。
[病史]1948年秋，初感全身不适，以后病情逐渐加重，神志昏迷，高热至40。c以上，腹泻。当时正值肠伤寒流行季节，原四川省立医院确诊为“ 正伤寒 ”，某专家认为，病已发展至极期，全身性中毒过重，已属不治之症。后由中医会诊，曾以大量犀角．羚羊角、紫雪丹等抢救。患儿虽高热退，腹泻止，而病势却更加沉重，四肢冰冷，脉欲绝，终至垂危。最后来诊，按少阴证下利虚脱论治，初诊机转，数诊痊愈。
[初诊]患儿连日来昏迷蹑卧，面色灰白乌暗，形体枯瘦。脉伏微细欲绝，唯以细灯草试双鼻子L，尚有丝微气息。四肢厥逆，手冷过肘，足冷过膝，甚至通体肢肤厥冷。此为病邪已由阳入阴，发展为少阴阴寒极盛，阳气倾刻欲脱之险恶阶段。急用驱阴回阳，和中固脱之法，以大剂通脉四逆汤一剂灌服急救。
处方：
川附片120克(久煎) 干姜120克 炙甘草60克

[二诊]上方，连夜频频灌服，至翌日凌晨，患儿家长慌忙赶来连声说：“ 坏了坏了，服药后鼻中出血了! ” 范老立即回答：“ 好了好了，小儿有救了! ” 遂再诊。患儿外形、病状虽与昨日相似，但呼吸已稍见接续、均匀，初露回生之兆。宜继守原法，以通脉四逆倍加用量再服。

处方：

川附片500克 干姜500克 炙甘草250克

先以肥母鸡一只熬汤，另以鸡汤煎附片一个半小时，再入姜、草。服药后约两小时，患儿忽从鼻中流出紫黑色凝血两条，约三寸长，口中亦吐出若干血块。这时缓缓睁开双眼，神志开始清醒，并开口说：“ 我要吃白糕! ” 全家顿时破涕为笑，皆大欢喜。遂遵原方，再进四剂。

[三诊]患儿神志已完全清醒，语言自如，每日可进少量鸡汤等流质。面色青暗。舌质淡白，乌暗，无苔。上肢可活动，开始端碗进食，下肢僵硬，不能屈伸，四肢仍厥冷。病已开始好转，阳气渐复；但阴寒凝聚已深，尤以下肢为甚。原方稍加大曲酒为引，再服。

上方又服一剂后，次日下肢即可慢慢屈伸。再服两剂，能下床缓步而行。服至十三剂，逐渐康复。

患者于1978年12月26日来函说：“ 三十年前，范老治好我的病以后，我于1953年参军，在部队还立了两次三等功，现在机械配件厂当钳工，身体一直很好。 ”

[按语] 此例由于失治，病由阳入阴，阳气衰微，阴寒凝滞，即阴阳气血已不能充实于四肢叽肤，故现面色灰白乌暗，脉伏细微欲绝，四肢通体逆冷，甚至昏厥不省。显然，病势已发展至少阴寒化之危重阶段，属典型之四逆证。值此纯阴微阳之际，千钧一发之时，一切以阳气之存亡为转移。阳存可生，阳亡立死，非急投以大剂通脉四逆回阳救逆不可。

四逆汤为仲景回阳救逆之主方。若能正确掌握，辨证施治，姜附草三昧，即能起死回生。郑钦安曾说：“ 仲景深通造化之微，知附子之力能补先天欲绝之火种，用之以为君。又虑群阴，阻塞不能直入根蒂，

故佐以干姜之辛温而散，以为前驱，荡尽阴邪，迎阳归舍，火种复兴，而生命立复，故日回阳。阳气既回，若无土复之，光焰易熄，虽生不永，故继以甘草之甘，以缓其正气。缓者即伏之之义也，真火伏藏，又得重生也，此方胡可忽视哉。”(《医理真传》)

四逆汤再加=F姜一倍，即本例所用之通脉四逆汤。干姜佐附子，更能除六腑之沉寒，回三阴之厥逆，救肾中元阳，脉气欲绝者。倍干姜，尤能增辛热以逐寒邪，取辛温而散之义，加强荡涤阴邪，迎阳归舍之效。灌服后，患儿忽然鼻孔出血，家长惊慌失措，以为误用姜附必死无疑!殊不知此病后期一派阴气弥漫，复进苦寒退热之品，犹如冰上加霜，周身气血趋于凝聚。此时转投大剂通脉四逆汤，回阳返本，峻逐阴寒，冰伏凝聚之血脉为之温通；阳药运行，阴邪渐化，血从上窍而出，实为通脉四逆推墙倒壁之功，初见起死回生之兆，何惊骇之有?此时此刻，又抓住转机，当机立断，在原方大剂量基础上再加倍翻番，姜、附均增至500克，凝结之血条血块，均被温通而逐出。正邪相搏出现新的突破，患儿终于转危为安。

或问：本例患儿在半月之内，每剂附子用量250～500克，累计6500克，经过三十年之检验，预后良好。附子的有效量和中毒量问题，是否值得重新探讨?

实践是检验真理的唯一标准。我们认为，上述问题如何从理论与实践的结合上，努力运用现代科学手段深入研究，对发掘祖国医药学的伟大宝库，是一项重要的课题。

58、少阴证淋病(前列腺炎)

张×，男，57岁。某电影制片厂导演。

[病史]1961年冬，在某地农村，睡新修湿炕而致病。初起，一侧睾丸肿大，坐立行走均疼痛难忍。因未能及时就医而日益加重。××医大附院确诊为“前列腺炎”。经某中医研究所治疗一年而愈。1974年冬，旧病复发，先后迁延约三年。开始仅尿频，睾丸不适；服中药清热利尿剂数付，即告缓解。其后屡犯屡重，不仅尿急，尿频，尿路灼痛，并常感生殖器冰冷麻木。××医院检查确诊，仍羁“前列腺炎”(检查报

告：脓球“B”，磷脂体少许，白血球每高倍镜视野50个以上，红血球每高倍镜视野30个)。从1977年4月至8月，开始采取中西医各种方法治疗：化疗、超声波理疗、热水坐浴、针灸、按摩等，同时服清热解毒利湿等中药150多剂。但自觉症状有增无减，并发展至阳萎，全身瘫软，步履艰难，终于被迫全休。1977年8月30日来诊，按少阴阳衰阴盛证论治，治疗三个月病愈。

[初诊]恶寒蹐卧，肢体萎软，神靡，头晕，失寐，食欲大减(每餐只进一两)。睾丸坠胀及腹，常感凉麻疼痛，小便浑浊频数，阳萎。面色萎黄暗黑，舌质淡白，全舌白苔密布，根部苔淡黄厚腻，脉象沉微细。此为少阴阳衰，阴寒内盛，法宜补阳温肾，散寒止痛。以四逆汤加上肉桂主之。

处方：

川附片120克(久煎) 干姜120克 炙甘草60克 上肉桂15克(研末冲服)

三剂

连服三剂，少腹和睾丸坠胀疼痛减轻，小便色转清，尿频也好转，阳气渐复，原方附子、干姜减至60克；再加茯苓，炒白术，以健脾除湿，继服三十剂。头晕、失眠、恶寒、乏力、少腹及睾丸坠胀，均进一步减轻，生殖器凉麻之感亦较前轻微。

[辨证]此病恶寒肢冷，神靡蹐卧，为心肾阳衰，不能温煦，正气不足，反为邪困；睾丸坠胀，常感凉麻疼痛，为肾气衰弱，不能温养筋脉，阴寒凝聚，气血阻滞。这表明少阴阳虚寒化之主证已比较突出。少阴寒化之阴寒内盛，属阴、属里、属虚、属寒，为全身性之虚寒证，必然累及人之整体机能及多种脏腑。小便频数，为肾气亏耗，固摄失司；小便浑浊，为气虚失调，不能制约脂液。阳萎，为下元亏损，命门火衰，失其作强。面色黄为寒湿；黄而萎，属脾阳不振；兼黑为寒，为痛；暗而无泽，乃肾阳虚衰。舌质淡者阳气之败；白者脏腑极寒。脉象沉而无力，里虚甚；微者，阳气衰而无力鼓血行；细者，阴血不足，脉道不充。综上所述，皆属少阴寒化，阳衰阴盛之主证贯穿全局。须抓住根本，以驱阴扶阳为急务。

[二诊]恶寒神靡，生殖器凉麻痛等证进一步好转。舌质稍现红润，黄白厚腻之苔已减。惟少阴心肾两脏，心主血主火；肾为水火同宫之脏，藏真阴真阳之气。患者全身性虚寒证，不仅伤及肾阳，同时累及肾阴。法宜继续温补肾阳，兼顾其阴，再佐以温中健脾为治。以四逆并理中加味主之。

处方：

川附片60克(久煎) 干姜60克 炙甘草60克 党参30克 上肉桂10克(研末冲服) 冬虫夏草15克 宁枸杞30克 菟丝子30克 云苓20克

服药十余剂，诸证继续好转。其后，根据病情加减，姜附减至30克，又服十余剂。

[三诊]经检查，前列腺炎基本痊愈；同时，多年来之低血压、头昏、失眠等证，亦均消失；饮食骤增，精神大振。后以壮阳益肾，养心安神之剂，配成丸药，缓缓调养，以巩固疗效。

处方：

川附片120克 上肉桂30克 朱砂15克 冬虫夏草30克 琥珀20克 麝香O．3克 宁枸杞30克 肉苁蓉30克 柏子仁30克 菟丝子30克

每日服两次，每次1克。

1977年12月初，病愈而恢复工作。1978年12月10日来信说；“ 我们的工作，经常需要爬山涉水， 战严寒、酷暑、大雪、狂风、烈日、暴雨……。我的病经范老治愈后，已拍完一部故事片；目前，正准备迎接新的战斗 ”。

[按语] 本例并非四逆证，为什么要用四逆汤?

《伤寒论》中的四逆汤，为回阳救逆的主方，但根据范老多年的临床经验，其作用不局限于此。除阳虚欲脱，脉微欲绝等典型四逆证以外，还可广泛用于一切阳虚阴盛之病人。

从伤寒六经辨证来看，大凡三阳病中某些变证、坏证，三阴病中之虚寒证，皆可酌情用之。

在临床上如何准确地、灵活地运用四逆汤?关键在于严格掌握阳虚阴盛疾病的基本要点。除上述典型的四逆证以外，这些要点，大体上还包

括： 舌质淡白，苔润有津；面色晦暗无泽；神疲，恶寒，四肢清冷，口不渴，或渴而不思饮；或喜热饮；大便不结，或虽大便难而腹无所苦，或先硬后溏，夜尿多，脉弱等。
在准确辨证的前提下，还必须严格掌握用药配伍和剂量轻重。附子用量应针对病情恰如其分，并须久煎一个半小时以上。附子无姜不燥，干姜的用量须灵活掌握。在阳虚阴盛而未至四逆，舌质虽淡而不甚，苔虽白而不厚的情况下，干姜可酌情少用；反之可多加，直至与附子等量。甘草的用量不超过附子的一半，大体与干姜相等。
必须指出，阳虚明盛之人，初服辛温大热之品，常有心中烦燥，鼻出黑血，喉干，目涩或赤，咳嗽痰多，面目及周身浮肿，或腹痛泄泻，或更加困倦等，此并非药误，而是阳药运行，阴去阳升，邪消正长，从阴出阳之佳兆。服药后比较理想的反应，是周身暖和，舌质和面色均现红润。此时即可用少量滋阴之品，以敛其所复之阳，阳得阴敛，则阳有所依，自然阴阳互根相济，邪去正安。

59、少阴证淋病
肖××，女，36岁。四川广汉县某小学教员。
[病史]小便不畅已十余年，重则尿黄窘迫，欲解不出。尿道灼痛，淋漓不尽。经多方检查治疗，疗效不显。1960年8月来诊。
[诊治]每昼夜小便数十次，量极少，有时仅数滴，涩痛，腰及小腹亦觉疼痛；下阴糜烂，白带多；四肢不温；舌尖边红，苔白滑。此为少阴阳郁，气机不利。法宜宣通气机，化阴通腑。以四逆散加味主之。
处方：
柴胡24克 白芍24克 枳实24克 甘草9克 桔梗30克 茯苓30克
四剂
另以自制九成丹涂下阴患部。
服后，小便通利，诸证悉解。下阴糜烂已好转。再以少量丹药涂于患处，半月后获愈。
[分析]《伤寒论》云：“ 少阴病，四逆，其人或咳，或悸，或小便不利，或腹中痛……四逆散主之。 ”本例之小便不利，四肢不温，并腹

中痛，为邪入少阴，阳为阴郁。少阴为三阴之枢，邪气滞于中，清浊不分。加之患者久病不愈，郁积而气机阻滞日甚。投四逆散举下陷之阳邪，疏不宣之气机。以柴胡启达阳气，兼解郁滞；芍药养真阴，调解肝脾，俾土木和而气机流畅；柴枳同用，一升一降，清浊分行。仲景原方注：小便不利加茯苓。恐其力缓，仅渗湿不足以畅气机。肺为水之上源，行呼吸，主一身之气，喜清肃，取下行为顺。今外邪固束，则水道难于通调，故重用桔梗，辛开苦降；茯苓利水，与桔梗之开提相合，亦为一升一降。水邪消，诸证自平矣。

[按语] 《素问?灵兰秘典论篇》日：“ 膀胱者，州都之官，津液藏焉，气化则能出矣。 ” 可见小水虽由膀胱所司，若无气机之转化，焉能排出而为溺?故小便之病变，与肾、肝、脾、肺、三焦之气化，关系密切。在临证中，对各种原因之小便失利或不禁，往往以相关脏腑经络全面考虑。范老认为，凡尿频、尿急，欲出不尽，或闭塞不通，排尿涩痛；小腹、两胁、腰部或胀或痛或酸；上述诸证，不必悉具，皆可以四逆散辨证加减论治。

60、少阴证淋病

王××，女，67岁。山东省荣城县居民。

[病史]患者十多年来，经常小便频急，重则淋漓涩痛，点滴不尽。曾多次验小便，均属正常。先后服大量抗菌素和利尿药，并以补肾气、除湿热等法论治，时好时坏。近来病情加重，转来求诊。

[诊治]1978年12月5日。近一月来，约隔半小时解小便一次，量极少，一昼夜排尿总量仅300多毫升，色黄如浓茶。小便灼热，欲解不尽；四肢不温，少腹胀满疼痛，日夜不宁。舌质淡红稍暗，苔白滑。此为邪入少阴．阳郁不伸，水气不化。法宜宣通气机，化阴通腑。以四逆散加味主之。

处方：

柴胡10克 白芍10克 枳实10克 甘草3克 桔梗15克 茯苓20克

四剂

服后小便通利，病遂获愈。

1979年5月15日随访：其女告之，病愈后， 已回山东原籍。最近来信，病未复发。
[按语] 肖、王二例少阴证淋病，病因、病情和病程大体相似。仅囚王例年逾花甲、证状较轻，故药量稍减。均投四逆散加茯苓、桔梗为治。皆一诊而愈。

61、少阴证淋病(肾盂肾炎)
周××，女，40岁。成都某厂职工。
[病史]1973年5月，患腰痛，小便不利。先后经两处医院检查：尿液混浊，有大量白细胞，少许红细胞，少量尿蛋白，血象白细胞计数增高。均诊断为“肾盂肾炎”。服中西药三月余，病势未减。同年8月来诊。
[初诊]1973年8月29日。近月来病情逐渐加重：小便短涩，频数，色黄，欲解不尽，点滴刺痛，并痛引小腹，腰痛尤甚。头痛恶寒，无汗，手足不温，面色略萎黄，舌质淡红，苔薄黄。此为淋病，证属少阴，兼太阳伤寒之邪，交织蕴积。法宜先从太阳入手，发表散寒，开腠逐邪，以甘草麻黄汤加味主之。
处方：
麻黄10克 甘草30克 葱白60克
二剂
[二诊]头痛、恶寒明显好转，腰痛减轻，小便短涩频数略减。余证如前。薄黄苔已退，太阳之寒邪已解。宜抓住少阴之枢，宣通气机，化阴通腑，以四逆散加味主之。
处方：
柴胡10克 枳实12克 白芍12克 甘草3克 茯苓30克 桔梗30克
三剂
连服三剂，小便通畅，尿转阴性，余证皆平。1979年11月随访，几年来坚持重体力劳动，病未复发。
[按语] 《金匮要略》云：“淋之为病，小便如粟状，小腹弦急，痛引脐中”。本例小便频数短涩，滴沥刺痛，痛则腰酸，实属淋病之主要

临床特征，而其基本病变为下焦气化不利，属少阴四逆散证。但，本案为何首用甘草麻黄汤?
少阴证虽有发汗之禁，复有淋家不可发汗之戒；但此例兼有太阳伤寒表实证，故不在此禁戒之例。少阴发汗之禁，乃指“病为在里”而言，一是少阴寒化，阳气已虚；一是少阴热化，阴虚内热。本例不仅表邪郁闭，阻滞气机，加重气化功能失调；而且此证虽属少阴，既非四逆汤证，又非热化证；病虽入里，而阳气未虚。虽属淋病，但既非湿热蓄于膀胱，又非膀胱津液先虚。实属少阴病四逆散证之阳为阴郁，气机不利。今首用《金匮要略》甘草麻黄汤，既可发表散寒，又能通利小便。重用甘草以托之、缓之。再加葱白，通上下阳气，调畅气机。故此方似峻而实稳，内外兼顾，以为前驱。后投四逆散加味，借少阴之转枢，并邪居内外之间，可进可退、时上时下之势，和解而分消之，病遂告愈。

62、少阴证经闭
胡××，女，38岁。四川郫县团结乡，农民。
(病史]经闭四年，经治疗其效不显，发至形寒，肢冷，颤抖，全身水肿，行动须人搀扶。1953年4月来诊。
[初诊]全身皆水肿，下肢尤甚，按之凹陷，遍体肌肉轻微颤抖。头昏，畏寒，不欲食，神疲倦卧，四肢清冷，声低气短。面色青暗无泽，舌淡，体胖，有齿痕，苔薄白，脉伏。此为少阴证经闭，阳虚水肿，法宜通阳渗湿，暖肾温中，以茯苓四逆汤加味主之。
处方：
茯苓30克 潞党参15克 炙甘草30克 干姜60克 制附片120克(久煎) 桂枝12克 炒白术12克
[二诊]服完第一剂，小便清长，肿胀略有减轻，每餐可进食米饭一两。继服二剂后，肿胀明显好转，颤抖停止。嘱其原方再进三剂，并以炮姜易干姜，加血余炭30克，返家后续服。月余病愈。
1979年7月追访，患者已63岁，自从二十六年前病愈后，直到经绝，月经一直正常，身体健康。

[辨证]患者系中年农妇，原体强健，后几年停经，一蹶不振。初诊时，病已沉重，究其原因，一则常年耕耘，历尽风霜雨露，积冷伤湿，而致寒凝血滞。正如《金匮要略》所云：“ 妇人之病，因虚、积冷、结气，为诸经水断绝。 ”二则久病精气衰惫，加之前服中药大多破淤攻下之品，挫伤脾肾之阳，以致肾水泛滥，脾不制水，全身肿胀。经云：“ 诸寒收引，皆属于肾 ”，“ 诸湿肿满，皆属于脾 ”。故此证属脾肾阳虚，阴寒内积，而以少阴虚衰为主。畏寒、肢冷、神疲倦卧，声低气短，面色青暗，舌淡脉伏，皆一派少阴寒化之明症。治以茯苓四逆汤，姜附回阳逐阴，甘草缓中，茯苓渗利，党参扶正。加白术补脾燥湿，增桂枝以通心阳而化膀胱之气；加炮姜易干姜，取其温经助血之行；再加血余炭，既有去淤生新之效，又具利小便之功，以促其肿胀之消除。

[按语] 本例患者，血寒凝滞，误用攻下，一以致阴阳两伤，经闭水肿，复因失治而致阴阳两虚；故取茯苓四逆汤，善消阳虚水肿之效，兼顾其阴。加温经散寒，逐淤生新之炮姜、血余炭，突破经阻之要害，诸症迎刃而解。

63、少阴证不孕

黄××，女，34岁。四川某机关干部。

[病史]已婚七年未孕，男女双方经检查生理正常。1959年冬开始，自觉头昏、乏力，早晨脸肿，下午脚肿，月事不调。1965年春，病情发展严重。同年7月20日来诊。

[初诊]闭经半年，白带多。全身轻度浮肿，下肢较重。周身疼痛，畏寒，多梦，纳差，血压有时偏高。小便不利，大便先结后溏。舌质淡，体胖嫩，边有齿痕，苔白滑，中间厚腻，脉沉。此为邪入少阴，火衰水旺，肾阳虚衰，经水不调之不孕证。首以真武汤加减，温阳化气行水为治。

处方：

制附片120克(久煎) 茯苓30克 生姜30克 桂枝15克 炮姜30克 炙甘草15克 四剂

[二诊]服上方，全身浮肿显著消退， 食欲增加。原方再服四剂。
[三诊]神疲、恶寒等证虽有好转，但仍血枯经闭。原方并当归补血汤加减主之。
处方：
制附片60克(久煎) 茯苓20克 白术15克 生姜30克 桂枝10克 黄芪30克 当归10克 炙甘草10克 炮姜30克
[四诊]上方服至八剂时，月经来潮。色淡量少，有淤块。小腹发凉隐痛。仍有宫寒凝滞之象，以温经汤加减主之。
处方：
吴茱萸6克 当归10克 川芎6克 白芍10克 血余炭20克 炮姜20克 炙甘草10克
二剂
[五诊]小腹冷痛消失，淤血显著减少，诸证明显好转。嘱其忌生冷，戒房事半年。并书一方，回家缓服调养。
处方：
制附片60克(久煎) 上肉桂10克(冲服) 炮姜30克 血余炭20克 菟丝子20克 肉苁蓉10克 黄芪30克 当归10克 泡参15克 炙甘草15克 枸杞20克 巴戟12克
1979年7月26日追访：患者说，前后共服药百余剂，并遵范老所嘱调养，1967年怀孕，现已有两个孩子。
[按语] 《素问?上古天真论篇》曰：“ 女子……任脉通，太冲脉盛，月事以时下，故有子。 ” 本例月事不调，时行时止，显系冲任二脉损伤， 焉能妊娠?
导致阴脉血海之损害，原因很多。本例病根，在于少阴真火虚衰，肾阳不振，又累及于脾。故现龙飞水泛，后天生化乏源，日益气虚血枯，寒凝胞宫，经脉受阻，月事不下。故首投温阳化气行水之剂，重用姜附，镇纳群阴。再以补血益气，温经散寒为治。脾湿除，气血调，任脉通，血海盛，经期正，连生二子。

64、少阴证胎黄

吴××．男，新生儿，55天。成都某厂职工之子。
[诊治]1957年7月来诊。患儿足月顺产，初生即周身发黄。现已55天，体重1．5公斤，身长30多公分。身面长满黄色细绒毛，长约l公分，皮肤晦黄不退。精神萎靡，四肢不温，皮肤干涩，头发稀疏、黄糙，生殖器肿大。虽值炎暑，还须棉花厚裹。稍受微风或惊动，皆易引起呕吐。××医院诊为：“ 先天不足 ”，未予治疗。范老认为临床罕见，殊难入手。其母再三恳求，方同意试治。询其妊娠期间身体状况，得知怀孕后，嗜饮大量浓茶，每日约5至6磅，连茶叶均嚼食之。故脾阳受伤，湿从内生，湿邪久羁，遗于胞胎。致新生儿先天亏损，脾肾阳气衰微，气亏血败，经隧受阻，胆液浸淫，溢于全身肌肤，故发为胎黄，日久不退。精神萎靡，四肢不温，头发稀疏而黄糙，亦显为少阴阴盛阳微之征。法宜破阴回阳，以通脉四逆汤加味主之，配以针砂散，祛脾胃之湿浊。
处方一：
制附片15克(久煎) 干姜15克 甘草10克 辽细辛1克 葱白30克
处方二：
针砂散。
每日晨用米汤灌服O．6克，连服20日。
月余后，患儿身黄退，体重略增，逗之能笑。遂停药，嘱其细心调养，此后逐渐健康成长。
1978年12月18日追访：患儿已长成人，参加工作。体重110斤，身高1．64米。喜爱体育运动，在中学时为业余足球运动员。
[按语] 此例虽属罕见，但按六经辨证，其主证既属少阴，并兼太阴寒湿；因此，病在何经，即可用其法其方施治。本案之获效，初看之，似某方某药之功，实则六经辨证生命力之所在。进而剖析，婴儿脾肾阳气不振，寒湿郁滞运化失常，胆汁被阻溢于肌肤；参之肢体不温，发育不良等，应属少阴阴黄。故投以通脉四逆，以助先天之元阳，配以针砂散除脾胃之湿浊。阳旺湿消，气机通畅，则邪去自安。

65、厥阴证头痛眩晕(美尼尔氏综合症)

黄××，女，34岁。成都市某商店职工。
[病史]1970年以来，经常患头痛、眩晕、干呕，甚则晕倒，经数家医院皆诊断为“美尼尔氏综合症”。
[初诊]1972年1月来诊。头顶痛甚，干呕，吐涎沫；眩晕时，天旋地转，如坐舟中；四肢无力，手足清凉。面色萎白无华，舌淡润少苔，脉微细。此为肝胃虚寒，浊阴上逆，病属厥阴寒逆头痛眩晕。法宜暖肝温胃，通阳降浊，以吴茱萸汤主之。
处方：
吴茱萸10克 潞党参20克 生姜30克 红枣30克
四剂
[辨证]在《伤寒论》中，吴茱萸汤主治病证有三条：一属阳明之胃家虚寒；二属少阴吐利；三属厥阴寒证。其共同之点，皆有呕吐这一主证。阳明虚寒食谷欲呕；少阴吐利；厥阴干呕吐涎沫，其病机之共性，皆为中虚气逆，浊阴上犯。
但本例厥阴干呕吐涎沫，还有头痛一证，此乃病属厥阴经之显著特征。其所以成为特征，一是因为厥阴受邪，循经气而上逆巅顶，故头痛，且其部位常在头顶。二是厥阴受寒，肝木横逆，寒邪挟浊阴之气上逆而犯胃土，以致中气虚弱，脾气不升，胃气不降。清阳不足，干呕气逆上冲则头痛；其眩晕，正如《素问?至真要大论篇》所云：“诸风掉眩，皆属于肝。”总其要，厥阴肝寒为本，阳明胃寒为标，病属厥阴寒证。
[二诊]上方服四剂，呕吐止。头痛，眩晕，明显减轻。但仍眩晕，其所以眩晕者，因其病在肝，而其根在肾。宜继进温补脾肾之剂，以理中汤加味缓缓服之。
处方：
潞党参20克 炒白术18克 炙甘草15克 干姜30克 制附片30克(久煎) 茯苓15克 上肉桂10克(研末冲服)
服二十余剂，诸恙悉安。1979年7月追访， 自从痊愈以来，再未重犯，始终坚持全勤。

[按语] 本例厥阴头痛眩晕之证，与美尼尔氏综合症相似。其病因现代医学至今尚未完全清楚。中医虽无此病名，但根据辨证，多属肝肾。《灵枢?海论篇》云：“ 髓海不足，则脑转耳鸣，胫酸眩冒，目无所见 ”，亦即此理。邪入厥阴，从阴化者居多，常见干呕，吐涎。其标在胃寒，其病在肝寒，其根在肾寒，故先后投以燠土、暖肝、温肾之剂，病祛根除而晕痛皆止。

66、厥阴证肠游(急性痢疾)

江××，男，39岁。成都市金牛区营门口乡，农民。

[病史]1977年8月下旬，在田间劳动忽感全身难受，四肢发凉，头冒冷汗，腹痛肠鸣。旋即昼夜腹泻，下利频繁，夹脓带血。9月2日急来求诊。按厥阴证肠澼论治，服药两剂痊愈。

[诊治]每日下利十余次，便稀带粘冻状，色黄赤，伴有腹痛，里急后重。兼见干呕、心烦、口渴、肢冷。舌质暗淡，尖部稍红，苔黄腻而厚。此为寒热错杂证肠澼，病在厥阴。法宜驱邪扶正，寒热并用，以乌梅丸主之。

处方：

乌梅30克 辽细辛6克 干姜30克 黄连12克 当归10克 制附片60克(久煎) 蜀椒6克 桂枝lO克党参12克 黄柏10克

二剂 忌食油荤、生冷。

上方连进两剂，肠游痊愈。1979年6月随访，患者说：一年前病愈后，至今未再复发。

[辨证]《素问?太阴阳明论篇》云：“ 贼风虚邪者，阳受之；食饮不节，起居不时者，阴受之。阳受之，则入六腑；阴受之，则入五脏……入五脏则膜满闭塞，下为飧泄，久为肠游。 ”可见肠游往往与阴阳乖和有关，并现寒热混淆诸证。

本例上热下寒之证十分明显。厥阴为风木之气，偏盛则风邪上窜。今患者干呕、心烦、恶心，舌尖较红，皆为上热。肢体厥冷，小腹冷痛，下利清稀，间夹乌白冷冻，其下寒诸证尤为明显。归根到底，其病机在于阴阳之气不能相互贯通。是以上为阳，阳自阳而为热；下属

阴，阴自阴而为寒。亦即“厥阴之胜”所致之肠澼，故以乌梅丸移治之。
[按语] 乌梅丸“又主久利”，本例并非久利，为何投此方?
一般而论，厥阴之证，非厥即利。久利多属寒热错杂之病，则宜寒温并用之法，力求寒热夹杂之方。本例虽非久利，因证属厥阴，寒热互见，乌梅丸恰为寒热温补并用，辛酸甘苦兼备之方，正与本例对证，故移用原方而获效。
实际上，古今医家曾将乌梅丸移治多种杂证，尤其对下利之治疗，更有不断扩展。以《千金方》为例，仿仲景“又主久利”之意，用乌梅、黄连治热利；配附子、干姜等治虚寒性久利。《圣济总录》以乌梅丸治产后冷热利久不止。《证治准绳》用本方治胃腑发咳，呕出长虫。日人雉间焕说：反胃之证，世医难其治，此方速治之，实奇剂也(转引自《论伤寒论初稿》)。任应秋认为：乌梅丸有强壮胃肠机能和消炎杀虫作用，所以对慢性腹泻病亦有效(《伤寒论语译》)。不久前，曾有用本方治愈迁延十五年结肠炎之报道。可见乌梅丸之应用范围，并不局限于蛔厥与久利，在实践中已有不断发展。

67、厥阴证骨痹
刘××，男，60岁。成都某机关干部。
[病史]患腰腿关节疼痛已十余年，痛有定处，遇寒痛增。开始右膝关节较重，左腿及腰痛稍轻；1956年以后，更加冷痛沉重，下肢伸屈不利，以至不能下地活动。当地医院诊断为风湿性关节炎。1960年6月来诊，按厥阴寒证骨痹而获效。
[初诊]下肢冷、骨痛、麻木、拘挛、沉重，右腿尤甚。伸屈行动困难，须靠拐杖或搀扶方能移步。面黄晦黑，舌质微乌，苔薄灰白，脉沉细。此为气血皆虚，寒湿内搏于骨节所致。法宜养血通络，温经散寒。以当归四逆汤加味主之。
处方：
当归10克 桂枝10克 白芍10克 辽细辛3克 木通lO克 红枣30克 生姜10克 苏叶10克 甘草6克 防风10克 牛膝10克 木瓜10克

六剂
[二诊]上方连服六剂，右腿已能屈伸，开始着力缓缓而行；骨节冷痛、拘挛亦减。厥阴伤寒之外证初解，多年痼疾松动；但患者年已花甲，六脉沉细无力，舌质仍暗淡无华，久病衰弱之象益显。法宜驱阴护阳，温补脾肾，以理中汤加味主之。
处方：
党参15克 白术12克 炙甘草15克 干姜12克 肉桂3克 制附片30克(久煎)
上方服二十余剂，从此行动自如，恢复正常工作。1979年8月6日追访：患者系红军干部，现已79岁。经范老于1960年治愈后，虽在1963年曾患肿病，有所反复；但当时腿仍能屈伸，关节疼痛不甚，尚可自由行动。至今能在室内外散步。
[辨证]此例明显之主证，为下肢关节拘挛冷痛，右腿屈伸履步尤艰。参之脉证，诊为痹证似无疑义。但为什么缠绵多年，几成废足?其病因、病位、病机之理何在?究属何经之病?必须详加辨证。
《素问?痹论篇》云：“风寒湿三气杂至，合而为痹也。其风气胜者为行痹；寒气胜者为痛痹；湿气胜者为著痹也。”这里既概括了引起痹证的三种外邪，又表明三痹不同的主证。不仅如此，根据风寒湿邪侵入之部位，进而分为骨、筋、脉、肌、皮五痹。又云：“痹在于骨则重；在于脉则血凝而不流；在于筋则屈不伸；在于肉则不仁；在于皮则寒。”可见三痹指病因，五痹言病位，并包括症状在内，互相联系而不可分割。
以本例患者而言，临床表现下肢疼痛较剧，且关节重着，固定不移。寒为阴邪，侵入人体，阴经受之；客于筋骨肌肉之间，故迫使气血凝滞，遇冷则痛更增。参之面色青黄，舌质乌暗，苔现灰白，皆属寒主痛，可知寒凝痛痹，乃其主证。
患者自觉右腿发凉，骨重难举。可见寒湿阴邪，已深侵入骨。正如《素问?长刺节论篇》所说：“病在骨，骨重不可举，骨髓酸痛，寒气至，名日骨痹”。
《伤寒论》云：“手足厥寒，脉细欲绝者，当归四逆汤主之”。本例

下肢冷痛，骨重难举， 麻木拘挛，参之舌质暗淡，脉象沉细，实为风寒中于血脉，血为邪伤，则营气阻滞，故病属厥阴寒证。郑重光曾指出；“ 手足厥寒，脉细欲绝，是厥阴伤寒之外证；当归四逆，是厥阴伤寒之表药也 ”(《中国医药汇海 ?伤寒论卷十六》)。这里不仅说明厥阴风寒中血脉而逆与四逆证不同，而且点出为何用当归四逆之理。今验之临床，初诊服药六剂，厥阴伤寒之外证遂除，血分之邪被逐，营气之阻滞即通，故下肢骨节冷痛掏挛诸证，迎刃而解。再进理中汤加味，培补先后二天，阴消阳长，从阴出阳，囚势利导而病获愈。

[按语]

临床常见之风、寒、湿、热诸痹， 《内经》等古籍，按其病变部位分为骨、筋、脉、肌、皮五痹；若进而发展至脏腑机能障碍，则更为严重。范老认为：纵有千变万化，究其病因，不外风寒湿热诸邪闭阻之部位不同。总其要，皆不离六经之传变规律。这正是辨认此类不同病变与循经用药之关键所在。

以本例厥阴证骨痹而论，其主要脉证亦不外“ 手足厥寒，脉细欲绝 ”。这本来是四逆辈之主证，为何仲景反用当归四逆汤主之?古今学者，对此颇多争议。因当归四逆汤，实为桂枝汤之变方。即桂枝本方易当归为君，去生姜，加细辛、通草组成(古之通草即今日之木通)。故争论之焦点，在于为何不用姜附。钱潢说：“ 方名日四逆，而方中并无姜附，不知何以挽回阳气，是以不能无疑也。 ”柯韵伯甚至认为：“ 此条证在里，当是四逆本方加当归，如茯苓四逆之例。若反用桂枝汤攻表误矣。 ”罗东逸等注家，又借厥阴主肝之说，对本方委曲顺解。提出“ 厥阴之脏，相火游行其间，经虽受寒，而脏不即寒 ”，故虽“ 见其手足厥冷，脉细欲绝者，不得遂认为寒，而用姜附也 ”。以上诸说皆不能令人信服。

喻嘉言《伤寒论尚论篇》，对当归四逆汤颇具卓见。他说：“ 四逆之名多矣。寒甚而厥，四逆汤；里寒外热，通脉四逆汤；热邪传里，四逆散。此用当归四逆汤何故‘ ?盖四逆之故不同，有因寒而逆，有因热而逆；此则因风寒中血脉而逆，乃当归为君之所以立也 ”。高学山著

《伤寒论尚论辨似》进而阐明桂枝汤之变法云：“至其桂枝之变法，神妙莫测，真有上下九天九地之幻。夫桂枝汤之号召阴阳，其义已见本汤下。乃忽焉加芍药，则使下引内入以畅脾阳。忽焉加芍药、而并加胶、饴，则使之内引上托，而建中气。忽焉加当归、增大枣，只以细辛、通草为使，则使之深入肝肾，而为温之润之之剂。长沙制方之意，可因此而悟其余矣!”这种观点比较符合仲景原意。范老在多年临床实践中，治愈不少厥阴证，常用当归四逆等厥阴诸方。此例仅为其中一个代表，它在理论和实践上，都涉及历代医学家提出过的一些问题，将有待于继续深入探讨。

68、厥阴证骨痹(坐骨神经痛)

王××，男，29岁。四川省某汽车队职工。

[病史]

1965年，在解放军某部因公负伤，左下肢股骨骨折，送××医疗队急救。整复后用石膏固定。因当时条件所限，石膏不干，曾采取烘烤措施。50余日出院，病未痊愈，又感风寒。患肢筋骨麻木疼痛，步行约100米则难以坚持。1966年，××医院诊为“坐骨神经痛”。1968年转业到地方。经多方治疗疼痛有缓解，遇天气变化，病又加剧。1971年6月来诊。

[诊治]

患者跛行，左下肢筋骨沿后侧呈放射性疼痛近六年，时有刺痛感。左足凉麻甚。舌质淡红稍暗，苔白根部微腻。询其数年来诊治情况，均按一般风湿论治，舒筋活血，散寒除湿等品所用颇多。范老反复思考：此例虽属风寒湿痹，但骨折后未痊愈又受风寒，其入侵部位已深入下肢筋骨，参之疼痛、麻木、肢凉等，病属厥阴骨痹。以当归四逆汤并五通散合为一方，养血通络，温经散寒，祛风除湿，活血化淤，并用酒醴以行药势。再以自制不二丹配合服之。

一、酒醴处方：

当归 桂枝 赤芍 木通 辽细辛 通草 淮通 血通 香通 干姜 牛膝 木瓜 川乌 羌活 独活 灵仙 草乌 川芎 川断 橘络 丝瓜络 伸筋草 防风 血竭 猴骨 土

鳖 红花 桃仁 三棱 莪术 海马 甘草
以上各10克共为粗末，用白酒五斤浸泡一周后，每晚睡前服10克。
二、丹药方：
生松香四份 血竭二份 硼砂二份 琥珀二份
共为细末，炼制成丹。每周服一次，每次3克。
遵上法服用约五月，病痊愈。1979年8月追访：七年来工作常年在外，东奔西跑，原患肢一直良好。
[按语]
本例属厥阴证骨痹。因患者原身体强壮，主要为暴力骨折后，寒湿乘隙深入筋骨，拖延日久，汤剂难达病所。故以酒醴之剂，以助药力，但仍嫌不足，另以不二丹通利关节，散淤除痹以助之。
古“ 醫 ”字本从酉(酒)，即由酒能治病演化而来。《素问?汤液醪醴论篇》云：“ 古圣人之作汤液醪醴者，以为备耳。 ”至今仍有“ 酒为百药之长 ”的说法。可见酒醴用之得法，常获著效。

69、厥阴证寒痹(坐骨神经痛)
郝×，男，70岁。四川某图书馆干部。
[病史]
曾有风湿性关节痛史。1973年冬，臀部及右腿冷痛难忍，不能坚持工作。经××医院检查，诊为“ 坐骨神经痛 ”。于1974年3月中旬来诊。
[初诊]
少腹及下肢发凉，膝关节以下微肿，行走困难，自右侧臀部沿腿至足抽掣冷痛。神疲，头昏，舌质淡红稍乌暗，苔白滑腻满布，脉细弱。证属厥阴寒痹筋痛。以当归四逆汤加味，养血活络，温经散寒为治。
处方：
当归12克 桂枝15克 白芍12克 辽细辛5克 木通12克 炙甘草6克 大枣20克 牛膝12克 木瓜12克 独活lO克
三剂
[辨证]
风寒入肝则筋痛，入肾则骨痛，入脾则肉痛。正如《内经》所说：“

寒痹之为病也，留而不去 ” 。又云 ： “ 病在筋，筋挛节痛，不可以行 ” 。可见本证显系邪入厥阴肝经，寒邪凝滞，气血受阻所致。又本例冷痛，自臀部痛引下肢，小腹及四肢末端发凉。此为厥阴证之血虚寒凝。气血运行不畅，不通则痛。 “ 欲续其脉，必益其血，欲益其血，必温其经 ” 。故不以四逆姜附回阳，而以当归四逆温经散寒，养血活络为治。

[二诊]

服上方，肢痛减轻。原方续服四剂。

[三诊]

患者可缓步而行，疼痛大减。仍守原方，加苏叶10克，入血分散寒凝；加防风10克，祛经络之风邪。再服十剂。

[四诊]

半月后，疼痛基本消失，神疲、头晕显著好转．滑腻苔减。唯下肢稍有轻微麻木感，时有微肿。寒邪虽衰，湿阻经络之象未全解，上方酌加除湿之品，以增强疗效。嘱其再服五剂。

处方：

当归12克 桂枝10克 白芍12克 木通12克 牛膝12克 茯苓15克 白术15克 苍术10克 苡仁15克 炙甘草6克

一月后病基本治愈，步履自如。

1979年7月15日追访：七年来病未复发，今年已七十七岁，身体尚好。

[按语]

以上厥阴骨痹、寒痹二例，虽病情、病位不尽相同，但主证皆因血虚寒郁所致，故皆以当归四逆汤主之。

《伤寒论》所载当归四逆汤，原主治 “ 手足厥寒，脉细欲绝者 ” 。其病机在于血虚寒滞。由于血被寒邪凝滞之程度和部位不同，则临床见证各异。后世医家对此多有发挥。范老在临证中，据《伤寒论》之学术思想及后贤经验，灵活运用于多种疾病，常获显著疗效。 其辨证要点，从主证看：一是少腹或腰、臀部以下发凉，或四肢末端冷；二是少腹、腰、臀以下疼痛，包括阴器、睾丸、下肢筋骨、关节疼痛，以

及痛经等。除以上主证外，还可能出现某些兼证。而脉象多细弱，舌质常暗红无泽，或有淤斑，苔灰白或腻或紧。以上诸证，不必悉具，皆可用之。

[后记]

医案整理小组的成员，除执笔者外，还有吴贵木、范开明、宁瑞盈和张秀琴同志。协助医案整理工作的，有程继贤、刘元灼、刘元堃等同志。

本书初稿承蒙印会河教授、戴佛延、邓明仲、郭子光、陈治恒、陈潮祖副教授以及洪梦浒讲师审阅，并提出宝贵意见，谨表示衷心地感谢!

This file was downloaded from Z-Library project

zlibrary

Your gateway to knowledge and culture. Accessible for everyone.

z-library.se singlelogin.re go-to-zlibrary.se single-login.ru

Official Telegram channel

Z-Access

https://wikipedia.org/wiki/Z-Library